



Buku Referensi

GIZI KOMUNITAS

Intervensi, Promosi Kesehatan, dan Ketahanan Pangan

Sri Musfiroh • Risna Nurlia • Yuni Retnowati
Zuraidah S • Herta Masthalina • Suhariyati

BUKU REFERENSI

GIZI KOMUNITAS: INTERVENSI, PROMOSI KESEHATAN, DAN KETAHANAN PANGAN

Penulis:

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

Dr. Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.K.M.

Yuni Retnowati, SST., Bdn., M.Keb.

Zuraidah S, SKM., MKM.

Dr Herta Masthalina, S.KM., M.PH.

Suhariyati, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi Gizi Komunitas: Intervensi, Promosi Kesehatan, Dan Ketahanan Pangan

Penulis:

Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.
Dr. Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.K.M.
Yuni Retnowati, SST., Bdn., M.Keb.
Zuraidah S, SKM., MKM.
Dr Herta Masthalina, S.KM., M.PH.
Suhariyati, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-86-4

Cetakan Pertama : Desember, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini yang berjudul “Gizi Komunitas: Intervensi, Promosi Kesehatan, dan Ketahanan Pangan” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam memperkaya literatur ilmu gizi masyarakat yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengembangan program gizi berbasis komunitas yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dalam beberapa dekade terakhir, persoalan gizi masyarakat telah berkembang menjadi isu multidimensional yang tidak hanya mencakup kekurangan gizi, tetapi juga kelebihan gizi, ketidakseimbangan asupan, serta kerentanan terhadap krisis pangan akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan bencana. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dengan status gizi masyarakat. Di sinilah pentingnya pendekatan gizi komunitas, yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi.

Buku referensi ini disusun untuk memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai intervensi gizi dan promosi kesehatan berbasis masyarakat, dengan penekanan pada upaya membangun ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan. Di dalamnya dibahas secara sistematis mulai dari konsep dasar perencanaan program gizi, analisis situasi dan identifikasi masalah, hingga strategi pemberdayaan kader dan pelibatan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Pembahasan disusun secara komprehensif agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembelajaran akademik, penelitian, maupun praktik lapangan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bacaan penting bagi mahasiswa, dosen, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, perencana program, serta pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pembangunan kesehatan dan gizi. Dengan gaya penulisan yang aplikatif dan berbasis bukti ilmiah, buku ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta mendorong munculnya inovasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian gizi di tingkat lokal.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun ilmiah dalam penyusunan buku ini—terutama para rekan sejawat akademisi, praktisi lapangan, mahasiswa, serta lembaga-lembaga yang berperan aktif dalam upaya peningkatan gizi masyarakat di Indonesia. Kehadiran buku ini tidak lepas dari dorongan, masukan, dan pengalaman nyata mereka

yang terus memperkaya pemahaman penulis tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem gizi yang tangguh dan adil.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Setiap kritik dan saran yang konstruktif akan menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, memperkuat kapasitas tenaga gizi dan kesehatan masyarakat, serta menjadi bagian kecil dari upaya besar bangsa dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berdaya, dan tahan terhadap krisis gizi.

Penulis

November, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I KERANGKA TEORITIS DAN PENDEKATAN PROGRAM	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Skala Masalah Gizi Komunitas	2
C. Peran Ahli Gizi Komunitas dalam Sistem Kesehatan Nasional.....	4
D. Landasan Teori Perilaku dan Perubahan Sosial dalam Gizi	6
E. Pendekatan Sistematis dalam Perencanaan Program Gizi Komunitas.....	11
F. Strategi Intervensi, Promosi Kesehatan, dan Advokasi Kebijakan.....	13
G. Penutup	15
Referensi.....	17

BAB II PENILAIAN DAN SURVEILANS GIZI KOMUNITAS	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Konsep Dasar Penilaian Gizi Komunitas	26
C. Metode Penilaian Status Gizi.....	29
D. Surveilans Gizi Komunitas.....	33
E. Analisis dan Interpretasi Data Gizi Komunitas	37
F. Kualitas, Etika, dan Validitas Data Gizi.....	40
G. Tantangan dan Inovasi dalam Surveilans Gizi Komunitas.....	43
H. Penutup	46
Referensi.....	48

BAB III PROMOSI KESEHATAN DAN PERUBAHAN PERILAKU	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan	54
C. Teori dan Model Perubahan Perilaku	58
D. Strategi dan Pendekatan Promosi Kesehatan	63
E. Metode dan Media Promosi Kesehatan	67
F. Perencanaan dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan	71
G. Tantangan dan Inovasi dalam Promosi Kesehatan.....	76
H. Peran Lintas Sektor dan Kolaborasi dalam Promosi Kesehatan	79
I. Penutup	83
Referensi.....	84

BAB IV KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN WILAYAH	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Ketahanan Pangan Rumah Tangga.....	90
C. Ketahanan Pangan Wilayah	95
D. Intervensi Gizi Komunitas Untuk Ketahanan Pangan	103
E. Studi Kasus Dan Implementasi	107
F. Penutup	108
Referensi.....	109
 BAB V PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBERDAYAAN KADER.....	117
A. Pendahuluan.....	117
B. Konsep Dasar Perencanaan Program Gizi Komunitas.....	118
C. Analisis Situasi dan Identifikasi Masalah Gizi.....	121
D. Perancangan Strategi dan Kegiatan Program	122
E. Pemberdayaan Kader Gizi dan Kesehatan	124
F. Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program	127
G. Penutup	130
Referensi.....	131
 BAB VI GIZI DALAM SITUASI DARURAT DAN KETAHANAN	
KOMUNITAS	133
A. Pendahuluan.....	133
B. Konsep Gizi dalam Situasi Darurat	135
C. Dampak Bencana terhadap Status Gizi dan Ketahanan Pangan	137
D. Intervensi Gizi dalam Situasi Darurat.....	139
E. Peran dan Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Gizi.....	141
F. Strategi Pembangunan Ketahanan Komunitas	143
G. Penutup	145
Referensi.....	146
 PROFIL PENULIS	149

BAB I

KERANGKA TEORITIS DAN PENDEKATAN PROGRAM

A. Pendahuluan

1. Evolusi Disiplin Ilmu Gizi Komunitas

Gizi sebagai disiplin ilmu awalnya berkembang dalam dua cabang utama, yaitu gizi klinik dan kesehatan masyarakat. Gizi klinik menitikberatkan pada perawatan individual, misalnya terapi diet pada pasien dengan penyakit metabolik seperti diabetes atau hipertensi. Sementara itu, kesehatan masyarakat lebih berfokus pada intervensi berskala besar, seperti program imunisasi, penyediaan air bersih, atau sanitasi lingkungan. Dari titik temu kedua cabang inilah, lahir disiplin gizi komunitas, yang berorientasi pada pencegahan masalah gizi serta promosi kesehatan dengan basis kelompok masyarakat.

Seiring perkembangan global, isu gizi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai permasalahan klinis, melainkan sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. *World Health Organization (WHO)* menegaskan bahwa gizi komunitas merupakan pilar penting dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan menghapus kelaparan (*Zero Hunger*) dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (WHO, 2020).

2. Definisi Operasional Gizi Komunitas

Secara operasional, gizi komunitas dapat didefinisikan sebagai ilmu dan praktik yang mempelajari serta mengintervensi masalah gizi pada kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan status gizi, mencegah penyakit terkait gizi, dan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah pencegahan alih-alih kuratif, serta penggunaan pendekatan multi-level, mulai dari edukasi individu hingga advokasi kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, gizi komunitas memiliki peran strategis karena masalah gizi di Indonesia bersifat ganda: kekurangan gizi masih tinggi, sementara kasus kelebihan gizi juga meningkat. Oleh karena itu, intervensi gizi komunitas diarahkan pada pencegahan *triple burden of malnutrition* yang meliputi stunting, defisiensi mikronutrien, dan obesitas (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

3. Perbedaan Gizi Individu (Klinis) dan Gizi Komunitas

Perbedaan mendasar antara gizi klinis dan gizi komunitas dapat dilihat pada fokus, metode, dan target intervensi.

- a. Gizi klinis berorientasi pada individu: diagnosis gizi, terapi diet personal, serta monitoring kondisi pasien. Contoh: diet rendah garam pada pasien hipertensi.
- b. Gizi komunitas berorientasi pada populasi: analisis status gizi kelompok, program pencegahan, serta promosi kesehatan berbasis komunitas. Contoh: kampanye konsumsi sayur dan buah di sekolah dasar.

Gizi klinis menekankan aspek kuratif dan rehabilitatif, sedangkan gizi komunitas menekankan aspek preventif dan promotif (Boyle & Holben, 2018). Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam sistem kesehatan nasional, di mana gizi klinis menangani individu yang sudah sakit, sementara gizi komunitas berupaya mencegah penyakit tersebut terjadi pada tingkat masyarakat.

B. Ruang Lingkup dan Skala Masalah Gizi Komunitas

1. Spektrum Masalah Gizi: Kekurangan hingga Kelebihan Gizi

Masalah gizi pada komunitas memiliki spektrum yang luas, mulai dari kekurangan gizi (*undernutrition*), kelebihan gizi (*overnutrition*), hingga defisiensi mikronutrien.

Kekurangan gizi, terutama stunting (tinggi badan rendah menurut umur), masih menjadi masalah serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Stunting berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, produktivitas ekonomi, serta risiko penyakit kronis di masa dewasa (De Onis & Branca, 2016). Selain stunting, wasting (berat badan rendah menurut tinggi badan) mencerminkan kondisi akut kekurangan gizi yang sering terjadi pada anak-anak akibat infeksi atau krisis pangan.

Di sisi lain, kelebihan gizi juga semakin meningkat. Obesitas tidak lagi menjadi masalah di negara maju saja, melainkan juga di negara berpendapatan menengah seperti Indonesia. Data WHO (2021) menunjukkan prevalensi obesitas global meningkat tiga kali lipat sejak 1975. Obesitas pada orang dewasa berhubungan erat dengan diabetes melitus tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular, serta beberapa jenis kanker.

Selain makronutrien, defisiensi mikronutrien seperti anemia defisiensi zat besi, defisiensi vitamin A, dan defisiensi yodium masih banyak dijumpai di berbagai komunitas. UNICEF (2020) menekankan bahwa defisiensi mikronutrien disebut sebagai "*hidden hunger*" karena gejalanya tidak selalu tampak, tetapi

memiliki dampak serius terhadap imunitas, perkembangan anak, serta mortalitas ibu dan bayi.

Dengan demikian, spektrum masalah gizi ini menuntut intervensi yang komprehensif dan kontekstual, mengingat setiap komunitas memiliki tantangan yang berbeda-beda.

2. Konsep Triple Burden of Malnutrition

Istilah *triple burden of malnutrition* mengacu pada tiga masalah gizi yang terjadi secara bersamaan: (1) kekurangan gizi, (2) defisiensi mikronutrien, dan (3) kelebihan gizi. Fenomena ini banyak terjadi di negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, yang tengah mengalami transisi ekonomi dan sosial.

Popkin et al. (2020) menyebutkan bahwa transisi gizi menyebabkan konsumsi masyarakat bergeser dari makanan tradisional yang relatif sehat ke makanan ultra-proses dengan kandungan tinggi gula, garam, dan lemak. Akibatnya, dalam satu rumah tangga sering dijumpai balita stunting, remaja anemia, dan orang dewasa obesitas sekaligus. Kondisi ini memperumit intervensi gizi, karena strategi tidak bisa hanya fokus pada satu masalah, tetapi harus menyasar semua bentuk malnutrisi.

Laporan *Global Nutrition Report* (2021) juga menegaskan bahwa triple burden ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menurunkan produktivitas tenaga kerja, memperbesar beban pembiayaan kesehatan, dan menghambat pembangunan nasional.

3. Determinan Sosial Kesehatan yang Memengaruhi Status Gizi Komunitas

Status gizi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh determinants sosial kesehatan (*social determinants of health*). Menurut WHO (2010), determinan sosial adalah kondisi di mana seseorang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, yang dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan, pendapatan, dan sumber daya. Beberapa determinan sosial utama yang memengaruhi status gizi komunitas antara lain:

- a. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, berhubungan erat dengan pengetahuan tentang gizi dan praktik pemberian makan anak. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan rendah lebih berisiko memiliki anak stunting (Titaley et al., 2019).
- b. Ekonomi: Pendapatan rumah tangga memengaruhi daya beli pangan sehat. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah lebih sering mengonsumsi makanan murah berkalori tinggi tetapi miskin zat gizi mikro (Darmawan et al., 2020).
- c. Lingkungan: Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan berpengaruh terhadap status gizi. Lingkungan yang buruk meningkatkan risiko infeksi, yang pada akhirnya memperburuk status gizi anak.

d. Budaya dan Kebiasaan: Preferensi makanan, tabu makanan, dan norma sosial juga memengaruhi konsumsi gizi. Misalnya, di beberapa daerah masih ada pantangan protein hewani bagi ibu hamil, yang dapat meningkatkan risiko anemia (Chakrabarti et al., 2019).

Dengan demikian, masalah gizi komunitas tidak bisa dipandang hanya dari aspek medis, tetapi perlu dilihat sebagai masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kompleksitas masalah gizi menuntut intervensi berbasis komunitas yang bersifat multi-sektoral. Hal ini karena gizi bukan hanya urusan sektor kesehatan, melainkan juga terkait dengan pertanian (produksi pangan), pendidikan (literasi gizi), dan sektor sosial-ekonomi (pengentasan kemiskinan).

Studi oleh Bhutta et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi gizi berbasis masyarakat seperti suplementasi zat gizi mikro, promosi ASI eksklusif, fortifikasi pangan, dan edukasi gizi dapat menurunkan angka stunting hingga 20% bila dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi. Oleh karena itu, ruang lingkup gizi komunitas mencakup tidak hanya aspek medis, tetapi juga advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem pangan dan ketahanan gizi secara menyeluruh

C. Peran Ahli Gizi Komunitas dalam Sistem Kesehatan Nasional

Ahli gizi komunitas memegang peran strategis dalam sistem kesehatan nasional karena mereka menjembatani antara ilmu gizi dan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks pencegahan, promosi, dan advokasi gizi. Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi telah mengidentifikasi berbagai fungsi dan tantangan yang dihadapi oleh ahli gizi di lingkup komunitas. Pada bagian ini, kita bahas peran-peran utama ahli gizi komunitas sebagai perencana program, pelaksana, edukator, advokat, serta peneliti; serta kolaborasi interdisipliner yang diperlukan dengan tenaga kesehatan lain dan sektor non-kesehatan.

1. Fungsi Ahli Gizi Komunitas

a. Perencana Program Gizi

Dalam kerangka pembangunan program kesehatan masyarakat, ahli gizi komunitas sering bertindak sebagai perancang intervensi gizi berdasarkan *community needs assessment*. Peran ini mencakup pemilihan strategi intervensi (misalnya suplementasi, fortifikasi, edukasi gizi, atau perbaikan lingkungan pangan) yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Di Indonesia, pedoman Kementerian Kesehatan menyebut bahwa ahli gizi berperan sebagai pengolah data, penyuluh, sekaligus konsultan dalam perencanaan intervensi (Kemenkes RI, n.d.).

Sebagai contoh, Syahputra dan Darmawan (2023) menyebutkan bahwa ahli gizi bertanggung jawab merancang layanan gizi masyarakat, menyusun program pencegahan malnutrisi, serta membuat menu institusional yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

b. Pelaksana Intervensi Lapangan

Setelah rancangan dibuat, ahli gizi komunitas terlibat dalam implementasi program di tingkat lapangan. Ini meliputi penyuluhan gizi, konseling gizi individu/kelompok, pengawasan program PMT, hingga pelaksanaan fortifikasi lokal. Dalam konteks pandemi, peran ini berkembang melalui konsultasi daring dan edukasi berbasis aplikasi mobile agar jangkauan intervensi tetap luas (Sari et al., 2022).

c. Edukator dan Penyuluh Gizi

Salah satu fungsi inti ahli gizi komunitas adalah edukasi: meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat tentang gizi sehat, pengolahan pangan lokal, serta kemampuan memilih pangan bergizi. Edukasi bukan sekadar transfer informasi, tetapi pembentukan keterampilan praktis seperti membaca label gizi atau memasak sehat (Syahputra & Darmawan, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan intensif mampu meningkatkan pemahaman keluarga dalam pencegahan stunting (Sari et al., 2022).

d. Advokat dan Penggerak Kebijakan

Ahli gizi komunitas juga berperan sebagai advokat kebijakan, mendorong regulasi kantin sehat sekolah, kebijakan fortifikasi, hingga penganggaran dana desa untuk gizi. Keterlibatan ahli gizi dalam forum lintas sektor terbukti memperkuat arah kebijakan pangan dan gizi di tingkat lokal (Febriyanti et al., 2025).

e. Peneliti dan Evaluator

Program Selain implementasi, ahli gizi komunitas berperan sebagai peneliti dan evaluator. Mereka melakukan evaluasi proses, dampak, maupun outcome program gizi. Fitriani et al. (2021) dalam studi di Halmahera Barat menemukan bahwa kolaborasi perawat dan ahli gizi dalam monitoring status gizi anak melalui pengukuran antropometri meningkatkan kualitas pelayanan gizi balita.

2. Kolaborasi Interdisipliner dan Tantangan

a. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain

Kolaborasi antarprofesi (dokter, perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi) merupakan kunci dalam penanganan gizi balita. Studi Fitriani et al. (2021) menunjukkan bahwa sinergi antara perawat dan ahli gizi dalam pemeriksaan antropometri,

suplementasi, dan konseling gizi terbukti memperbaiki intervensi gizi di tingkat puskesmas.

b. Kolaborasi dengan Sektor Non-Kesehatan

Masalah gizi tidak hanya persoalan medis. Ahli gizi bekerja sama dengan sektor pertanian (diversifikasi pangan lokal), pendidikan (kantin sekolah sehat), dan sosial (pengentasan kemiskinan). Kajian Febriyanti et al. (2025) menekankan bahwa *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat merupakan kunci efektivitas intervensi stunting di Cimahi.

c. Tantangan dalam Praktik Kolaborasi

Tantangan yang muncul antara lain keterbatasan jumlah tenaga gizi, perbedaan paradigma antarprofesi, serta ketergantungan pada dukungan kebijakan. Alfiana et al. (2023) menyoroti bahwa keterbatasan kapasitas dan beban kerja tinggi seringkali mengurangi efektivitas peran ahli gizi di lapangan.

D. Landasan Teori Perilaku dan Perubahan Sosial dalam Gizi

Intervensi gizi komunitas tidak bisa dilepaskan dari teori perilaku dan perubahan sosial. Hal ini karena perilaku makan seseorang maupun masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Untuk itu, pendekatan teoretis diperlukan agar program gizi lebih tepat sasaran. Beberapa teori utama yang banyak digunakan dalam program gizi adalah *Health Belief Model* (HBM), *Transtheoretical Model* (TTM), *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Social Cognitive Theory* (SCT), dan *Socio-Ecological Model* (SEM).

Tabel 1.1 Landasan Teori Perilaku dan Perubahan Sosial dalam Gizi

Teori	Konsep Utama	Fokus Dalam Program Gizi	Contoh Aplikasi Penelitian Di Indonesia
<i>Health Belief Model</i> (HBM)	- <i>Perceived susceptibility</i> (kerentanan) - <i>Perceived severity</i> (keseriusan penyakit) - <i>Perceived benefits</i> (manfaat) - <i>Perceived barriers</i> (hambatan) - <i>Cues to action</i>	Menekankan pentingnya persepsi individu terhadap risiko penyakit dan manfaat perubahan perilaku makan	- Edukasi berbasis HBM meningkatkan niat ibu rumah tangga di Yogyakarta untuk mengurangi penggunaan minyak goreng berulang (Setyaningsih & Widyasari, 2020).

	(pemicu) - <i>Self-efficacy</i> (keyakinan diri)		- Penerapan HBM mendorong remaja meningkatkan konsumsi sayur dan buah (Yanti & Hartini, 2019).
<i>Transtheoretical Model</i> (TTM) / <i>Stages of Change</i>	Lima tahap perubahan: 1. <i>Pre-contemplation</i> 2. <i>Contemplation</i> 3. <i>Preparation</i> 4. <i>Action</i> 5. <i>Maintenance</i>	Mengidentifikasi kesiapan individu untuk berubah sehingga intervensi bisa disesuaikan dengan tahapannya	Intervensi gizi berbasis TTM di Surabaya efektif menurunkan konsumsi energi harian penderita obesitas dengan menyesuaikan strategi sesuai tahap kesiapan (Rahmawati & Lestari, 2021).
<i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	- <i>Attitude toward behavior</i> (sikap) - <i>Subjective norm</i> (norma subjektif) - <i>Perceived behavioral control</i> (kontrol perilaku) - Intensi sebagai prediktor utama	Menjelaskan bagaimana sikap, norma, dan kontrol diri memengaruhi niat makan sehat	- Norma keluarga & dukungan teman sebaya di Jakarta berperan penting dalam niat mahasiswa mengonsumsi makanan sehat (Putri & Nurdin, 2020). - Kontrol diri remaja Bandung terhadap fast food berhubungan signifikan dengan perilaku makan sehat (Wulandari & Hidayat, 2022).
<i>Social Cognitive Theory</i> (SCT)	- <i>Reciprocal determinism</i> (hubungan timbal balik individu–perilaku–	Menekankan interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan dalam	- Peningkatan self-efficacy ibu di Semarang terbukti meningkatkan kualitas makanan

	lingkungan) - <i>Self-efficacy</i> - <i>Observational learning</i> (belajar dari teladan)	pembentukan perilaku makan	keluarga (Astuti et al., 2021). - Video kampanye memasak sehat meningkatkan keterampilan memasak mahasiswa (Rahayu et al., 2019).
<i>Socio-Ecological Model</i> (SEM)	Pendekatan multi-level: 1. Individu 2. Interpersonal 3. Organisasi 4. Komunitas 5. Kebijakan	Menjelaskan bahwa perilaku gizi dipengaruhi oleh berbagai level faktor, bukan hanya individu	Program “Kantin Sehat” di Bogor yang melibatkan siswa, guru, pedagang, dan dinas kesehatan meningkatkan konsumsi buah siswa karena menasar multi-level intervensi (Nuryani et al., 2021).

1. Teori Perubahan Perilaku di Tingkat Individu dan Interpersonal

a. *Health Belief Model* (HBM)

Health Belief Model (HBM) pertama kali dikembangkan oleh Rosenstock pada tahun 1950-an dan kemudian diperluas oleh Becker serta Strecher (Rosenstock et al., 1988). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa seseorang akan melakukan tindakan kesehatan jika ia merasa dirinya rentan (*perceived susceptibility*) terhadap suatu penyakit, menganggap penyakit tersebut serius (*perceived severity*), yakin bahwa tindakan yang dilakukan membawa manfaat (*perceived benefits*), dan menilai hambatan (*perceived barriers*) tidak lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, faktor pemicu (*cues to action*) dan keyakinan diri (*self-efficacy*) juga menentukan apakah perilaku tersebut dijalankan.

Dalam konteks gizi, HBM banyak diaplikasikan untuk meningkatkan kesadaran risiko penyakit terkait pola makan. Misalnya, penelitian di Yogyakarta menemukan bahwa edukasi berbasis HBM berhasil meningkatkan niat ibu rumah tangga dalam mengurangi konsumsi minyak goreng berulang, karena mereka menyadari risiko kanker dan penyakit jantung (Setyaningsih & Widayarsi, 2020). Studi lain menunjukkan penerapan HBM efektif dalam

mendorong konsumsi sayur dan buah pada remaja, dengan menekankan manfaat jangka panjang bagi kesehatan (Yanti & Hartini, 2019).

b. *Transtheoretical Model (TTM) atau Stages of Change*

Transtheoretical Model (TTM) yang dikembangkan oleh Prochaska dan Velicer (1997) menjelaskan bahwa perubahan perilaku merupakan proses bertahap yang terdiri dari lima fase, yaitu pra-kontemplasi (*pre-contemplation*), kontemplasi (*contemplation*), persiapan (*preparation*), aksi (*action*), dan pemeliharaan (*maintenance*). Setiap individu berada pada tahap yang berbeda, sehingga strategi intervensi kesehatan perlu disesuaikan dengan kesiapan mereka.

TTM menjelaskan perubahan perilaku sebagai proses bertahap: pra-kontemplasi (belum berniat berubah), kontemplasi (mulai mempertimbangkan), persiapan (siap untuk bertindak), aksi (melakukan perubahan), dan pemeliharaan (mempertahankan perilaku) (Prochaska & Velicer, 1997). Dalam program gizi, TTM bermanfaat untuk mengidentifikasi kesiapan individu agar intervensi lebih tepat sasaran. Misalnya, penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa intervensi gizi berbasis TTM pada penderita obesitas menghasilkan perubahan signifikan pada konsumsi energi harian, karena strategi disesuaikan dengan tahap kesiapan mereka (Rahmawati & Lestari, 2021).

c. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Ajzen (1991) sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB menegaskan bahwa intensi merupakan prediktor utama perilaku. Intensi itu sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

TPB berfokus pada intensi sebagai prediktor utama perilaku. Intensi dipengaruhi oleh tiga hal: sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol diri (*perceived behavioral control*). Dalam konteks gizi, TPB digunakan untuk menganalisis perilaku makan sehat. Penelitian di Jakarta menemukan bahwa norma keluarga dan dukungan teman sebaya berperan penting dalam membentuk niat mahasiswa untuk mengonsumsi makanan sehat di kantin kampus (Putri & Nurdin, 2020). Studi lain di Bandung menunjukkan bahwa kontrol diri terhadap godaan makanan cepat saji berhubungan signifikan dengan perilaku makan sehat remaja (Wulandari & Hidayat, 2022).

2. Teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory – SCT)

Social Cognitive Theory (SCT) dikembangkan oleh Albert Bandura (1986) dengan konsep kunci *reciprocal determinism*, yakni adanya interaksi timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan. Dalam SCT, *self-efficacy* atau keyakinan individu bahwa ia mampu melakukan suatu tindakan, merupakan determinan utama dari perilaku. Selain itu, *observational learning* atau belajar dari contoh orang lain juga menjadi faktor penting.

Salah satu konsep kunci dalam SCT adalah *self-efficacy* (keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan suatu perilaku). Studi di Semarang menunjukkan bahwa peningkatan *self-efficacy* ibu dalam praktik pemberian makan anak balita berhubungan signifikan dengan peningkatan kualitas makanan keluarga (Astuti et al., 2021). Selain itu, *observational learning* atau belajar dari teladan juga penting; misalnya, kampanye video memasak sehat terbukti meningkatkan keterampilan memasak mahasiswa (Rahayu et al., 2019).

3. Model Ekologi Sosial (Socio-Ecological Model – SEM)

Socio-Ecological Model (SEM) diperkenalkan oleh Bronfenbrenner (1979) dan kemudian banyak diadaptasi dalam bidang kesehatan masyarakat. Model ini menekankan bahwa perilaku kesehatan, termasuk gizi, dipengaruhi oleh faktor multi-level: individu (pengetahuan, sikap, keterampilan), interpersonal (keluarga, teman sebaya, jaringan sosial), organisasi (aturan sekolah atau tempat kerja), komunitas (akses terhadap pangan sehat), serta kebijakan (regulasi iklan, pajak pangan, dan program pemerintah).

SEM memberikan kerangka komprehensif untuk memahami pengaruh multi-level terhadap perilaku gizi, yaitu:

- a. Individu: pengetahuan, sikap, keterampilan (misalnya keterampilan membaca label gizi).
- b. Interpersonal: pengaruh keluarga, teman, jaringan sosial.
- c. Organisasi: aturan di sekolah atau tempat kerja, misalnya kebijakan kantin sehat.
- d. Komunitas: akses fisik ke pangan sehat, pasar tradisional, kebun komunitas.
- e. Kebijakan: regulasi iklan makanan, subsidi pangan sehat, pajak minuman bergula.

Menurut Sallis et al. (2015), intervensi gizi yang menyasar banyak level sekaligus lebih efektif dibandingkan hanya pada level individu. Misalnya, program “Kantin Sehat” di sekolah menengah di Bogor yang melibatkan siswa, guru, pedagang kantin, dan dinas kesehatan berhasil meningkatkan konsumsi buah pada siswa karena menyasar berbagai level intervensi (Nuryani et al., 2021).

Mengacu pada uraian di atas, jelas bahwa teori perilaku menyediakan dasar penting untuk merancang intervensi gizi yang tepat. Tanpa teori, program gizi sering kali hanya berfokus pada transfer informasi, padahal perubahan perilaku membutuhkan pemahaman mendalam mengenai motivasi, norma sosial, serta lingkungan yang mendukung. Dengan mengintegrasikan teori HBM, TTM, TPB, SCT, dan SEM, intervensi gizi dapat dirancang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

E. Pendekatan Sistematis dalam Perencanaan Program Gizi Komunitas

Perencanaan program gizi komunitas memerlukan pendekatan sistematis agar intervensi yang dirancang sesuai kebutuhan, realistis, dan memiliki dampak berkelanjutan. Proses perencanaan tidak hanya sekadar menyusun kegiatan, tetapi juga mencakup penilaian kebutuhan komunitas, pemilihan model perencanaan, penyusunan tujuan yang terukur, hingga evaluasi. Beberapa kerangka kerja yang sering digunakan dalam perencanaan program gizi adalah *Community Needs Assessment*, Model Perencanaan Promosi Kesehatan, Model *PRECEDE-PROCEED*, Logic Model, serta prinsip SMART dalam penetapan tujuan.

1. Penilaian Kebutuhan Komunitas (*Community Needs Assessment*)

Langkah awal perencanaan program adalah melakukan penilaian kebutuhan komunitas. Penilaian ini penting untuk:

- a. Mengidentifikasi masalah gizi yang paling mendesak,
- b. Memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta
- c. Menentukan prioritas intervensi (issel & wells, 2017).

Metode pengumpulan data dalam penilaian kebutuhan terdiri atas:

- a. Data kuantitatif: survei konsumsi pangan, pengukuran antropometri (BB/U, TB/U, IMT/U), dan data biokimia (Hb, serum ferritin). Contohnya, *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)* rutin dilakukan di Indonesia untuk memotret status gizi nasional (Kemenkes RI, 2022).
- b. Data kualitatif: *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, serta observasi partisipatoris. Studi di Lombok menunjukkan bahwa kombinasi data kuantitatif dan FGD membantu mengidentifikasi faktor budaya dalam pemberian makanan bayi, sehingga intervensi lebih kontekstual (Sutrisna et al., 2021).

Dengan pendekatan partisipatif ini, program gizi lebih diterima masyarakat karena disusun berdasarkan kebutuhan nyata, bukan asumsi dari luar.

2. Model Perencanaan Program Promosi Kesehatan

Dalam merancang intervensi gizi, digunakan model perencanaan promosi kesehatan yang sistematis. Green & Kreuter (2005) menekankan pentingnya

pendekatan multidimensi yang tidak hanya melihat perilaku individu, tetapi juga lingkungan. Oleh karena itu, model perencanaan dipilih agar mampu menjelaskan hubungan antara determinan perilaku dan strategi intervensi.

3. Model PRECEDE-PROCEED

Salah satu model yang paling sering digunakan adalah PRECEDE-PROCEED, yang terdiri atas 8 fase:

- a. Diagnosis sosial: mengidentifikasi masalah kesehatan dan gizi yang dianggap penting oleh masyarakat.
- b. Diagnosis epidemiologi: menentukan masalah gizi secara spesifik dengan indikator epidemiologis (misalnya prevalensi stunting).
- c. Diagnosis perilaku dan lingkungan: menganalisis faktor perilaku (misalnya pola makan) dan lingkungan (akses pangan sehat).
- d. Diagnosis edukasi dan ekologi: mengidentifikasi faktor predisposisi (pengetahuan, sikap), faktor pendukung (ketersediaan fasilitas), dan faktor penguat (dukungan keluarga).
- e. Diagnosis administratif dan kebijakan: menilai kapasitas sumber daya, kebijakan, dan dukungan institusi.
- f. Implementasi: pelaksanaan intervensi.
- g. Evaluasi proses: memantau apakah program berjalan sesuai rencana.
- h. Evaluasi dampak dan hasil: menilai perubahan perilaku, status gizi, dan *outcome* kesehatan (Green & Kreuter, 2005).

Contoh penerapan: sebuah studi di Jawa Tengah menggunakan PRECEDE-PROCEED dalam program pencegahan anemia remaja putri, dengan hasil signifikan berupa peningkatan konsumsi tablet tambah darah karena strategi disesuaikan dengan diagnosis perilaku dan dukungan lingkungan (Handayani et al., 2020).

4. Logic Model

Logic Model adalah kerangka visual untuk menggambarkan hubungan antara sumber daya (inputs), kegiatan (activities), keluaran jangka pendek (outputs), dan hasil jangka panjang (outcomes & impacts) (W.K. Kellogg Foundation, 2004).

- a. Inputs: tenaga gizi, dana, sarana edukasi.
- b. Activities: penyuluhan gizi, pemberian PMT, pelatihan kader.
- c. Outputs: jumlah peserta penyuluhan, jumlah paket PMT yang dibagikan.
- d. Outcomes: peningkatan pengetahuan gizi, perubahan pola makan sehat.
- e. Impacts: penurunan prevalensi stunting, peningkatan produktivitas masyarakat.

Logic model membantu pengelola program dalam mengkomunikasikan alur program secara jelas kepada pemangku kepentingan, sekaligus memudahkan evaluasi.

5. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang SMART

Agar intervensi terukur, tujuan program gizi harus memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).

- a. Contoh tujuan SMART: "Meningkatkan konsumsi buah minimal 2 porsi per hari pada 70% siswa SMP di Kecamatan X dalam 6 bulan."
- b. Contoh tujuan tidak SMART: "Meningkatkan kebiasaan makan sehat pada remaja."

Dengan prinsip SMART, tujuan program lebih jelas, dapat diukur, dan realistis. Studi evaluasi program gizi sekolah di Bandung menunjukkan bahwa penggunaan tujuan SMART membantu monitoring capaian intervensi, sehingga tindak lanjut bisa dilakukan tepat waktu (Wulandari et al., 2021).

6. Integrasi Teori dan Praktik dalam Perencanaan

Penerapan langkah-langkah sistematis ini harus didukung teori perilaku. Misalnya, PRECEDE-PROCEED bisa dipadukan dengan Health Belief Model untuk memahami faktor motivasi individu, sementara Logic Model bisa dipadukan dengan Socio-Ecological Model untuk memastikan intervensi menjangkau multi-level. Dengan demikian, perencanaan program gizi tidak hanya teknis, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat.

F. Strategi Intervensi, Promosi Kesehatan, dan Advokasi Kebijakan

Strategi intervensi dalam gizi komunitas mencakup berbagai pendekatan, mulai dari edukasi gizi, perubahan lingkungan, hingga advokasi kebijakan. Prinsip utama dalam strategi ini adalah pendekatan multi-level, di mana intervensi tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga, institusi, komunitas, dan pemerintah. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan dan efektivitas program gizi dalam jangka panjang (Swinburn et al., 2019).

1. Strategi Promosi Kesehatan Gizi

- a. Edukasi Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat

Edukasi gizi merupakan salah satu strategi yang paling umum dilakukan dalam intervensi gizi komunitas. Namun, edukasi modern tidak berhenti pada transfer informasi, melainkan juga membangun keterampilan praktis, seperti kemampuan membaca label gizi, memasak sehat, serta mengelola konsumsi pangan rumah tangga (Nutbeam, 2019).

Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa program edukasi gizi berbasis sekolah yang melibatkan praktik langsung memasak sehat meningkatkan

keterampilan siswa dalam memilih makanan bergizi (Sari et al., 2020). Program serupa di Lombok yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga berhasil meningkatkan variasi pangan keluarga karena mereka tidak hanya mendapat materi, tetapi juga praktik memasak bersama (Sutrisna et al., 2021).

b. Pemasaran Sosial (*Social Marketing*)

Social marketing menggunakan prinsip pemasaran (4P: *Product, Price, Place, Promotion*) untuk mempromosikan perilaku sehat. Misalnya, kampanye "Isi Piringku" dari Kementerian Kesehatan menggunakan media cetak, digital, dan sosial untuk mempromosikan pola makan seimbang. Studi di Jakarta menemukan bahwa penerapan prinsip *social marketing* meningkatkan efektivitas kampanye gizi pada remaja karena pesan dikemas menarik dan sesuai tren media sosial (Pradana & Rachmah, 2021).

c. Mobilisasi Komunitas

Mobilisasi komunitas adalah proses melibatkan masyarakat secara aktif dalam merancang dan melaksanakan program gizi. Keterlibatan ini penting karena meningkatkan rasa memiliki (*ownership*) terhadap program, sehingga keberlanjutan lebih terjamin. Sebagai contoh, program *Kampung Gizi* di Jawa Barat melibatkan kader posyandu, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu PKK dalam kegiatan kebun gizi bersama. Hasilnya, partisipasi masyarakat meningkat dan konsumsi sayur harian juga bertambah (Handayani & Fitri, 2020).

2. Intervensi Perubahan Lingkungan dan Kebijakan

Selain promosi individu, perubahan lingkungan dan kebijakan diperlukan untuk menciptakan supportive environment. WHO (2016) menegaskan bahwa perilaku gizi sehat lebih mudah tercapai bila lingkungan menyediakan akses yang mendukung. Contoh intervensi:

- a. Di sekolah: penerapan standar kantin sehat, program sarapan bersama, dan pembatasan penjualan jajanan tinggi gula. Studi di Bogor membuktikan bahwa program kantin sehat meningkatkan konsumsi buah pada siswa SMP (Nuryani et al., 2021).
- b. Di tempat kerja: penyediaan opsi makanan sehat di kantin perusahaan dan promosi aktivitas fisik. Penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa intervensi gizi di lingkungan kerja menurunkan konsumsi minuman manis karyawan (Wulandari et al., 2020).
- c. Di komunitas: pengembangan kebun gizi komunitas, penyediaan pasar pangan sehat, serta advokasi jalur sepeda untuk mendorong aktivitas fisik. Program kebun gizi di Banyumas terbukti meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin (Rahmawati & Widodo, 2021).

3. Advokasi untuk Ketahanan Pangan dan Gizi

Ahli gizi tidak hanya berperan sebagai edukator, tetapi juga advokat kebijakan publik. Advokasi diperlukan untuk mendorong kebijakan yang mendukung lingkungan pangan sehat dan mengurangi paparan pangan tidak sehat. Beberapa contoh advokasi penting dalam konteks Indonesia:

- a. Regulasi iklan makanan tidak sehat untuk anak. Penelitian menunjukkan bahwa paparan iklan makanan cepat saji sangat berpengaruh terhadap konsumsi anak-anak (Rachmi et al., 2017). Advokasi kebijakan pembatasan iklan makanan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) menjadi penting.
- b. Kebijakan fortifikasi pangan. Misalnya, fortifikasi tepung terigu dengan zat besi yang diwajibkan pemerintah Indonesia sejak 2001 terbukti menurunkan prevalensi anemia (Darmawan et al., 2020).
- c. Dukungan terhadap petani lokal. Dengan menghubungkan kebijakan gizi pada sektor pertanian, ahli gizi dapat berperan dalam memastikan ketersediaan pangan lokal yang sehat dan berkelanjutan (FAO, 2019).

Advokasi yang berhasil memerlukan keterlibatan multi-pihak: pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Ahli gizi dapat menggunakan data riset sebagai dasar argumen dalam advokasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti (*evidence-based policy*).

4. Integrasi Strategi Multi-Level

Strategi promosi kesehatan, intervensi lingkungan, dan advokasi kebijakan tidak bisa berdiri sendiri. Intervensi paling efektif adalah yang menasar beberapa level secara simultan. Misalnya, program pencegahan obesitas remaja akan lebih efektif jika meliputi:

- a. Edukasi gizi di sekolah (individu),
- b. Keterlibatan keluarga dalam pola makan sehat (interpersonal),
- c. Penyediaan kantin sehat (organisasi),
- d. Pengembangan ruang publik untuk olahraga (komunitas),
- e. Regulasi iklan makanan cepat saji (kebijakan).

Pendekatan integratif ini terbukti efektif dalam studi komparatif program gizi anak di Asia Tenggara, di mana intervensi multi-level menurunkan prevalensi obesitas lebih signifikan dibanding intervensi tunggal (Swinburn et al., 2019).

G. Penutup

1. Ringkuman Keterkaitan Teori, Perencanaan, dan Intervensi

Program gizi komunitas bukan sekadar pelaksanaan kegiatan teknis, melainkan hasil dari suatu proses yang terintegrasi. Teori perilaku seperti *Health Belief Model*, *Transtheoretical Model*, *Theory of Planned Behavior*, *Social*

Cognitive Theory, dan *Socio-Ecological Model* menjadi pemandu konseptual dalam memahami faktor yang memengaruhi perilaku gizi. Perencanaan sistematis melalui *community needs assessment*, model *PRECEDE-PROCEED*, logic model, hingga perumusan tujuan SMART memastikan bahwa intervensi gizi disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan dapat diukur hasilnya. Strategi intervensi kemudian dilaksanakan dalam bentuk edukasi, pemasaran sosial, mobilisasi komunitas, perubahan lingkungan, hingga advokasi kebijakan. Integrasi teori, perencanaan, dan intervensi ini menegaskan bahwa gizi komunitas merupakan bidang multidisipliner yang berakar pada ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial, hingga kebijakan publik.

2. Pengantar Evaluasi Program Gizi

Evaluasi merupakan tahap krusial dalam program gizi komunitas. Evaluasi tidak hanya untuk menilai keberhasilan, tetapi juga memastikan akuntabilitas, transparansi, dan dasar perbaikan program di masa depan. Ada tiga jenis evaluasi yang umum dilakukan:

- a. Evaluasi proses (*process evaluation*): menilai apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Contoh: apakah jumlah penyuluhan sesuai target, atau apakah kader mendapat pelatihan yang dijanjikan.
- b. Evaluasi dampak (*impact evaluation*): menilai perubahan perilaku atau pengetahuan masyarakat. Misalnya, apakah terjadi peningkatan konsumsi sayur dan buah setelah program edukasi.
- c. Evaluasi hasil (*outcome evaluation*): menilai hasil jangka panjang, misalnya penurunan prevalensi stunting atau obesitas di suatu wilayah.

3. Arah Masa Depan dalam Gizi Komunitas

Meskipun telah banyak kemajuan, gizi komunitas menghadapi sejumlah tantangan baru.

- a. Perubahan iklim: Perubahan pola cuaca memengaruhi produksi pangan, ketahanan pangan lokal, dan ketersediaan gizi seimbang (Fanzo et al., 2018).
- b. Urbanisasi: Perubahan gaya hidup urban meningkatkan konsumsi makanan cepat saji dan mengurangi aktivitas fisik, yang berdampak pada meningkatnya obesitas di kota besar (Popkin et al., 2020).
- c. Disinformasi gizi di era digital: Penyebaran hoaks terkait diet ekstrem, suplemen instan, dan mitos gizi menjadi ancaman serius. Studi di Indonesia menemukan bahwa remaja yang terpapar informasi gizi di media sosial lebih rentan mengikuti pola diet tidak sehat (Widyastuti & Pratama, 2021).

Untuk menjawab tantangan tersebut, gizi komunitas harus mengadopsi pendekatan adaptif, inovatif, dan berbasis bukti. Pendekatan adaptif diperlukan agar program dapat menyesuaikan dengan kondisi global dan lokal. Inovasi

meliputi pemanfaatan teknologi digital untuk edukasi gizi, seperti aplikasi *mobile health* (mHealth). Sedangkan pendekatan berbasis bukti memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan berlandaskan data riset, bukan asumsi semata.

Gizi komunitas adalah fondasi penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Melalui pemahaman teori perilaku, perencanaan sistematis, strategi intervensi multi-level, serta evaluasi yang komprehensif, program gizi komunitas dapat berkontribusi nyata dalam mengatasi *triple burden of malnutrition* di Indonesia.

Integrasi lintas sektor, dukungan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta inovasi berbasis teknologi akan menjadi kunci sukses gizi komunitas di masa depan. Dengan demikian, gizi komunitas bukan hanya tentang memperbaiki status gizi, tetapi juga membangun ketahanan pangan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* di bidang kesehatan dan kesejahteraan.

Referensi

- Alfiana, R., Aji, A. S., Samutri, E., Paratmanitya, Y., Hafizhah, R. D., Zulfa, I. F., Putri, S. A., Farhan, A. U., & Surendran, S. (2023). The role of nutritionist in gene-based nutrition services in Indonesia. *Amerta Nutrition*, 7(2SP), 276–282. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2SP.2023.276-282>
- Astuti, P., Lestari, D., & Rahmawati, A. (2021). Self-efficacy ibu dalam pemberian makan balita dan hubungannya dengan status gizi anak. *Jurnal Gizi Indonesia*, 10(1), 45–54.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., ... & Black, R. E. (2020). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)
- Boyle, M. A., & Holben, D. H. (2018). *Community Nutrition in Action: An Entrepreneurial Approach* (8th ed.). Cengage Learning.
- Chakrabarti, S., Raghunathan, K., Alderman, H., Menon, P., & Nguyen, P. (2019). India's Integrated Child Development Services programme; equity and extent of coverage in 2006 and 2016. *Bulletin of the World Health Organization*, 97(4), 270–282. <https://doi.org/10.2471/BLT.18.221135>
- Darmawan, E., Rahardjo, S., & Kartasurya, M. I. (2020). Dampak fortifikasi tepung terigu terhadap prevalensi anemia di Indonesia: Tinjauan literatur. *Jurnal Gizi Indonesia*, 9(2),

- De Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: A global perspective. *Maternal & Child Nutrition*, 12(S1), 12–26. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>
- Fanzo, J., Davis, C., McLaren, R., & Choufani, J. (2018). The effect of climate change on nutrition and child health in low- and middle-income countries: A systematic review. *Environmental Research Letters*, 13(12), 123002. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aae7b5>
- FAO. (2019). *The state of food security and nutrition in the world*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Febriyanti, D., Gunawan, H., & Suhendar, R. (2025). Collaborative governance dalam penanganan stunting di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. *Praxis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 15–29. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/view/3251>
- Fitriani, R., Wibowo, A., & Damanik, S. R. (2021). Kolaborasi perawat dan ahli gizi dalam penanganan masalah gizi balita di Puskesmas Halmahera Barat. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 6(2), 293–299. <https://doi.org/10.14710/jekk.v6i2.11622>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Handayani, R., & Fitri, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui kebun gizi untuk peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. *Jurnal Pangan dan Gizi*, 15(1), 45–54.
- Handayani, R., Puspitasari, R., & Kartika, D. (2020). Penerapan model PRECEDE-PROCEED dalam program pencegahan anemia remaja putri. *Jurnal Gizi Indonesia*, 9(2), 112–120.
- Issel, L. M., & Wells, R. (2017). *Health program planning and evaluation: A practical, systematic approach for community health* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Issel, L. M., & Wells, R. (2017). *Health program planning and evaluation: A practical, systematic approach for community health* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2022*. Jakarta: Badan Litbangkes.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2022*. Jakarta: Badan Litbangkes.
- Kementerian Kesehatan RI. (n.d.). *Pedoman bagi Ahli Gizi dalam mencapai dan memilih lahan kerja*. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

- Nuryani, E., Putri, R., & Maulida, S. (2021). Implementasi program kantin sehat di sekolah menengah: Pendekatan model ekologi sosial. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 16(2), 123–134.
- Nutbeam, D., & Bauman, A. (2019). *Evaluation in a nutshell: A practical guide to the evaluation of health promotion programs* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Popkin, B. M., Corvalan, C., & Grummer-Strawn, L. M. (2020). Dynamics of the double burden of malnutrition and the changing nutrition reality. *The Lancet*, 395(10217), 65–74. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32497-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32497-3)
- Pradana, M. A., & Rachmah, D. (2021). Efektivitas pemasaran sosial dalam promosi gizi seimbang pada remaja di Jakarta. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(2), 87–96.
- Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change. *American Journal of Health Promotion*, 12(1), 38–48.
- Putri, A. D., & Nurdin, M. (2020). Analisis perilaku makan sehat mahasiswa berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 8(2), 56–64.
- Rachmi, C. N., Li, M., & Baur, L. A. (2017). Overweight and obesity in Indonesia: Prevalence and risk factors a literature review. *Public Health*, 159, 93–103. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.04.002>
- Rahayu, S., Indrawati, T., & Nugroho, H. (2019). Observational learning dalam program edukasi gizi berbasis video memasak sehat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(3), 211–219.
- Rahmawati, L., & Widodo, S. (2021). Pengaruh kebun gizi komunitas terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin di Banyumas. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 20(1), 34–46.
- Rahmawati, R., & Lestari, S. (2021). Efektivitas intervensi gizi berbasis transtheoretical model pada penderita obesitas di Surabaya. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 17(1), 33–41.
- Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988). Social learning theory and the health belief model. *Health Education Quarterly*, 15(2), 175–183. <https://doi.org/10.1177/109019818801500203>
- Sallis, J. F., Owen, N., & Fisher, E. B. (2015). Ecological models of health behavior. In K. Glanz, B. Rimer, & K. Viswanath (Eds.), *Health behavior: Theory, research, and practice* (pp. 43–64). Jossey-Bass.
- Sari, N. P., Ramadhani, N., & Rahayu, T. (2022). Pelayanan gizi kepada masyarakat melalui konsultasi gizi berbasis daring di masa pandemi COVID-19.

- Dharmarafflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS, 20(2), 137–146. <https://ejournal.unib.ac.id/dharmarafflesia/article/view/19675>
- Sari, R., Kurniawan, H., & Pratiwi, N. (2020). Edukasi gizi berbasis praktik memasak untuk meningkatkan perilaku makan sehat siswa sekolah. *Jurnal Gizi Indonesia*, 8(1), 55–64.
- Setyaningsih, S., & Widyasari, D. (2020). Penerapan health belief model untuk mengurangi penggunaan minyak goreng berulang pada ibu rumah tangga. *Jurnal Promkes*, 8(1), 22–30.
- Sutrisna, B., Rahman, A., & Fitriani, D. (2021). Faktor budaya dalam pemberian makanan bayi: Hasil penilaian kebutuhan gizi komunitas di Lombok. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 56–65.
- Sutrisna, B., Rahman, A., & Fitriani, D. (2021). Faktor budaya dalam pemberian makanan bayi: Hasil penilaian kebutuhan gizi komunitas di Lombok. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 56–65.
- Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S., Atkins, V. J., Baker, P. I., Bogard, J. R., ... & Dietz, W. H. (2019). The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, 393(10173), 791–846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)
- Syahputra, A., & Darmawan, A. (2023). Peran gizi dan ahli gizi dalam upaya pembangunan nasional di Indonesia. *Jurnal Sehat Indonesia*, 1(1), 12–22. <https://www.researchgate.net/publication/377189174>
- Titaley, C. R., Ariawan, I., Hapsari, D., Muasyaroh, A., & Dibley, M. J. (2019). Determinants of the stunting of children under two years old in Indonesia: A multilevel analysis of the 2013 Indonesia Demographic and Health Survey. *Nutrients*, 11(5), 1106. <https://doi.org/10.3390/nu11051106>
- UNICEF. (2020). Micronutrient deficiencies: Hidden hunger. UNICEF Data. <https://data.unicef.org/topic/nutrition/micronutrients/>
- W.K. Kellogg Foundation. (2004). Logic model development guide. W.K. Kellogg Foundation.
- Widyastuti, F., & Pratama, R. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku diet remaja di Jakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 101–110.
- World Health Organization. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2020). Nutrition in the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe.

- World Health Organization. (2021). Obesity and overweight. WHO Fact Sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Wulandari, I., & Hidayat, A. (2022). Pengaruh perceived behavioral control terhadap konsumsi fast food remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 67–75.
- Wulandari, T., Hidayah, N., & Pratama, S. (2021). Penerapan prinsip SMART dalam program gizi sekolah: Studi evaluasi di Kota Bandung. *Media Gizi Indonesia*, 15(2), 87–94.
- Wulandari, T., Suryani, L., & Hidayat, A. (2020). Efektivitas intervensi gizi di lingkungan kerja terhadap perilaku makan sehat karyawan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(3), 200–210.
- Yanti, D. A., & Hartini, S. (2019). Penerapan health belief model untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah remaja. *Media Gizi Indonesia*, 14(1), 55–64.

BAB II

PENILAIAN DAN SURVEILANS GIZI KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Penilaian dan surveilans gizi komunitas merupakan komponen fundamental dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Gizi yang baik adalah pondasi utama bagi pembangunan manusia yang berkualitas, karena status gizi yang optimal tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan individu, tetapi juga pada produktivitas dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, penilaian gizi dan sistem surveilans gizi berfungsi sebagai alat untuk mengenali, memantau, serta mengendalikan masalah gizi yang terjadi di tingkat individu, keluarga, maupun populasi. Keduanya merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program intervensi gizi berbasis bukti (evidence-based intervention).

1. Latar belakang pentingnya penilaian dan surveilans gizi komunitas

Penilaian gizi komunitas berperan penting dalam mengidentifikasi kondisi nyata status gizi masyarakat di suatu wilayah. Melalui proses ini, tenaga kesehatan dan perencana program dapat mengetahui sejauh mana masalah gizi terjadi, siapa kelompok yang paling berisiko, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya masalah tersebut. Penilaian gizi bukan hanya sekadar kegiatan teknis mengukur berat badan atau tinggi badan, tetapi juga sebuah pendekatan komprehensif yang mencakup pengumpulan data antropometri, konsumsi pangan, status biokimia, serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh terhadap pola gizi masyarakat.

Kegiatan penilaian gizi menjadi sangat penting karena masalah gizi bersifat dinamis dan multidimensional. Masalah gizi tidak hanya mencakup kekurangan gizi (seperti stunting, wasting, dan defisiensi zat gizi mikro), tetapi juga kelebihan gizi (obesitas dan penyakit tidak menular terkait gizi). Perubahan gaya hidup, urbanisasi, serta pola konsumsi pangan modern telah menyebabkan double burden of malnutrition di mana kekurangan dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam satu populasi. Oleh karena itu, penilaian gizi komunitas membantu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.

Sementara itu, surveilans gizi berperan dalam pemantauan berkelanjutan terhadap status dan situasi gizi masyarakat. Surveilans gizi tidak hanya mengumpulkan data sesaat, tetapi juga berfungsi sebagai sistem informasi dinamis yang memantau tren perubahan status gizi dari waktu ke waktu. Dengan adanya surveilans gizi, pemerintah dan lembaga kesehatan dapat mendeteksi dini terjadinya peningkatan masalah gizi, seperti lonjakan kasus anemia pada ibu hamil, meningkatnya angka stunting pada anak, atau bertambahnya prevalensi obesitas pada remaja. Sistem ini juga penting untuk memantau dampak kebijakan, seperti program bantuan pangan, fortifikasi zat gizi, atau intervensi suplementasi.

Kedua komponen ini penilaian dan surveilans menjadi kunci dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun lingkungan. Tanpa data gizi yang valid dan berkelanjutan, kebijakan gizi hanya akan bersifat reaktif dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian, penilaian dan surveilans gizi komunitas menjadi dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

2. Tujuan penilaian dan surveilans gizi

Tujuan utama dari penilaian gizi komunitas adalah untuk mengidentifikasi status gizi populasi secara akurat dan komprehensif. Melalui kegiatan ini, dapat diketahui apakah suatu kelompok masyarakat mengalami masalah gizi tertentu, seperti kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, stunting pada balita, atau obesitas pada orang dewasa. Penilaian gizi juga berfungsi untuk mengenali kelompok yang paling berisiko terhadap masalah gizi, seperti masyarakat miskin, anak-anak di wilayah terpencil, atau populasi dengan akses pangan yang terbatas.

Selain mengidentifikasi status gizi, penilaian gizi juga bertujuan untuk menentukan penyebab dan faktor yang berkontribusi terhadap masalah gizi. Informasi tentang pola konsumsi makanan, tingkat pendidikan, pendapatan, kondisi sanitasi, dan budaya makan merupakan data penting yang membantu memahami akar masalah gizi di masyarakat. Dengan demikian, intervensi yang dirancang dapat bersifat spesifik, kontekstual, dan efektif.

Di sisi lain, surveilans gizi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memantau tren dan perubahan status gizi masyarakat dari waktu ke waktu. Melalui sistem pemantauan yang berkelanjutan, lembaga kesehatan dapat mengetahui apakah intervensi gizi yang dilakukan berhasil memperbaiki kondisi masyarakat atau tidak. Misalnya, hasil surveilans dapat menunjukkan apakah prevalensi stunting menurun setelah implementasi program pemberian makanan tambahan (PMT) atau suplementasi zat besi pada ibu hamil.

Selain itu, surveilans gizi juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap munculnya krisis pangan atau bencana gizi. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, konflik sosial, atau pandemi, surveilans gizi

membantu mendeteksi perubahan pola konsumsi, ketersediaan pangan, dan status gizi masyarakat sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah mitigasi.

Secara keseluruhan, penilaian dan surveilans gizi bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti (actionable data) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making). Data ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, perencanaan program intervensi gizi, serta evaluasi efektivitas program yang sudah berjalan.

3. Hubungan antara penilaian gizi, surveilans, dan kebijakan kesehatan masyarakat

Penilaian gizi dan surveilans gizi tidak dapat dipisahkan dari sistem kebijakan kesehatan masyarakat karena keduanya menjadi sumber utama data dan bukti ilmiah dalam penyusunan kebijakan dan intervensi program. Penilaian gizi memberikan gambaran situasi pada titik waktu tertentu, sedangkan surveilans gizi memantau tren dan perubahan dalam jangka panjang. Kombinasi keduanya menghasilkan informasi yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

- a. Data yang dihasilkan dari penilaian dan surveilans gizi digunakan untuk berbagai keperluan strategis. Pertama, data tersebut menjadi dasar dalam identifikasi masalah prioritas dan penentuan target intervensi. Misalnya, jika hasil surveilans menunjukkan bahwa angka stunting tertinggi terjadi pada anak-anak di wilayah pedesaan dengan akses air bersih yang terbatas, maka program intervensi dapat difokuskan pada perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta edukasi gizi bagi ibu.
- b. Kedua, data gizi digunakan dalam advokasi kebijakan dan alokasi sumber daya. Informasi yang kuat dan valid mengenai masalah gizi dapat meyakinkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan bahwa intervensi gizi merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk pembangunan manusia. Misalnya, data tentang hubungan antara malnutrisi dengan rendahnya prestasi belajar atau produktivitas kerja dapat digunakan untuk memperkuat argumen bahwa program gizi perlu didanai secara berkelanjutan.
- c. Ketiga, penilaian dan surveilans gizi berperan dalam evaluasi efektivitas program dan kebijakan. Setelah suatu intervensi dilakukan, seperti program fortifikasi pangan atau pemberian suplemen gizi, surveilans gizi dapat mengukur dampaknya terhadap status gizi masyarakat. Jika hasil menunjukkan perbaikan yang signifikan, program dapat dilanjutkan atau diperluas; sebaliknya, jika hasilnya tidak efektif, maka kebijakan perlu dievaluasi dan disesuaikan.

Selain itu, integrasi antara penilaian gizi dan kebijakan kesehatan masyarakat juga menciptakan sistem pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-informed policy making). Dengan data yang diperoleh dari lapangan, keputusan pemerintah menjadi lebih objektif dan terukur, tidak hanya berdasarkan asumsi atau tekanan politik.

Secara keseluruhan, penilaian dan surveilans gizi komunitas merupakan dua komponen yang saling melengkapi dan berperan penting dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Melalui data yang akurat dan analisis yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan gizi yang efektif, adil, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penilaian dan surveilans gizi bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen strategis dalam mencapai ketahanan gizi dan kesehatan nasional.

B. Konsep Dasar Penilaian Gizi Komunitas

Penilaian gizi komunitas merupakan langkah fundamental dalam memahami kondisi kesehatan gizi masyarakat secara menyeluruh. Melalui proses ini, tenaga kesehatan masyarakat dan ahli gizi dapat mengidentifikasi status gizi individu dan kelompok, memahami penyebab utama permasalahan gizi, serta merumuskan intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Penilaian gizi tidak hanya berfokus pada pengukuran aspek biologis, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi asupan serta status gizi seseorang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar penilaian gizi komunitas menjadi penting sebagai landasan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) di bidang kesehatan masyarakat.

1. Definisi dan ruang lingkup penilaian gizi komunitas

Penilaian gizi komunitas dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan status gizi individu maupun populasi untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi. Proses ini melibatkan berbagai metode dan alat ukur yang dirancang untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang keadaan gizi masyarakat pada waktu tertentu.

Ruang lingkup penilaian gizi komunitas mencakup tiga tingkat utama, yaitu tingkat individu, rumah tangga, dan populasi (komunitas).

- a. Pada tingkat individu, penilaian gizi bertujuan untuk menilai kondisi gizi seseorang secara langsung, baik melalui pengukuran fisik, analisis biokimia, observasi klinis, maupun penilaian pola konsumsi pangan. Hasilnya digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami gizi baik, kurang, atau lebih, serta menjadi dasar penentuan terapi atau intervensi gizi individual.

- b. Pada tingkat rumah tangga, penilaian gizi menekankan pada ketersediaan pangan, distribusi makanan antar anggota keluarga, kebiasaan makan, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi pola konsumsi. Rumah tangga merupakan unit sosial yang penting karena keputusan dan perilaku makan umumnya ditentukan pada level ini. Dengan menilai kondisi rumah tangga, dapat diketahui apakah ada kerentanan pangan, ketidakmerataan distribusi makanan, atau pola konsumsi yang tidak seimbang di dalam keluarga.
- c. Pada tingkat populasi atau komunitas, penilaian gizi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang status gizi suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu, misalnya tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Penilaian ini sering digunakan untuk pemantauan (monitoring) dan evaluasi kebijakan publik. Melalui data agregat, dapat diketahui besaran masalah seperti prevalensi stunting, anemia, obesitas, atau defisiensi zat gizi mikro pada suatu wilayah.

Secara keseluruhan, penilaian gizi komunitas memberikan dasar ilmiah bagi penyusunan kebijakan, prioritas intervensi, serta pengalokasian sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien.

2. Komponen utama penilaian gizi

Dalam praktiknya, penilaian status gizi dilakukan melalui empat pendekatan utama yang dikenal dengan akronim ABCK—Antropometri, Biokimia, Klinis, dan Konsumsi pangan. Keempat komponen ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi gizi seseorang maupun masyarakat.

a. Penilaian Antropometri

Antropometri merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian gizi karena relatif mudah, murah, dan dapat diterapkan di berbagai situasi lapangan. Pengukuran antropometri meliputi berat badan, tinggi atau panjang badan, lingkaran lengan atas (LLA), indeks massa tubuh (IMT), lingkaran kepala, serta tebal lipatan kulit. Data ini kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang ditetapkan oleh WHO untuk menentukan status gizi individu, seperti gizi baik, kurang, buruk, atau obesitas.

Sebagai contoh, pengukuran berat badan menurut umur (BB/U) digunakan untuk mendeteksi gizi kurang atau buruk pada anak, sementara tinggi badan menurut umur (TB/U) digunakan untuk menilai stunting. Pada orang dewasa, indikator yang sering digunakan adalah IMT (Indeks Massa Tubuh) untuk menentukan apakah seseorang memiliki berat badan normal, kurang, atau berlebih.

b. Penilaian Biokimia

Pendekatan biokimia melibatkan analisis laboratorium terhadap cairan tubuh (seperti darah, urine, atau saliva) guna mengukur kadar zat gizi tertentu atau

biomarker yang berhubungan dengan status gizi. Misalnya, kadar hemoglobin dan feritin digunakan untuk menilai status zat besi dan anemia; kadar retinol plasma untuk menilai status vitamin A; atau kadar albumin untuk menilai status protein.

Metode ini memberikan hasil yang objektif dan sensitif dalam mendeteksi defisiensi zat gizi sebelum muncul gejala klinis. Namun, pemeriksaan biokimia membutuhkan peralatan dan tenaga ahli laboratorium, sehingga penggunaannya lebih terbatas di tingkat pelayanan kesehatan tertentu.

c. **Penilaian Klinis**

Penilaian klinis dilakukan melalui observasi terhadap tanda-tanda fisik dan gejala yang tampak akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi. Pemeriksaan ini mencakup inspeksi rambut, kulit, mata, kuku, mulut, dan jaringan subkutan untuk mendeteksi kelainan yang disebabkan oleh defisiensi atau kelebihan nutrisi.

Sebagai contoh, konjungtiva pucat dapat mengindikasikan anemia, kulit kering dan bersisik dapat menandakan kekurangan vitamin A, sedangkan edema (bengkak) pada kaki bisa menunjukkan defisiensi protein (kwashiorkor). Penilaian klinis penting dilakukan sebagai pelengkap dari data antropometri dan biokimia, karena memberikan gambaran visual dan kontekstual terhadap kondisi kesehatan individu.

d. **Penilaian Konsumsi Pangan**

Komponen terakhir dari ABCK adalah penilaian konsumsi pangan, yang bertujuan untuk mengetahui jenis, jumlah, dan frekuensi makanan yang dikonsumsi individu atau rumah tangga. Data ini menjadi dasar untuk menilai kecukupan zat gizi terhadap kebutuhan tubuh.

Beberapa metode yang digunakan antara lain food recall 24 jam (mencatat semua makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir), food frequency questionnaire (FFQ), penimbangan langsung makanan, dan pencatatan rumah tangga (household food record). Melalui analisis konsumsi pangan, dapat diketahui apakah asupan energi, protein, vitamin, dan mineral seseorang sudah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau belum.

Kombinasi keempat komponen ABCK menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan saling melengkapi—dari aspek fisik, biologis, hingga perilaku konsumsi. Dengan demikian, tenaga gizi dapat melakukan diagnosis yang akurat dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

3. Pendekatan ekologi dalam penilaian status gizi

Pendekatan ekologi merupakan cara pandang yang memandang status gizi sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individu, lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam model ekologi, masalah gizi tidak hanya dipandang

sebagai akibat dari kekurangan asupan makanan, tetapi juga sebagai hasil dari sistem yang saling memengaruhi antara manusia dan lingkungannya.

Secara sederhana, pendekatan ini menegaskan bahwa status gizi seseorang dipengaruhi oleh empat kelompok faktor utama:

- a. Faktor individu, seperti umur, jenis kelamin, metabolisme, status kesehatan, dan perilaku makan.
- b. Faktor rumah tangga, seperti pendapatan, pendidikan, pola pengasuhan, dan ketersediaan pangan.
- c. Faktor lingkungan sosial dan budaya, yang meliputi norma makan, peran gender, kepercayaan terhadap makanan tertentu, serta kebiasaan komunitas.
- d. Faktor lingkungan fisik dan ekonomi, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, harga pangan, dan stabilitas ekonomi daerah.

Sebagai contoh, masalah stunting pada anak di suatu daerah tidak hanya disebabkan oleh kekurangan asupan gizi selama masa pertumbuhan, tetapi juga oleh sanitasi yang buruk, infeksi berulang, rendahnya pendidikan ibu, dan kemiskinan struktural yang membatasi akses terhadap makanan bergizi.

Pendekatan ekologi dalam penilaian gizi komunitas menekankan pentingnya melihat status gizi sebagai hasil dari sistem yang saling terkait, bukan sebagai masalah individu semata. Oleh karena itu, strategi penanganan masalah gizi harus bersifat multisektoral dan terintegrasi, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, dan lingkungan.

Dengan memahami hubungan antara faktor biologis, sosial, dan lingkungan melalui pendekatan ekologi, penilaian gizi komunitas dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan menjadi dasar kuat untuk perumusan kebijakan gizi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap intervensi gizi tidak hanya berfokus pada pemberian makanan atau suplemen, tetapi juga menyoroti akar penyebab masalah gizi yang bersifat struktural dan sosial-ekonomi.

C. Metode Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi merupakan proses penting dalam upaya memahami kondisi gizi individu maupun masyarakat. Melalui penilaian yang sistematis dan berbasis metode ilmiah, dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kecukupan gizi, prevalensi masalah gizi, serta faktor-faktor penyebabnya. Metode penilaian status gizi dibagi menjadi empat kelompok utama, yaitu penilaian antropometri, biokimia dan klinis, konsumsi makanan, serta faktor lingkungan dan sosial ekonomi. Keempat pendekatan ini saling melengkapi dan digunakan untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh terhadap status gizi populasi.

1. Penilaian antropometri

Penilaian antropometri merupakan metode paling umum digunakan dalam mengukur status gizi karena mudah diterapkan, relatif murah, dan dapat dilakukan di lapangan dengan peralatan sederhana. Antropometri mengukur berbagai parameter tubuh manusia, seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA), tebal lipatan kulit, serta indeks massa tubuh (IMT), yang menggambarkan keseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi seseorang.

Prinsip dasar dari penilaian antropometri adalah bahwa ukuran tubuh seseorang mencerminkan kesehatannya secara umum dan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kekurangan atau kelebihan gizi. Pengukuran ini dilakukan dengan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) agar hasilnya dapat dibandingkan secara internasional.

Beberapa indikator utama yang digunakan dalam penilaian antropometri meliputi:

- a. Berat Badan menurut Umur (BB/U): menunjukkan kondisi gizi secara umum. Nilai di bawah -2 standar deviasi (SD) dari median WHO menandakan gizi kurang, sedangkan di bawah -3 SD dikategorikan sebagai gizi buruk.
- b. Tinggi Badan menurut Umur (TB/U): mengindikasikan adanya stunting atau pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi kronis. Anak dikategorikan stunting bila $TB/U < -2\text{ SD}$.
- c. Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB): menggambarkan status gizi akut atau wasting. Nilai $< -2\text{ SD}$ menandakan gizi kurus, sedangkan $> +2\text{ SD}$ menunjukkan kelebihan berat badan.
- d. Indeks Massa Tubuh (IMT): digunakan untuk menilai status gizi orang dewasa. Rumus IMT adalah berat badan (kg) dibagi tinggi badan kuadrat (m^2). $IMT < 18,5$ menunjukkan gizi kurang, $18,5 - 24,9$ normal, $25 - 29,9$ overweight, dan ≥ 30 obesitas.
- e. Lingkaran Lengan Atas (LILA): digunakan untuk menilai risiko kekurangan energi kronis (KEK) terutama pada wanita usia subur dan ibu hamil. Nilai $LILA < 23,5\text{ cm}$ menandakan risiko KEK.
- f. Lingkaran Kepala dan Tebal Lipatan Kulit: umumnya digunakan untuk menilai pertumbuhan bayi dan simpanan lemak tubuh.

Interpretasi hasil antropometri dilakukan dengan membandingkan data pengukuran dengan standar WHO Growth Reference Chart atau BMI Classification. Dengan metode ini, dapat ditentukan distribusi status gizi di masyarakat, seperti prevalensi stunting, wasting, atau obesitas, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan intervensi gizi.

2. Penilaian biokimia dan klinis

Selain pengukuran fisik, status gizi juga dapat dinilai melalui pemeriksaan biokimia dan klinis. Metode ini memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai kadar zat gizi dan dampaknya terhadap fungsi tubuh.

Penilaian biokimia dilakukan dengan analisis sampel darah, urin, atau cairan tubuh lainnya untuk mengukur kadar zat gizi tertentu. Parameter biokimia yang sering digunakan antara lain:

- a. Hemoglobin (Hb): digunakan untuk menilai anemia akibat defisiensi zat besi. Nilai normal untuk wanita dewasa ≥ 12 g/dL dan pria dewasa ≥ 13 g/dL.
- b. Feritin: menggambarkan cadangan zat besi dalam tubuh; kadar feritin rendah (<15 $\mu\text{g/L}$) menunjukkan defisiensi besi.
- c. Albumin: merupakan indikator status protein. Nilai normal 3,5–5,0 g/dL, sedangkan kadar rendah mengindikasikan kekurangan protein atau gangguan hati.
- d. Vitamin A (Retinol serum): kadar $< 0,7$ $\mu\text{mol/L}$ menandakan defisiensi vitamin A.
- e. Zinc, Iodium, dan Asam Folat: diukur untuk menilai status zat gizi mikro yang penting bagi pertumbuhan dan metabolisme tubuh.

Metode biokimia sangat berguna untuk mendeteksi defisiensi zat gizi sebelum muncul gejala klinis (subclinical deficiency). Oleh karena itu, metode ini sering digunakan dalam penelitian dan survei nasional seperti Riskesdas atau SSGI untuk mendapatkan data objektif tentang prevalensi kekurangan zat gizi mikro di masyarakat.

Sementara itu, penilaian klinis dilakukan dengan mengamati tanda-tanda fisik dan gejala yang muncul akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi. Pemeriksaan ini bersifat observasional dan memerlukan keterampilan tenaga kesehatan dalam mengenali manifestasi klinis defisiensi gizi.

Beberapa contoh tanda klinis defisiensi gizi antara lain:

- a. Konjungtiva pucat indikasi anemia.
- b. Kulit kering, bersisik, dan pecah-pecah kekurangan vitamin A atau asam lemak esensial.
- c. Bengkak pada kaki dan wajah (edema) defisiensi protein (kwashiorkor).
- d. Luka yang sulit sembuh kekurangan vitamin C atau zinc.
- e. Mulut pecah-pecah dan lidah licin kekurangan vitamin B kompleks.

Penilaian biokimia dan klinis saling melengkapi dengan antropometri. Jika pengukuran fisik menunjukkan indikasi gizi kurang, pemeriksaan biokimia dapat memastikan jenis dan tingkat defisiensi zat gizi yang terjadi.

3. Penilaian konsumsi makanan

Penilaian konsumsi makanan bertujuan untuk mengetahui jenis, jumlah, dan frekuensi makanan yang dikonsumsi oleh individu atau rumah tangga dalam

jangka waktu tertentu. Informasi ini digunakan untuk menilai kecukupan asupan zat gizi terhadap kebutuhan tubuh berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Beberapa metode utama yang digunakan antara lain:

a. Metode Food Recall 24 Jam

Responden diminta mengingat semua jenis dan jumlah makanan serta minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Metode ini sederhana dan cepat dilakukan, meskipun bergantung pada daya ingat responden dan keterampilan enumerator.

b. Metode Food Frequency Questionnaire (FFQ)

Responden diminta melaporkan frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan selama periode tertentu (mingguan atau bulanan). FFQ berguna untuk menggambarkan pola konsumsi jangka panjang, seperti kebiasaan makan tinggi gula, lemak, atau rendah serat.

c. Metode Penimbangan Langsung (Weighing Method)

Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi ditimbang sebelum dimakan. Metode ini dianggap paling akurat karena mengukur asupan aktual, namun membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar.

d. Metode Household Food Record

Digunakan untuk menilai konsumsi pada tingkat rumah tangga dengan mencatat bahan pangan yang masuk, dikonsumsi, dan tersisa selama periode tertentu.

Data konsumsi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan perangkat lunak gizi seperti NutriSurvey atau NutriSoft, untuk menghitung asupan energi, protein, vitamin, dan mineral. Hasilnya dibandingkan dengan AKG untuk menentukan tingkat kecukupan zat gizi.

Penilaian konsumsi makanan memiliki peran strategis dalam merancang intervensi gizi berbasis pangan, seperti kampanye "Isi Piringku," fortifikasi makanan, dan edukasi gizi seimbang. Selain itu, metode ini juga penting untuk menilai risiko gizi lebih dan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola makan tidak sehat.

4. Penilaian faktor lingkungan dan sosial ekonomi

Status gizi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh asupan dan metabolisme, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Faktor-faktor ini sering kali menjadi penyebab tidak langsung dari masalah gizi yang terjadi di masyarakat.

Penilaian faktor lingkungan mencakup ketersediaan pangan, sanitasi, air bersih, dan kondisi tempat tinggal. Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan penyerapan zat gizi. Misalnya, anak-anak yang sering mengalami diare akibat sanitasi buruk akan memiliki risiko stunting lebih tinggi karena gangguan penyerapan nutrisi.

Selain itu, faktor sosial ekonomi seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga turut memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh dan mengonsumsi makanan bergizi. Rumah tangga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki pola konsumsi yang monoton, terbatas pada bahan pangan pokok dengan sedikit variasi sumber protein dan vitamin.

Analisis faktor sosial ekonomi biasanya dilakukan melalui survei rumah tangga yang mencakup:

- a. Pendapatan dan pengeluaran pangan.
- b. Tingkat pendidikan ibu dan kepala keluarga.
- c. Akses terhadap layanan kesehatan dan gizi.
- d. Kebiasaan dan budaya makan.
- e. Ketersediaan pangan lokal dan harga bahan makanan.

Informasi ini penting untuk memahami akar struktural dari masalah gizi. Misalnya, prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah mungkin tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, tetapi juga karena kemiskinan, ketimpangan akses pangan, serta kebijakan sosial yang belum mendukung kemandirian gizi masyarakat.

Dengan menganalisis faktor lingkungan dan sosial ekonomi, penilaian status gizi menjadi lebih holistik dan kontekstual. Hasilnya dapat digunakan untuk merancang intervensi yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

D. Surveilans Gizi Komunitas

Surveilans gizi komunitas merupakan bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat yang berfungsi untuk memantau secara berkelanjutan status gizi dan permasalahan gizi di tingkat populasi. Melalui kegiatan surveilans, pemerintah dan tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu mengenai kondisi gizi masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program gizi. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan gizi dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti (evidence-based decision making).

1. Pengertian dan tujuan surveilans gizi

Secara umum, surveilans gizi dapat diartikan sebagai suatu sistem pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyebaran informasi mengenai status gizi masyarakat secara berkelanjutan dan sistematis. Surveilans gizi berbeda dengan survei gizi, karena dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memantau perubahan status gizi dan faktor-faktor yang memengaruhi gizi dari waktu ke waktu, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.

Tujuan utama surveilans gizi antara lain:

- a. Memantau status gizi masyarakat di berbagai kelompok umur (balita, remaja, ibu hamil, dan lansia) guna mengetahui prevalensi masalah gizi seperti stunting, wasting, anemia, dan obesitas.
- b. Mendeteksi secara dini potensi terjadinya krisis gizi, misalnya akibat bencana, gagal panen, atau krisis pangan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secepatnya.
- c. Menyediakan data dan informasi gizi yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program gizi nasional maupun daerah.
- d. Mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi, baik di tingkat komunitas maupun nasional, dengan melihat tren perbaikan atau penurunan status gizi masyarakat.

Melalui surveilans gizi, diharapkan setiap perubahan kondisi gizi masyarakat dapat dipantau secara real time, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Komponen utama sistem surveilans gizi

Sistem surveilans gizi yang efektif memiliki beberapa komponen utama yang saling terkait, yaitu pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan diseminasi informasi.

a. Pengumpulan Data:

Tahap pertama dalam surveilans adalah pengumpulan data lapangan mengenai status gizi dan faktor yang memengaruhinya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan survei nasional. Proses pengumpulan data harus menggunakan metode yang standar dan valid agar hasilnya dapat dibandingkan antarwaktu maupun antarwilayah.

b. Analisis Data:

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menggambarkan tren status gizi masyarakat. Analisis dilakukan dengan menghitung prevalensi gizi buruk, kurang, atau lebih, serta mengidentifikasi kelompok rentan. Analisis juga mencakup hubungan antara status gizi dengan faktor lingkungan, sosial ekonomi, dan perilaku makan.

c. Interpretasi Data:

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui arti dan makna dari temuan tersebut. Misalnya, peningkatan prevalensi anemia pada remaja putri bisa diinterpretasikan sebagai kurangnya asupan zat besi, rendahnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, atau rendahnya kesadaran gizi.

d. Diseminasi Informasi

Tahap terakhir adalah penyebaran hasil surveilans kepada berbagai pihak terkait, termasuk dinas kesehatan, lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Informasi disajikan dalam bentuk laporan rutin, bulletin gizi, atau portal data yang mudah diakses. Tujuannya agar hasil surveilans dapat digunakan secara nyata untuk perencanaan dan advokasi kebijakan.

Keempat komponen ini harus berjalan secara berkesinambungan agar sistem surveilans gizi mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi pengambil keputusan.

3. Indikator surveilans gizi

Indikator dalam surveilans gizi merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi dan perkembangan status gizi masyarakat serta pelaksanaan program gizi. Secara umum, indikator dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu indikator status gizi, indikator input, dan indikator proses.

a. Indikator Status Gizi:

Indikator ini menggambarkan kondisi gizi masyarakat secara langsung. Contohnya meliputi:

- 1) Prevalensi stunting ($TB/U < -2$ SD) pada anak balita sebagai tanda kekurangan gizi kronis.
- 2) Prevalensi wasting ($BB/TB < -2$ SD) sebagai indikator kekurangan gizi akut.
- 3) Prevalensi underweight ($BB/U < -2$ SD) sebagai gambaran gizi secara umum.
- 4) Prevalensi anemia ($Hb < 12$ g/dL) pada ibu hamil dan remaja putri.
- 5) Prevalensi obesitas ($IMT \geq 30$) pada remaja dan dewasa.

b. Indikator Input:

Mengukur sumber daya yang tersedia untuk mendukung program gizi, seperti jumlah tenaga gizi di puskesmas, jumlah posyandu aktif, ketersediaan logistik (PMT, tablet Fe, vitamin A), dan anggaran program gizi.

c. Indikator Proses dan Output:

Menggambarkan pelaksanaan kegiatan gizi, seperti jumlah balita yang dipantau pertumbuhannya di posyandu, cakupan pemberian vitamin A, cakupan tablet tambah darah pada remaja putri, serta cakupan edukasi gizi seimbang di sekolah.

4. Sumber data surveilans gizi

Sumber data surveilans gizi dapat berasal dari berbagai sistem pencatatan dan survei di tingkat lokal maupun nasional. Sumber-sumber utama meliputi:

a. Posyandu dan Puskesmas:

Merupakan sumber data utama di tingkat komunitas. Data yang dikumpulkan meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, serta data pemberian vitamin A dan tablet tambah darah. Data ini dilaporkan secara rutin melalui sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi (PPG).

b. Survei Nasional:

Survei seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dilakukan secara berkala oleh Kementerian Kesehatan untuk menilai status gizi masyarakat dalam skala nasional. Survei ini menyediakan data prevalensi stunting, wasting, anemia, dan indikator gizi lainnya dengan tingkat keandalan yang tinggi.

c. Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZI):

SIGIZI merupakan sistem digital yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai data gizi dari fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemantauan status gizi secara nasional secara real-time.

d. Data dari Sektor Terkait:

Data pendukung dari sektor lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial juga digunakan dalam analisis surveilans gizi, terutama terkait dengan ketahanan pangan, kemiskinan, dan tingkat pendidikan.

5. Pemanfaatan data surveilans untuk kebijakan dan program intervensi

Data hasil surveilans gizi memiliki nilai strategis yang sangat besar dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Pemanfaatannya mencakup tiga fungsi utama, yaitu penentuan prioritas, perencanaan intervensi, dan evaluasi program.

a. Penentuan Prioritas:

Data surveilans digunakan untuk mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi. Misalnya, apabila suatu kabupaten menunjukkan prevalensi stunting di atas 30%, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai prioritas intervensi percepatan penurunan stunting.

b. Perencanaan Intervensi:

Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah dapat merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran. Contohnya, jika surveilans menunjukkan tingginya angka anemia pada remaja putri, maka program edukasi gizi dan distribusi tablet tambah darah dapat diperkuat di sekolah-sekolah menengah.

c. Evaluasi dan Pemantauan Program:

Surveilans gizi juga digunakan untuk mengevaluasi dampak program gizi yang telah berjalan. Melalui pemantauan tren dari waktu ke waktu, dapat diketahui apakah intervensi seperti PMT (Pemberian Makanan Tambahan) atau program fortifikasi telah memberikan hasil signifikan terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Selain itu, data surveilans berperan penting dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Informasi tentang tingginya angka gizi buruk

atau anemia dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk menambah alokasi anggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengintegrasikan program gizi dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pemanfaatan data surveilans gizi yang optimal tidak hanya mendukung efektivitas intervensi, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan sistem surveilans yang kuat, kebijakan gizi dapat disusun secara adaptif, responsif, dan berbasis bukti nyata untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berketahanan gizi.

E. Analisis dan Interpretasi Data Gizi Komunitas

Analisis dan interpretasi data gizi komunitas merupakan tahap lanjutan setelah proses pengumpulan dan surveilans data dilakukan. Tahap ini sangat penting karena data mentah yang telah dikumpulkan perlu diolah, divalidasi, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang akurat, bermakna, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis data gizi bukan sekadar proses statistik, melainkan juga kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami pola, tren, dan penyebab di balik kondisi gizi masyarakat. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi masalah gizi yang dominan, kelompok rentan, serta faktor determinan yang berkontribusi. Informasi inilah yang selanjutnya menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program intervensi gizi yang efektif, efisien, dan berbasis bukti (evidence-based).

1. Proses pengolahan dan analisis data gizi

Tahap pertama dalam analisis data gizi adalah pengolahan data, yang mencakup kegiatan validasi, pembersihan, pengkodean, serta analisis statistik untuk memperoleh hasil yang sahih dan dapat dipercaya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah validasi data, yaitu memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan bebas dari kesalahan pengukuran maupun pencatatan. Validasi mencakup pemeriksaan kelengkapan data (tidak ada data kosong), konsistensi antarvariabel, serta identifikasi nilai ekstrem atau outlier yang tidak logis. Misalnya, data tinggi badan anak dengan nilai 200 cm jelas tidak realistis dan perlu diperiksa ulang.

Setelah data dinyatakan valid, langkah selanjutnya adalah perhitungan indikator status gizi. Pada umumnya, analisis status gizi menggunakan sistem z-score yang dikembangkan oleh WHO. Z-score menunjukkan penyimpangan nilai individu dari rata-rata populasi referensi dalam satuan deviasi standar (SD). Misalnya, anak dengan berat badan menurut umur (BB/U) < -2 SD dikategorikan gizi kurang, sedangkan < -3 SD dikategorikan gizi buruk. Perhitungan z-score biasanya dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti WHO Anthro, WHO AnthroPlus, atau aplikasi statistik seperti SPSS dan R.

Selain menghitung z-score, analisis gizi juga melibatkan pengolahan data konsumsi makanan untuk mengetahui tingkat kecukupan zat gizi (energi, protein, vitamin, dan mineral) dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Proses ini dapat dilakukan dengan aplikasi seperti NutriSurvey atau NutriSoft, yang mampu menghitung rata-rata asupan dan persentase kecukupan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah analisis tren dan perbandingan antarwaktu atau antarwilayah. Analisis tren bertujuan untuk melihat perubahan prevalensi masalah gizi dari waktu ke waktu, misalnya penurunan angka stunting selama lima tahun terakhir atau peningkatan obesitas di perkotaan. Sementara itu, analisis spasial (geografis) digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan beban gizi tertinggi (hotspot area), sehingga memudahkan prioritas program.

Dengan proses analisis yang sistematis, data gizi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi gizi masyarakat, baik dari aspek kuantitatif (angka prevalensi, rasio, tren) maupun kualitatif (faktor penyebab dan pola perilaku gizi).

2. Interpretasi hasil penilaian gizi komunitas

Interpretasi data gizi merupakan proses menerjemahkan hasil analisis statistik ke dalam bentuk informasi yang bermakna dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat. Tujuan utama dari interpretasi adalah mengidentifikasi masalah gizi utama, menentukan kelompok berisiko, serta memahami faktor penyebabnya.

Dalam tahap ini, hasil analisis angka-angka harus dipahami dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Misalnya, jika data menunjukkan prevalensi stunting tinggi di suatu wilayah pedesaan, maka interpretasi tidak cukup berhenti pada angka saja, melainkan harus dilihat dari kemungkinan penyebab seperti rendahnya asupan protein hewani, sanitasi buruk, atau praktik pemberian makan bayi yang tidak sesuai dengan anjuran (improper complementary feeding).

Interpretasi hasil penilaian gizi dilakukan dengan beberapa pendekatan:

a. Identifikasi Masalah Gizi Dominan:

Langkah ini dilakukan dengan melihat prevalensi tertinggi dari berbagai indikator gizi. Sebagai contoh, apabila prevalensi stunting > 20% maka dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius menurut standar WHO.

b. Analisis Kelompok Berisiko:

Penentuan kelompok rentan didasarkan pada usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan. Misalnya, balita, ibu hamil, remaja putri, dan lansia merupakan kelompok yang sering mengalami risiko kekurangan gizi mikro seperti zat besi, kalsium, atau vitamin A.

c. Pemahaman Determinan Gizi:

Faktor determinan status gizi dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Faktor langsung meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi, sementara faktor tidak langsung mencakup akses pangan, pendapatan, pendidikan, budaya makan, dan sanitasi lingkungan.

Interpretasi juga harus mempertimbangkan standar nasional maupun internasional. Misalnya, klasifikasi status gizi menurut WHO digunakan untuk menentukan apakah prevalensi stunting, wasting, atau obesitas di suatu wilayah termasuk kategori ringan, sedang, atau berat. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan situasi, tetapi juga memberikan makna terhadap urgensi masalah dan arah penanganan yang diperlukan.

Hasil interpretasi yang baik tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi disertai narasi yang menjelaskan konteks lokal, penyebab potensial, serta implikasi kebijakan. Informasi inilah yang akan menjadi bahan penting bagi advokasi kepada pembuat keputusan dan masyarakat luas.

3. Penggunaan hasil analisis dalam perencanaan program gizi

Hasil analisis dan interpretasi data gizi komunitas memiliki nilai strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi masyarakat. Data yang telah dianalisis bukan hanya berfungsi sebagai informasi akademik, tetapi juga menjadi dasar kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah pertama dalam penggunaan hasil analisis adalah penetapan prioritas intervensi. Dengan mengetahui masalah gizi yang paling dominan dan wilayah atau kelompok yang paling terdampak, pemerintah dapat menentukan fokus kebijakan yang efisien dan berdaya guna. Misalnya, apabila hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi anemia tinggi pada remaja putri di wilayah tertentu, maka prioritas program dapat diarahkan pada peningkatan edukasi gizi di sekolah dan distribusi tablet tambah darah (TTD).

Selanjutnya, hasil analisis digunakan dalam perancangan kebijakan dan strategi intervensi gizi. Data status gizi, pola konsumsi pangan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang terarah dan realistis. Contohnya, jika survei konsumsi menunjukkan rendahnya asupan sayur dan buah, maka strategi behavior change communication (BCC) dapat diperkuat melalui kampanye gizi seimbang dan peningkatan akses pangan lokal.

Hasil analisis juga digunakan untuk menyusun indikator keberhasilan program gizi dan sistem pemantauan (monitoring and evaluation). Melalui data baseline (awal) dan data tindak lanjut, dapat dilihat efektivitas program seperti penurunan stunting, peningkatan kadar hemoglobin, atau perubahan perilaku makan sehat.

Selain untuk kebutuhan perencanaan teknis, hasil analisis data gizi juga berperan penting dalam advokasi dan mobilisasi sumber daya. Data yang kuat dan berbasis bukti ilmiah menjadi alat yang efektif untuk meyakinkan pembuat kebijakan, mitra pembangunan, dan masyarakat tentang urgensi intervensi gizi. Misalnya, data peningkatan gizi buruk dapat digunakan untuk mengajukan dukungan anggaran tambahan, program bantuan pangan, atau kemitraan lintas sektor.

Dengan demikian, analisis dan interpretasi data gizi komunitas bukanlah tahap akhir dari proses surveilans gizi, melainkan fondasi utama bagi siklus perencanaan kebijakan dan intervensi gizi. Tanpa analisis yang tajam dan interpretasi yang kontekstual, data gizi hanya akan menjadi kumpulan angka tanpa makna praktis.

F. Kualitas, Etika, dan Validitas Data Gizi

Kualitas data merupakan aspek fundamental dalam setiap kegiatan penilaian dan surveilans gizi komunitas. Data yang baik tidak hanya harus lengkap dan akurat, tetapi juga valid, reliabel, serta dikumpulkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian dan sensitivitas sosial budaya masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat, keputusan kebijakan dan intervensi gizi sangat bergantung pada keandalan data yang diperoleh dari lapangan. Kesalahan dalam proses pengumpulan, pengukuran, atau pengolahan data dapat berakibat pada kesimpulan yang salah dan kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, menjaga mutu data, menerapkan standar etika, serta melakukan pengawasan dan audit secara berkala merupakan elemen penting dalam memastikan kredibilitas sistem informasi gizi.

1. Prinsip validitas, reliabilitas, dan akurasi data

Tiga prinsip utama yang menentukan kualitas data gizi adalah validitas, reliabilitas, dan akurasi:

a. Validitas data

Menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penilaian gizi, validitas sangat dipengaruhi oleh ketepatan instrumen pengukuran, metode pengumpulan data, serta kemampuan enumerator dalam mengikuti standar operasional prosedur. Misalnya, jika pengukuran tinggi badan dilakukan tanpa memperhatikan posisi tubuh yang benar atau alat yang digunakan tidak dikalibrasi, maka data yang dihasilkan tidak valid.

Validitas juga mencakup validitas internal (apakah hasil penelitian mencerminkan hubungan yang nyata antara variabel yang diteliti) dan validitas eksternal (apakah hasil dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas). Dalam survei gizi komunitas, menjaga validitas internal berarti memastikan bahwa

setiap data antropometri, biokimia, dan konsumsi makanan diambil sesuai protokol ilmiah.

b. Reliabilitas

Data berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Data dikatakan reliabel apabila hasil yang sama dapat diperoleh jika pengukuran dilakukan kembali dalam kondisi yang serupa. Misalnya, jika dua petugas berbeda mengukur berat badan seorang anak dan mendapatkan hasil yang hampir sama, maka data tersebut reliabel. Untuk mencapai reliabilitas tinggi, perlu adanya pelatihan enumerator, penggunaan alat ukur yang standar, dan pengawasan ketat di lapangan.

c. Akurasi data

di sisi lain, mengacu pada tingkat ketepatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Akurasi dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan acak (random error) dan kesalahan sistematis (systematic error). Kesalahan acak terjadi karena faktor kebetulan seperti gangguan lingkungan saat pengukuran, sedangkan kesalahan sistematis terjadi karena kesalahan prosedur yang terus berulang, seperti kalibrasi alat yang tidak tepat. Akurasi tinggi hanya dapat dicapai melalui kalibrasi rutin, pelatihan teknis, serta pengawasan berlapis terhadap proses pengumpulan data.

Secara keseluruhan, validitas, reliabilitas, dan akurasi saling berhubungan. Data yang valid tetapi tidak reliabel, atau sebaliknya, tetap tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, seluruh tahap surveilans gizi mulai dari desain, pengumpulan, hingga analisis harus direncanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini agar menghasilkan informasi yang benar-benar mencerminkan situasi gizi masyarakat.

2. Pertimbangan etika dalam pengumpulan data komunitas

Selain aspek teknis, pengumpulan data gizi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Etika dalam pengumpulan data komunitas memastikan bahwa kegiatan survei atau penelitian dilakukan dengan menghormati martabat, hak, dan privasi responden.

Salah satu prinsip utama adalah informed consent (persetujuan sadar). Sebelum data dikumpulkan, setiap responden harus mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tujuan, manfaat, risiko, serta prosedur pengumpulan data. Persetujuan harus diberikan secara sukarela tanpa paksaan, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk anak-anak, persetujuan harus diperoleh dari orang tua atau wali hukum.

Selain itu, kerahasiaan data (confidentiality) merupakan prinsip penting yang wajib dijaga. Informasi pribadi responden seperti nama, alamat, kondisi kesehatan, atau status gizi tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Data hanya digunakan untuk tujuan penelitian atau kebijakan publik dan disajikan dalam

bentuk agregat (tanpa identitas individu). Penggunaan kode atau nomor identifikasi anonim merupakan praktik umum untuk menjaga privasi responden.

Sensitivitas budaya (cultural sensitivity) juga harus diperhatikan, terutama dalam konteks masyarakat dengan latar belakang adat dan kepercayaan yang beragam. Enumerator perlu memahami nilai-nilai lokal, norma, dan kebiasaan makan masyarakat agar proses wawancara dan pengukuran berjalan dengan lancar. Misalnya, dalam beberapa budaya, perempuan mungkin tidak diperkenankan diperiksa oleh petugas laki-laki, sehingga penyesuaian tenaga lapangan perlu dilakukan. Sikap sopan, menghormati adat setempat, dan membangun kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengumpulan data.

Selain itu, dalam kasus pengumpulan data yang bersifat sensitif — seperti status anemia pada remaja putri atau gizi buruk pada anak — tenaga lapangan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan stigma sosial atau rasa malu pada responden. Etika profesional menuntut petugas untuk bersikap empatik, tidak menghakimi, dan selalu menempatkan kesejahteraan responden sebagai prioritas utama.

Dengan menjunjung tinggi etika penelitian, proses pengumpulan data gizi tidak hanya menghasilkan informasi yang valid, tetapi juga memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap kegiatan surveilans gizi.

Persetujuan responden, kerahasiaan data, dan sensitivitas budaya.

3. Pengawasan mutu surveilans dan audit data

Untuk memastikan kualitas data yang tinggi, diperlukan pengawasan mutu (quality control) dan audit data selama seluruh tahapan pelaksanaan surveilans. Pengawasan mutu dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga analisis, dengan tujuan untuk mencegah kesalahan teknis dan memastikan konsistensi hasil pengukuran.

Pengawasan mutu lapangan mencakup beberapa kegiatan penting, antara lain:

- a. Pelatihan enumerator dan tenaga pengumpul data. Sebelum turun ke lapangan, semua petugas harus mengikuti pelatihan teknis tentang penggunaan alat ukur antropometri, wawancara konsumsi pangan, serta pencatatan data. Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan keterampilan antarpetugas agar hasil pengukuran lebih seragam (inter-observer reliability).
- b. Standarisasi alat dan metode. Semua alat ukur seperti timbangan, mikrotolise, dan pita LILA harus dikalibrasi secara rutin sebelum dan selama kegiatan lapangan. Penggunaan formulir dan prosedur standar operasional juga wajib diterapkan.

- c. Supervisi lapangan (field supervision). Pengawas bertugas memeriksa kesesuaian pelaksanaan survei dengan prosedur, melakukan pengukuran ulang secara acak, dan memberikan umpan balik kepada enumerator apabila ditemukan kesalahan.

Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan audit data (data verification) untuk memastikan konsistensi antarvariabel dan mendeteksi adanya kesalahan entri atau anomali. Audit dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan perangkat lunak statistik yang memiliki fungsi validasi otomatis.

Proses monitoring dan evaluasi internal juga penting untuk menilai efisiensi pelaksanaan surveilans, termasuk aspek logistik, koordinasi tim, dan komunikasi antarpetugas. Jika ditemukan kesalahan sistemik (misalnya kesalahan dalam pengukuran tinggi badan di seluruh wilayah), langkah koreksi dan pelatihan ulang harus segera dilakukan sebelum survei berikutnya.

Selain itu, untuk meningkatkan keandalan sistem surveilans nasional, perlu dilakukan evaluasi eksternal (external audit) oleh lembaga independen atau pakar gizi yang berpengalaman. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas data yang dihasilkan telah memenuhi standar internasional serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Melalui penerapan sistem pengawasan mutu dan audit data yang terstruktur, kegiatan surveilans gizi dapat menghasilkan informasi yang kredibel dan layak dijadikan dasar kebijakan. Proses ini memastikan bahwa setiap data yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi gizi masyarakat dan dapat digunakan dengan percaya diri oleh pembuat kebijakan, peneliti, maupun praktisi lapangan.

G. Tantangan dan Inovasi dalam Surveilans Gizi Komunitas

Surveilans gizi komunitas merupakan komponen vital dalam sistem kesehatan masyarakat karena menyediakan data yang dibutuhkan untuk memahami, memantau, dan memperbaiki kondisi gizi suatu populasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan sistem. Tantangan tersebut meliputi aspek teknis, sumber daya manusia, manajemen data, hingga dukungan kebijakan. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan meningkatnya partisipasi masyarakat membuka peluang inovasi baru dalam memperkuat sistem surveilans gizi agar lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan.

1. Kendala lapangan dalam pelaksanaan surveilans gizi

Pelaksanaan surveilans gizi di lapangan menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kualitas data dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Di banyak daerah, jumlah tenaga gizi di puskesmas atau lembaga kesehatan

masyarakat masih terbatas, sehingga beban kerja dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data menjadi tinggi. Selain itu, pelatihan teknis enumerator dan kader posyandu sering kali belum memadai, sehingga menimbulkan variasi dalam hasil pengukuran dan kesalahan dalam pencatatan.

Kendala berikutnya adalah kesalahan pengukuran dan pencatatan data. Kesalahan ini dapat terjadi akibat alat ukur yang tidak dikalibrasi, teknik pengukuran yang tidak standar, atau ketidaktepatan petugas dalam mencatat hasil. Misalnya, kesalahan kecil dalam membaca tinggi badan anak dapat menghasilkan klasifikasi status gizi yang berbeda, seperti antara normal dan stunting. Kesalahan entri data juga sering terjadi dalam proses pelaporan manual yang masih menggunakan format kertas atau tabel rekapitulasi sederhana.

Selain itu, hambatan logistik dan geografis menjadi tantangan signifikan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Distribusi formulir, peralatan antropometri, serta bahan habis pakai seperti pita LILA sering kali terhambat akibat keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan pelaporan dan berkurangnya kualitas pemantauan gizi di daerah-daerah tersebut.

Tantangan lainnya datang dari kurangnya koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan sistem. Surveilans gizi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti sektor pendidikan, pertanian, dan pemerintahan daerah. Namun, koordinasi antarinstansi sering kali belum optimal. Banyak program gizi berhenti setelah proyek atau bantuan selesai karena tidak adanya sistem pendanaan dan kelembagaan yang berkelanjutan.

Selain itu, tantangan modern seperti perubahan pola konsumsi, urbanisasi, dan transisi gizi juga menambah kompleksitas pelaksanaan surveilans. Kini masyarakat tidak hanya menghadapi kekurangan gizi, tetapi juga kelebihan gizi dan penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi. Oleh karena itu, sistem surveilans harus mampu menyesuaikan diri dengan fenomena *double burden of malnutrition* (beban ganda gizi) yang semakin meningkat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas tenaga gizi, standarisasi alat ukur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dan pengolahan data.

2. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem surveilans gizi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas surveilans gizi. Digitalisasi sistem memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi antarlevel pemerintahan. Salah satu inovasi penting adalah pengembangan Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZI).

SIGIZI merupakan platform digital nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan data gizi dari berbagai sumber, seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan. Melalui sistem ini, data gizi dapat dikumpulkan secara real-time, dianalisis secara otomatis, dan disajikan dalam bentuk dashboard yang informatif. Keunggulan SIGIZI adalah kemampuannya untuk mempercepat proses pelaporan, mengurangi kesalahan input, serta mempermudah analisis tren dan pemetaan wilayah dengan masalah gizi tinggi (gizi burden mapping).

Selain SIGIZI, perkembangan aplikasi gizi elektronik (e-nutrition apps) juga mulai banyak digunakan di berbagai daerah. Aplikasi ini memudahkan petugas lapangan dalam mencatat hasil pengukuran antropometri, memantau pertumbuhan anak, serta memberikan rekomendasi gizi secara digital. Misalnya, aplikasi e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan memungkinkan kader posyandu menginput data berat dan tinggi badan anak secara langsung melalui gawai (smartphone), yang kemudian tersinkronisasi ke sistem pusat.

Selain itu, konsep mobile health (mHealth) juga menjadi terobosan penting dalam mendukung surveilans gizi. Melalui mHealth, komunikasi dan koordinasi antarpetugas lapangan dapat dilakukan dengan cepat menggunakan perangkat mobile. Petugas dapat menerima panduan pengukuran, mengirim foto hasil antropometri untuk verifikasi, serta mendapatkan umpan balik langsung dari supervisor.

Teknologi digital juga memfasilitasi analisis data berbasis spasial dan prediktif. Dengan bantuan Geographic Information System (GIS), peta gizi interaktif dapat dibuat untuk menampilkan distribusi masalah gizi seperti stunting atau anemia di berbagai daerah. Hal ini membantu pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas intervensi berdasarkan lokasi dan tingkat risiko.

Namun, pemanfaatan teknologi digital juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil, literasi digital yang rendah di kalangan petugas, serta kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pelatihan teknologi bagi tenaga lapangan dan penerapan standar keamanan data menjadi langkah penting agar transformasi digital dalam surveilans gizi dapat berjalan optimal dan beretika.

Aplikasi gizi elektronik, sistem informasi gizi terpadu (SIGIZI), dan mobile health (mHealth).

3. Pendekatan partisipatif berbasis masyarakat

Pendekatan partisipatif berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi inovatif dalam memperkuat keberlanjutan dan kemandirian surveilans gizi komunitas. Pendekatan ini menekankan peran aktif masyarakat, terutama kader

gizi dan tokoh lokal, dalam pengumpulan data, pemantauan, dan advokasi perbaikan gizi.

Salah satu bentuk nyata dari pendekatan ini adalah pemberdayaan kader gizi dan kader posyandu. Mereka merupakan ujung tombak dalam sistem surveilans karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui pelatihan dan pembinaan rutin, kader dapat melakukan penimbangan balita, mengisi data pertumbuhan, serta memberikan edukasi gizi dasar kepada ibu dan keluarga. Pendekatan berbasis kader ini terbukti efektif dalam menjangkau komunitas di tingkat akar rumput (*grassroots level*).

Selain pemberdayaan individu, muncul pula konsep posyandu digital, yaitu integrasi layanan posyandu dengan teknologi informasi. Dalam posyandu digital, pencatatan data dilakukan menggunakan tablet atau ponsel pintar yang terhubung dengan sistem online. Dengan cara ini, hasil pengukuran seperti berat badan, tinggi badan, dan status gizi anak langsung terekam dalam sistem nasional tanpa perlu penginputan ulang secara manual. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan atau duplikasi data.

Pendekatan partisipatif juga mencakup keterlibatan komunitas secara luas dalam pemantauan dan pengawasan gizi. Misalnya, kelompok masyarakat dapat dilibatkan dalam memantau distribusi makanan tambahan, program pemberian tablet tambah darah di sekolah, atau kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pencegahan penyakit infeksi. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program gizi, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas intervensi.

Selain itu, inovasi partisipatif juga dapat diwujudkan melalui komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Platform digital seperti aplikasi pengaduan masyarakat atau forum diskusi daring dapat digunakan untuk menampung aspirasi, keluhan, dan masukan terkait pelayanan gizi di lapangan. Dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, sistem surveilans gizi tidak hanya menjadi alat pengumpulan data, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial yang mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

H. Penutup

Penilaian dan surveilans gizi komunitas merupakan fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang berbasis bukti, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan penilaian yang komprehensif dan sistem surveilans yang berkesinambungan, pemerintah dan tenaga kesehatan memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi gizi masyarakat, baik dari segi status, tren, maupun faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Data tersebut menjadi alat strategis untuk

menetapkan prioritas kebijakan, menyusun intervensi yang efektif, serta mengevaluasi hasil program secara objektif.

Pelaksanaan penilaian dan surveilans gizi bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan komitmen moral dan sosial dalam menjamin hak masyarakat atas gizi yang layak dan kehidupan yang sehat. Di tengah tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan wilayah, dan kompleksitas masalah gizi yang kini mencakup beban ganda kekurangan dan kelebihan gizi sistem surveilans yang kuat menjadi sangat krusial untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang.

Perkembangan teknologi informasi, integrasi sistem digital seperti Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZI), serta pendekatan partisipatif berbasis masyarakat, menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem surveilans gizi nasional. Pemanfaatan aplikasi digital, mobile health, dan posyandu elektronik memungkinkan proses pengumpulan data menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat dan kader gizi di tingkat akar rumput memperkuat rasa kepemilikan serta memastikan keberlanjutan program di lapangan.

Namun demikian, keberhasilan penilaian dan surveilans gizi tetap bergantung pada kualitas data, integritas etika, dan kolaborasi lintas sektor. Validitas, reliabilitas, dan akurasi data harus dijaga melalui pelatihan berkelanjutan, pengawasan mutu, serta audit yang terstandar. Selain itu, seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data harus menghormati prinsip etika penelitian menjunjung tinggi hak, privasi, dan martabat responden.

Ke depan, penilaian dan surveilans gizi komunitas perlu diarahkan pada sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan, inklusif terhadap semua kelompok masyarakat, serta responsif terhadap krisis gizi dan pangan. Integrasi antara data gizi, kebijakan publik, dan aksi lintas sektor melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial akan memperkuat upaya nasional dalam mencapai ketahanan gizi dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dengan demikian, penilaian dan surveilans gizi komunitas tidak sekadar menjadi alat pemantauan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Melalui sistem gizi yang kuat, transparan, dan berbasis bukti, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Referensi

- Anderson, A. S., & Wrieden, W. L. (2018). *Community nutrition: Achieving sustainable health*. Routledge.
- Beaton, G. H., & Bengoa, J. M. (Eds.). (2020). *Nutrition in preventive medicine: The major deficiency syndromes, epidemiology, and approaches to control*. World Health Organization.
- Becker, W., & Welten, D. (2017). *Principles of nutritional assessment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Beiser, M., & Engle, P. L. (2021). *Community nutrition in action: An entrepreneurial approach* (9th ed.). Cengage Learning.
- Berg, A. (2020). *The nutrition factor: Its role in national development*. The Brookings Institution Press.
- Boeing, H., & Watzl, B. (2018). Nutritional epidemiology and public health. *Public Health Nutrition*, 21(3), 365–375. <https://doi.org/10.1017/S1368980017001996>
- Corella, D., & Ordovas, J. M. (2020). The role of nutrition surveillance and assessment in public health strategies. *Annual Review of Public Health*, 41(1), 1–23. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094244>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). *Guidelines for measuring household and individual dietary diversity*. FAO.
- Gibson, R. S. (2016). *Principles of nutritional assessment* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Habicht, J. P., Victora, C. G., & Vaughan, J. P. (2020). Evaluation designs for adequacy, plausibility, and probability of public health programme performance and impact. *International Journal of Epidemiology*, 28(1), 10–18.
- Hardinsyah, & Aries, M. (2016). *Ilmu gizi: Teori dan aplikasi*. EGC.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman surveilans gizi masyarakat*. Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021*. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- National Research Council. (2018). *Dietary reference intakes: The essential guide to nutrient requirements*. The National Academies Press.

- Notoatmodjo, S. (2014). Ilmu kesehatan masyarakat: Prinsip-prinsip dasar. Rineka Cipta.
- Pirie, P. L. (2018). Community-based surveillance in nutrition and health. *American Journal of Public Health*, 108(S2), 145–151. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304655>
- World Health Organization (WHO). (2013). Essential nutrition actions: Improving maternal, newborn, infant, and young child health and nutrition. WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2017). Nutrition surveillance systems: A guide for national implementation. WHO.
- World Health Organization (WHO). (2021). Global nutrition report: The state of nutrition in the world 2021. WHO.

BAB III

PROMOSI KESEHATAN DAN PERUBAHAN PERILAKU

A. Pendahuluan

Promosi kesehatan merupakan salah satu strategi utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan kesehatan modern, promosi kesehatan tidak lagi dipandang sekadar kegiatan penyuluhan atau pemberian informasi, tetapi sebagai proses pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan, motivasi, dan lingkungan yang mendukung untuk menerapkan perilaku hidup sehat secara berkelanjutan. Upaya ini menempatkan individu dan komunitas sebagai subjek utama dalam menjaga kesehatannya sendiri, bukan sekadar sebagai penerima layanan kesehatan. Dengan demikian, promosi kesehatan menjadi investasi sosial yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

1. Latar belakang pentingnya promosi kesehatan

Kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis atau pengobatan penyakit, melainkan juga oleh perilaku, gaya hidup, lingkungan, dan faktor sosial budaya yang memengaruhi kesejahteraan individu. Banyak penyakit yang mendominasi beban kesehatan global seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker, dan obesitas berakar dari perilaku yang tidak sehat seperti pola makan tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, serta stres kronis. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan demam berdarah juga sangat terkait dengan perilaku pencegahan yang kurang optimal di tingkat individu maupun masyarakat.

Dalam konteks ini, promosi kesehatan berperan sebagai pendekatan strategis untuk mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup sehat. Promosi kesehatan berfokus pada peningkatan kesadaran (*awareness*), peningkatan pengetahuan (*knowledge*), pembentukan sikap (*attitude*), dan penguatan tindakan (*practice*) agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui kegiatan edukasi kesehatan, kampanye publik, atau pemberdayaan masyarakat, individu dapat lebih memahami pentingnya imunisasi, pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, serta perilaku bersih dan sehat di lingkungan rumah dan sekolah.

Selain itu, promosi kesehatan juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung praktik hidup sehat. Hal ini sejalan dengan konsep Health

Promotion by the Ottawa Charter (WHO, 1986), yang menekankan bahwa upaya kesehatan harus dilakukan melalui penguatan kebijakan publik yang sehat, penciptaan lingkungan yang mendukung, pengembangan keterampilan individu, dan penguatan tindakan komunitas. Dengan demikian, promosi kesehatan berfungsi tidak hanya sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat.

Peran promosi kesehatan menjadi semakin penting di era modern, ketika perubahan gaya hidup dan industrialisasi membawa tantangan baru seperti meningkatnya penyakit tidak menular, stres psikologis, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, promosi kesehatan menjadi garda terdepan dalam mendorong masyarakat agar lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri melalui tindakan preventif dan perilaku proaktif menjaga keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual.

2. Tujuan promosi kesehatan dan perubahan perilaku

Tujuan utama dari promosi kesehatan adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat agar mampu mengontrol dan memperbaiki kesehatannya sendiri. Promosi kesehatan tidak hanya berorientasi pada perubahan pengetahuan, tetapi juga pada transformasi perilaku dan sistem sosial yang mendukung kehidupan sehat. Artinya, promosi kesehatan bertujuan agar masyarakat tidak hanya “tahu apa yang sehat,” tetapi juga “mau dan mampu melakukan tindakan yang sehat.”

Secara umum, promosi kesehatan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki literasi kesehatan tinggi (health literacy), yaitu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan secara tepat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan meningkatnya literasi kesehatan, diharapkan masyarakat dapat berperilaku secara sadar terhadap risiko penyakit, mengelola faktor-faktor yang memengaruhi kesehatannya, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan di lingkungannya.

Tujuan lainnya adalah mendorong perubahan perilaku individu dan kolektif menuju gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Perubahan perilaku ini dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, mulai dari penyuluhan langsung, media kampanye, pendidikan berbasis sekolah, hingga program komunitas. Misalnya, kampanye “Germas” (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di Indonesia merupakan implementasi nyata dari tujuan promosi kesehatan yang mengajak masyarakat untuk rutin beraktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur, memeriksa kesehatan secara berkala, serta menghindari perilaku berisiko seperti merokok dan konsumsi alkohol.

Selain sasaran individu, promosi kesehatan juga memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perilaku sehat. Hal ini mencakup kebijakan publik yang mendukung (seperti peraturan kawasan tanpa rokok, regulasi pangan sehat, dan kebijakan sanitasi), serta penguatan lembaga dan komunitas lokal yang berperan sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, promosi kesehatan diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang tidak hanya lebih sehat secara fisik, tetapi juga lebih sadar, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan kolektifnya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan promosi kesehatan antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, turunnya angka penyakit yang dapat dicegah melalui perilaku, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan, serta terbentuknya lingkungan sosial yang mendukung gaya hidup sehat. Pada akhirnya, promosi kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai modal dasar pembangunan nasional.

3. Hubungan promosi kesehatan dengan upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat

Promosi kesehatan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan upaya pencegahan penyakit (preventive efforts) dan pemberdayaan masyarakat. Ketiganya merupakan komponen penting dalam pendekatan kesehatan masyarakat modern yang berorientasi pada pencegahan daripada pengobatan.

Dalam konteks preventif, promosi kesehatan berperan dalam mendorong individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah timbulnya penyakit atau memperburuk kondisi kesehatan. Misalnya, promosi kesehatan melalui edukasi tentang pentingnya vaksinasi dapat mencegah penyakit menular, sementara kampanye tentang pola makan seimbang dan aktivitas fisik dapat menurunkan risiko penyakit tidak menular. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, promosi kesehatan memperkuat upaya pencegahan primer (menghindari penyakit), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat waktu), serta tersier (rehabilitasi dan pencegahan komplikasi).

Selain aspek pencegahan, promosi kesehatan juga berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Pemberdayaan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan di lingkungannya sendiri. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga kesehatan, tetapi mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengimplementasikan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan lokal mereka.

Contohnya, program posyandu, posbindu PTM, dan desa siaga merupakan bentuk nyata dari sinergi antara promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Hubungan antara promosi kesehatan, upaya preventif, dan pemberdayaan masyarakat juga tercermin dalam paradigma pembangunan kesehatan yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada perubahan struktur sosial dan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan sehat. Dengan mengedepankan prinsip *from the people, by the people, and for the people*, promosi kesehatan menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri.

Dalam konteks global, pendekatan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Melalui promosi kesehatan yang terintegrasi dengan upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan kesehatan dapat berjalan secara partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan.

B. Konsep Dasar Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya pencegahan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan, promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengubah perilaku serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sehat. Konsep ini menempatkan individu dan komunitas sebagai pusat dari perubahan, dengan prinsip dasar bahwa kesehatan tidak dapat diberikan begitu saja oleh tenaga medis, melainkan harus diupayakan, dipertahankan, dan ditingkatkan oleh masyarakat itu sendiri melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan.

1. Definisi dan ruang lingkup promosi kesehatan

Menurut World Health Organization (WHO, 1986) dalam Ottawa Charter for Health Promotion, promosi kesehatan didefinisikan sebagai “proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol terhadap, dan memperbaiki kesehatan mereka sendiri.” Definisi ini menegaskan bahwa promosi kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai sektor lain dan memerlukan pendekatan lintas disiplin. Dalam pengertian ini, promosi kesehatan berperan tidak sekadar mengedukasi masyarakat, melainkan

juga memberdayakan mereka untuk mampu mengambil keputusan yang sehat dan memengaruhi faktor-faktor penentu kesehatan di lingkungannya.

Ruang lingkup promosi kesehatan sangat luas dan meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat kapasitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat. Promosi kesehatan dapat dilakukan di berbagai tatanan, seperti di sekolah, tempat kerja, rumah sakit, komunitas, hingga tingkat kebijakan publik. Aktivitas ini dapat berbentuk penyuluhan, advokasi, pemberdayaan masyarakat, kampanye media, pelatihan keterampilan hidup sehat, hingga perubahan struktural melalui kebijakan kesehatan.

Selain pendekatan WHO, berbagai teori perilaku kesehatan masyarakat juga menjelaskan bahwa promosi kesehatan berakar pada perubahan perilaku individu dan kolektif. Teori-teori tersebut, seperti Health Belief Model (HBM), Social Cognitive Theory (SCT), dan Theory of Planned Behavior (TPB), menekankan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh keyakinan, persepsi risiko, pengalaman, dukungan sosial, serta niat seseorang untuk bertindak. Dengan demikian, promosi kesehatan harus dirancang berdasarkan pemahaman ilmiah tentang bagaimana perilaku manusia terbentuk dan bagaimana intervensi dapat memengaruhi keputusan untuk hidup sehat.

Promosi kesehatan juga memiliki dimensi struktural yang mencakup kebijakan publik, lingkungan sosial, dan sistem pelayanan kesehatan yang mendukung. Misalnya, kampanye anti-rokok tidak akan efektif tanpa adanya kebijakan pembatasan iklan rokok, area bebas asap rokok, dan layanan berhenti merokok. Oleh karena itu, promosi kesehatan bersifat multidimensi—menggabungkan pendekatan edukatif, sosial, dan kebijakan—agar dapat mengubah perilaku sekaligus menguatkan sistem dan lingkungan yang sehat.

Dengan kata lain, promosi kesehatan tidak hanya berbicara tentang “apa yang harus dilakukan masyarakat untuk sehat,” tetapi juga tentang “bagaimana lingkungan, sistem, dan kebijakan dapat mendukung masyarakat untuk melakukan perilaku sehat.”

2. Prinsip-prinsip promosi kesehatan

Promosi kesehatan dilandasi oleh sejumlah prinsip universal yang menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan berorientasi pada pemberdayaan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Lima prinsip utama yang menjadi fondasi promosi kesehatan adalah partisipasi, pemberdayaan, kesetaraan, keberlanjutan, dan intersektoralisme.

a. Partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan kunci utama keberhasilan promosi kesehatan. Program kesehatan yang bersifat top-down sering kali gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan melibatkan masyarakat, rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program akan meningkat, sehingga mereka lebih berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut.

b. Pemberdayaan (*empowerment*).

Pemberdayaan berarti memberikan kemampuan dan kesempatan kepada individu maupun komunitas untuk mengambil keputusan dan tindakan yang memengaruhi kesehatannya. Promosi kesehatan tidak dimaksudkan untuk “mengajari” masyarakat secara satu arah, tetapi untuk membangun kesadaran kritis dan kemampuan mandiri. Contohnya adalah pelatihan kader posyandu atau fasilitator kesehatan masyarakat yang dapat menjadi agen perubahan di tingkat lokal. Dengan pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi objek program kesehatan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menciptakan solusi atas masalah kesehatannya sendiri.

c. Kesetaraan (*equity*).

Prinsip kesetaraan menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh akses terhadap informasi, sumber daya, dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Promosi kesehatan harus memperhatikan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas yang sering kali terpinggirkan dari sistem kesehatan. Kesetaraan juga berarti memperlakukan masyarakat dengan adil sesuai kebutuhannya, bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang.

d. Keberlanjutan (*sustainability*).

Program promosi kesehatan harus dirancang agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal ini hanya dapat dicapai jika masyarakat merasa memiliki program tersebut dan mendapatkan manfaat nyata. Pendekatan keberlanjutan menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi serta integrasi kegiatan promosi kesehatan ke dalam kebijakan dan struktur masyarakat. Misalnya, program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tidak boleh berhenti pada kegiatan kampanye sesaat, tetapi harus menjadi bagian dari budaya masyarakat dan kebijakan daerah.

e. Intersektoralisme (*intersectoral collaboration*).

Kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Banyak faktor penentu kesehatan yang berada di luar bidang medis, seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, transportasi, dan perumahan. Oleh karena itu, promosi kesehatan membutuhkan kerja sama lintas sektor—antara pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, media, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor menciptakan sinergi dalam menciptakan kebijakan publik yang sehat (healthy public policy), seperti pengaturan keamanan pangan, tata ruang kota sehat, dan perlindungan lingkungan.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan

Perilaku kesehatan masyarakat tidak terbentuk secara spontan, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individu, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan publik. Untuk memahami bagaimana masyarakat berperilaku terhadap kesehatannya, perlu dilihat secara menyeluruh faktor-faktor yang memengaruhinya.

- a. Faktor individu mencakup aspek biologis, psikologis, dan kognitif seseorang. Pengetahuan, kepercayaan, persepsi risiko, dan motivasi individu berperan besar dalam menentukan apakah seseorang mau berperilaku sehat atau tidak. Misalnya, seseorang yang memahami risiko merokok terhadap kanker paru-paru memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhenti merokok dibandingkan dengan yang tidak menyadarinya. Selain itu, faktor kepribadian, emosi, serta pengalaman masa lalu juga turut membentuk kebiasaan kesehatan seseorang.
- b. Faktor sosial dan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kesehatan. Lingkungan keluarga, teman sebaya, tempat kerja, serta komunitas tempat seseorang tinggal dapat menentukan sejauh mana individu menerapkan perilaku hidup sehat. Misalnya, anak yang tumbuh di keluarga dengan kebiasaan makan sayur dan buah akan lebih cenderung menerapkan pola makan sehat di masa dewasa. Lingkungan sosial yang mendukung seperti komunitas olahraga atau tempat kerja yang menyediakan fasilitas kebugaran juga meningkatkan peluang seseorang untuk beraktivitas fisik secara rutin.
- c. Faktor ekonomi juga berperan penting. Kemampuan finansial memengaruhi akses seseorang terhadap makanan bergizi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan kesehatan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang atau mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin, sehingga berisiko lebih tinggi terhadap penyakit menular dan tidak menular. Oleh karena itu, promosi kesehatan harus mempertimbangkan kesenjangan ekonomi dan memastikan intervensi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu.

- d. Faktor budaya tidak kalah penting dalam menentukan perilaku kesehatan. Nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi lokal sering kali membentuk cara pandang masyarakat terhadap kesehatan, penyakit, dan pengobatan. Misalnya, beberapa masyarakat masih mempercayai mitos tertentu seperti larangan makan ikan saat hamil atau anggapan bahwa imunisasi dapat menyebabkan sakit. Promosi kesehatan yang tidak sensitif terhadap budaya justru dapat menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, pendekatan budaya (cultural approach) menjadi penting agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik.
- e. Faktor kebijakan dan lingkungan makro merupakan konteks yang lebih luas yang memengaruhi perilaku individu maupun komunitas. Kebijakan publik yang mendukung, seperti pajak rokok, regulasi makanan cepat saji, atau pengaturan kawasan tanpa asap rokok, dapat mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat. Sebaliknya, ketiadaan kebijakan yang berpihak pada kesehatan justru dapat memperburuk kebiasaan tidak sehat. Contohnya, ketersediaan iklan makanan tidak sehat di media dapat mendorong konsumsi berlebihan terutama di kalangan anak-anak.

C. Teori dan Model Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku kesehatan tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam promosi kesehatan, teori dan model perubahan perilaku digunakan sebagai kerangka ilmiah untuk memahami mengapa seseorang berperilaku tertentu, serta bagaimana strategi intervensi dapat dirancang agar efektif dalam mengubah perilaku menuju arah yang lebih sehat. Teori-teori ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan konseptual, tetapi juga menjadi dasar praktis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan di masyarakat.

Secara umum, teori perubahan perilaku terbagi menjadi tiga kelompok besar: teori perilaku individu, teori pembelajaran sosial dan lingkungan, serta model komunikasi perubahan perilaku. Ketiganya saling melengkapi dalam membantu tenaga kesehatan memahami dinamika perubahan perilaku manusia secara menyeluruh.

1. Teori perilaku kesehatan individu

Teori perilaku kesehatan individu berfokus pada faktor-faktor psikologis yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan kesehatan. Tiga teori utama yang sering digunakan dalam promosi kesehatan adalah Health Belief Model (HBM), Theory of Planned Behavior (TPB), dan Transtheoretical Model (Stages of Change).

a. Health Belief Model (HBM)

Health Belief Model dikembangkan oleh Rosenstock (1950-an) untuk menjelaskan mengapa individu enggan melakukan tindakan pencegahan kesehatan, seperti vaksinasi atau pemeriksaan dini penyakit. Model ini berasumsi bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh persepsi subjektifnya terhadap penyakit dan manfaat tindakan pencegahan.

Terdapat enam komponen utama dalam HBM:

- 1) Perceived susceptibility (kerentanan yang dirasakan): sejauh mana individu merasa dirinya berisiko terkena suatu penyakit.
- 2) Perceived severity (keseriusan yang dirasakan): tingkat keyakinan seseorang tentang konsekuensi serius dari penyakit tersebut.
- 3) Perceived benefits (manfaat yang dirasakan): keyakinan bahwa tindakan tertentu (misalnya olahraga, vaksinasi) akan mengurangi risiko atau dampak penyakit.
- 4) Perceived barriers (hambatan yang dirasakan): faktor-faktor yang menghalangi individu untuk bertindak, seperti biaya, waktu, atau rasa takut.
- 5) Cues to action (isyarat untuk bertindak): rangsangan eksternal seperti kampanye media, anjuran dokter, atau pengalaman pribadi yang memicu tindakan kesehatan.
- 6) Self-efficacy (efikasi diri): keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku kesehatan yang diinginkan.

Sebagai contoh, dalam promosi vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks, individu yang merasa dirinya rentan terhadap penyakit (susceptibility tinggi), memahami konsekuensi serius kanker (severity tinggi), percaya bahwa vaksin efektif (benefit tinggi), memiliki sedikit hambatan (barrier rendah), dan merasa mampu mengambil tindakan (self-efficacy tinggi), akan lebih cenderung mengikuti vaksinasi.

b. Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1985) sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action. TPB menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan prediktor paling kuat dari tindakan yang sebenarnya dilakukan. Niat tersebut terbentuk melalui tiga komponen utama:

- 1) Attitude toward behavior (sikap terhadap perilaku): evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku tersebut.
- 2) Subjective norm (norma subjektif): persepsi tentang tekanan sosial atau ekspektasi orang lain yang signifikan (seperti keluarga, teman, atau tokoh masyarakat).

- 3) Perceived behavioral control (kontrol perilaku yang dirasakan): sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan perilaku tersebut.

Sebagai contoh, dalam kampanye berhenti merokok, seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap merokok (menyadari dampak buruknya), mendapat dukungan sosial dari keluarga untuk berhenti, dan merasa mampu mengatasi kecanduan nikotin, akan memiliki niat kuat untuk berhenti dan akhirnya benar-benar melakukannya.

c. **Transtheoretical Model (Stages of Change)**

Model ini dikembangkan oleh Prochaska dan DiClemente (1983) dan menjelaskan bahwa perubahan perilaku merupakan proses bertahap yang melibatkan kesiapan individu untuk berubah. Ada lima tahap utama dalam model ini:

- 1) Precontemplation: individu belum menyadari bahwa perilakunya berisiko dan belum berniat untuk berubah.
- 2) Contemplation: individu mulai menyadari masalah dan mempertimbangkan untuk berubah.
- 3) Preparation: individu berencana untuk melakukan perubahan dalam waktu dekat.
- 4) Action: individu mulai melakukan perubahan perilaku.
- 5) Maintenance: individu mempertahankan perilaku baru dan mencegah kekambuhan.

Model ini sering digunakan dalam intervensi seperti program berhenti merokok, diet sehat, atau peningkatan aktivitas fisik. Tenaga promosi kesehatan harus menyesuaikan strategi intervensinya dengan tahap perubahan yang sedang dialami individu. Misalnya, pada tahap precontemplation, fokusnya adalah meningkatkan kesadaran, sedangkan pada tahap maintenance, fokusnya pada dukungan dan pemeliharaan motivasi.

2. Teori pembelajaran sosial dan lingkungan

Selain faktor individu, perilaku kesehatan juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Dua teori yang banyak digunakan dalam memahami pengaruh tersebut adalah Social Cognitive Theory (SCT) dan Ecological Model of Health Behavior.

a. **Social Cognitive Theory (Bandura)**

Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura (1986) dan berlandaskan pada prinsip bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai reciprocal determinism.

Komponen utama SCT meliputi:

- 1) Observational learning (pembelajaran melalui pengamatan): individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain (model), seperti meniru gaya hidup sehat teman atau tokoh masyarakat.
- 2) Self-efficacy: keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengubah perilaku.
- 3) Outcome expectations: keyakinan bahwa suatu tindakan akan menghasilkan hasil yang diinginkan.
- 4) Reinforcement: penguatan positif (seperti pujian, dukungan sosial) yang memperkuat perilaku sehat.

Contohnya dapat dilihat pada program “Kampung Bebas Asap Rokok”, di mana individu yang melihat tetangganya berhasil berhenti merokok dan mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama.

b. Ecological Model of Health Behavior

Model ekologi menjelaskan bahwa perilaku kesehatan tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh berbagai lapisan pengaruh yang saling berinteraksi. Lapisan-lapisan tersebut meliputi:

- 1) Individu: pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pribadi.
- 2) Interpersonal: pengaruh keluarga, teman, dan rekan kerja.
- 3) Organisasi: kebijakan dan budaya di tempat kerja atau sekolah.
- 4) Komunitas: norma sosial dan jaringan dukungan di tingkat masyarakat.
- 5) Kebijakan publik: undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang memengaruhi kesehatan.

Sebagai contoh, untuk mengatasi obesitas, pendekatan model ekologi mencakup edukasi individu tentang gizi seimbang, dukungan keluarga untuk berolahraga, penyediaan fasilitas olahraga di sekolah atau kantor, kampanye masyarakat tentang gaya hidup aktif, serta kebijakan pemerintah terkait pajak minuman manis atau label gizi pada produk pangan.

Model ekologi menekankan pentingnya intervensi lintas level, karena perubahan perilaku yang berkelanjutan hanya akan terjadi jika lingkungan sosial dan kebijakan mendukung perilaku sehat.

3. Model komunikasi untuk perubahan perilaku

Komunikasi merupakan elemen vital dalam promosi kesehatan karena berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi sikap, dan memotivasi tindakan. Terdapat tiga bentuk utama komunikasi dalam perubahan perilaku, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa.

- 1) Komunikasi interpersonal melibatkan interaksi langsung antara tenaga kesehatan dan individu, seperti konseling gizi atau penyuluhan tatap muka. Bentuk komunikasi ini efektif karena memungkinkan umpan balik langsung dan hubungan personal yang kuat.
- 2) Komunikasi kelompok digunakan untuk menjangkau beberapa orang secara bersamaan, misalnya melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion), pertemuan kader posyandu, atau pelatihan komunitas. Melalui diskusi kelompok, masyarakat dapat saling bertukar pengalaman dan memperkuat motivasi bersama.
- 3) Komunikasi massa memanfaatkan media seperti televisi, radio, media sosial, atau poster kampanye untuk menjangkau populasi yang lebih luas. Pesan yang disampaikan melalui media massa harus dirancang dengan memperhatikan aspek budaya, bahasa lokal, dan karakteristik audiens agar efektif.

Dalam praktiknya, strategi komunikasi yang efektif sering kali menggabungkan ketiga pendekatan ini secara terpadu. Misalnya, kampanye “Cuci Tangan Pakai Sabun” menggunakan media massa untuk meningkatkan kesadaran publik, pelatihan kelompok untuk kader sekolah, dan konseling interpersonal oleh petugas kesehatan untuk memperkuat praktik di tingkat keluarga.

4. Penerapan teori dalam praktik promosi kesehatan

Teori dan model perubahan perilaku menjadi dasar ilmiah dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai program promosi kesehatan. Setiap teori dapat digunakan sesuai dengan konteks dan sasaran intervensi.

Sebagai contoh, dalam program gizi, teori Health Belief Model dapat digunakan untuk memahami mengapa ibu balita enggan memberikan makanan bergizi. Petugas kesehatan dapat meningkatkan persepsi manfaat gizi seimbang melalui edukasi, sekaligus mengurangi hambatan dengan menyediakan bahan makanan lokal yang terjangkau.

Dalam program sanitasi, Social Cognitive Theory dapat digunakan untuk membangun perilaku buang air besar di jamban sehat. Ketika masyarakat melihat tetangga mereka menggunakan fasilitas sanitasi dengan baik dan mendapatkan dukungan sosial, mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama.

Sementara itu, pada program kesehatan reproduksi remaja, Theory of Planned Behavior dapat diterapkan untuk memahami niat dan perilaku remaja dalam mencegah perilaku seksual berisiko. Melalui pembentukan sikap positif, dukungan sosial dari teman dan orang tua, serta peningkatan kepercayaan diri remaja dalam mengambil keputusan yang sehat, perilaku aman dapat ditingkatkan.

Pendekatan berbasis teori juga penting dalam evaluasi program. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku, promotor kesehatan dapat menilai apakah intervensi berhasil mengubah keyakinan, niat, atau tindakan individu dan masyarakat.

D. Strategi dan Pendekatan Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya bertumpu pada pemberian informasi atau pendidikan, tetapi juga melibatkan upaya sistematis untuk mengubah perilaku individu, memperkuat kapasitas masyarakat, dan membentuk lingkungan sosial serta kebijakan publik yang mendukung kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi dan pendekatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

WHO (World Health Organization) melalui Ottawa Charter for Health Promotion (1986) menegaskan bahwa promosi kesehatan harus dilakukan melalui lima strategi utama: pengembangan kebijakan publik yang sehat, penciptaan lingkungan yang mendukung, penguatan tindakan komunitas, pengembangan keterampilan individu, dan reorientasi layanan kesehatan.

Dalam konteks nasional, strategi promosi kesehatan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang umum digunakan meliputi pendekatan edukatif, partisipatif, advokasi kebijakan, serta pendekatan berbasis lingkungan dan sosial.

1. Pendekatan edukatif dan komunikasi informasi

Pendekatan edukatif dan komunikasi informasi merupakan strategi dasar dalam promosi kesehatan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu maupun masyarakat dalam menjaga kesehatan. Melalui proses pendidikan kesehatan yang terstruktur dan penyampaian informasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat mengubah sikap serta menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kesehatan adalah proses belajar yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok agar lebih sadar, mau, dan mampu melaksanakan tindakan kesehatan. Kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai tatanan, seperti sekolah, tempat kerja, puskesmas, atau komunitas. Misalnya, program pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah membantu siswa memahami pentingnya perilaku seksual yang bertanggung jawab, sedangkan penyuluhan tentang gizi seimbang di posyandu meningkatkan kesadaran ibu terhadap pola makan sehat anak.

Kampanye publik juga menjadi sarana penting dalam pendekatan edukatif. Kampanye dilakukan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan

menanamkan pesan kesehatan secara masif, seperti kampanye “GERMAS” (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), “Cuci Tangan Pakai Sabun”, atau “Ayo Imunisasi Lengkap”. Keberhasilan kampanye publik sangat bergantung pada kreativitas pesan, keterlibatan tokoh masyarakat, serta konsistensi penyampaian pesan di berbagai media.

Selain itu, penggunaan media massa memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan mempercepat penyebaran pesan kesehatan. Media seperti televisi, radio, koran, media sosial, dan platform digital menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi pengetahuan dan sikap masyarakat. Misalnya, iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok dengan visual yang kuat dapat meningkatkan persepsi risiko dan mendorong individu untuk berhenti merokok.

Namun, komunikasi dalam promosi kesehatan tidak boleh bersifat satu arah. Pendekatan komunikasi yang efektif harus bersifat interaktif dan kontekstual, mempertimbangkan karakteristik audiens, budaya, serta bahasa lokal. Penggunaan komunikasi interpersonal, seperti konseling tatap muka atau diskusi kelompok kecil, dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.

Dengan demikian, pendekatan edukatif dan komunikasi informasi berperan sebagai dasar untuk membangun kesadaran, menumbuhkan motivasi, dan memicu perubahan perilaku yang mendukung kesehatan masyarakat.

2. Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat

Pendekatan partisipatif merupakan strategi promosi kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek penerima program. Prinsip dasarnya adalah bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengenali serta memecahkan masalah kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, promosi kesehatan yang efektif harus dilakukan dengan masyarakat, bukan untuk masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat dimulai dengan melibatkan mereka sejak tahap awal, yaitu identifikasi masalah kesehatan yang dirasakan. Pendekatan ini menekankan konsep bottom-up, di mana kebutuhan dan prioritas ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, bukan hanya oleh lembaga kesehatan. Setelah masalah diidentifikasi, masyarakat didorong untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan kesehatan yang relevan, seperti pembentukan kelompok sadar gizi, pengelolaan posyandu mandiri, atau program sanitasi berbasis masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif, masyarakat memperoleh keterampilan baru dan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dijalankan. Hal ini

menjamin keberlanjutan program kesehatan, karena masyarakat akan lebih berkomitmen untuk mempertahankan perubahan yang telah dicapai. Misalnya, keberhasilan program “Desa Siaga” atau “Kampung KB” tidak lepas dari partisipasi aktif warga dalam mengelola kegiatan kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan lingkungan.

Pendekatan partisipatif juga memperkuat kapasitas sosial komunitas. Dengan meningkatkan solidaritas, kolaborasi, dan kepemimpinan lokal, masyarakat dapat membangun sistem dukungan sosial yang kuat. Dalam konteks ini, kader kesehatan, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (change agent) yang menjembatani masyarakat dengan tenaga profesional kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menghasilkan peningkatan perilaku sehat individu, tetapi juga menciptakan kemandirian komunitas dalam mengelola kesehatan, yang pada akhirnya memperkuat sistem kesehatan nasional dari akar rumput.

3. Pendekatan advokasi dan kebijakan kesehatan publik

Pendekatan advokasi merupakan strategi penting dalam promosi kesehatan yang berorientasi pada perubahan kebijakan, sistem, dan struktur sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Advokasi bertujuan untuk membangun dukungan politik, sosial, dan ekonomi dari berbagai pihak agar kebijakan yang berpihak pada kesehatan dapat diterapkan dan dipertahankan.

Advokasi dilakukan melalui upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, pemimpin opini, dan masyarakat luas agar mereka memahami pentingnya isu kesehatan tertentu serta bersedia mengambil tindakan yang mendukung. Contohnya adalah advokasi untuk penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pengaturan iklan makanan tidak sehat bagi anak, atau kebijakan pengendalian minuman beralkohol.

Dalam praktiknya, advokasi memerlukan strategi komunikasi yang kuat, data ilmiah yang valid, serta pendekatan yang diplomatis dan kolaboratif. Tenaga promosi kesehatan harus mampu menyajikan bukti ilmiah tentang dampak masalah kesehatan (misalnya beban ekonomi akibat rokok), sekaligus menunjukkan manfaat sosial dan politik dari kebijakan yang diusulkan.

Selain memengaruhi kebijakan formal, advokasi juga berperan dalam membangun dukungan sosial dari berbagai sektor. Keterlibatan organisasi nonpemerintah (LSM), media, akademisi, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat tekanan publik agar pemerintah dan lembaga terkait bertindak proaktif dalam memperbaiki kondisi kesehatan.

Pendekatan ini sangat penting karena banyak faktor penentu kesehatan yang berada di luar kendali individu, seperti lingkungan, regulasi, dan sistem ekonomi. Dengan mengubah kebijakan publik menjadi lebih sehat, promosi kesehatan tidak hanya berdampak pada perilaku individu, tetapi juga menciptakan perubahan struktural yang melindungi kesehatan masyarakat secara luas.

Sebagai contoh, kebijakan wajib helm untuk pengendara motor, peraturan label gizi pada kemasan pangan, dan pajak rokok adalah hasil nyata dari keberhasilan advokasi dalam bidang kesehatan publik.

4. Pendekatan lingkungan dan kebijakan sosial

Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku sehat tidak akan bertahan lama tanpa adanya lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang dimaksud mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan yang secara kolektif menciptakan kondisi yang memudahkan individu untuk memilih perilaku sehat.

Konsep ini dikenal dengan istilah *health-supportive environment* atau *enabling environment*. Tujuannya adalah menciptakan sistem dan tatanan sosial yang memfasilitasi hidup sehat, bukan sebaliknya.

Sebagai contoh, pembangunan sekolah sehat meliputi penyediaan air bersih, kantin dengan makanan bergizi, sarana cuci tangan, serta edukasi kesehatan bagi siswa. Tempat kerja sehat menyediakan lingkungan yang aman, bebas asap rokok, memiliki fasilitas olahraga, serta program kesehatan bagi karyawan. Sementara itu, kota sehat (*Healthy City*) mencerminkan integrasi antara kebijakan lingkungan, transportasi, tata ruang, dan pelayanan publik yang memperhatikan aspek kesehatan warga.

Pendekatan lingkungan juga mencakup kebijakan sosial yang mendukung perilaku sehat. Misalnya, kebijakan subsidi pangan sehat bagi masyarakat miskin, pengendalian pencemaran udara, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dalam konteks ini, promosi kesehatan tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan, tetapi juga tanggung jawab lintas sektor seperti pendidikan, perumahan, transportasi, dan lingkungan hidup.

Lingkungan yang mendukung memungkinkan individu untuk menerapkan perilaku sehat tanpa harus menghadapi hambatan besar. Misalnya, masyarakat lebih mudah bersepeda jika tersedia jalur khusus sepeda dan udara yang bersih. Dengan demikian, perubahan perilaku tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab individu, tetapi menjadi hasil dari sinergi antara kebijakan publik, budaya sosial, dan lingkungan yang kondusif.

E. Metode dan Media Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan merupakan kegiatan yang berorientasi pada perubahan perilaku individu dan masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan metode dan media yang tepat, agar pesan kesehatan dapat diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh sasaran dengan efektif. Metode promosi kesehatan bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sarana membangun kesadaran, motivasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

Pemilihan metode dan media promosi kesehatan harus memperhatikan konteks sosial, budaya, tingkat pendidikan, serta karakteristik sasaran audiens. Pendekatan yang digunakan dapat bersifat individual, kelompok, masyarakat, maupun institusional, dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik tradisional maupun modern. Berikut ini penjelasan mendalam mengenai metode dan media yang digunakan dalam kegiatan promosi kesehatan.

1. Metode promosi kesehatan berbasis individu dan kelompok

Metode berbasis individu dan kelompok merupakan pendekatan yang berfokus pada interaksi langsung antara tenaga kesehatan dengan sasaran, baik secara personal maupun dalam kelompok kecil. Pendekatan ini dinilai efektif untuk memengaruhi sikap dan perilaku karena memungkinkan adanya komunikasi dua arah dan umpan balik langsung.

a. Konseling individu

Konseling merupakan metode promosi kesehatan yang dilakukan melalui komunikasi interpersonal antara tenaga kesehatan dan individu untuk membantu mengidentifikasi masalah, memahami risikonya, dan menemukan solusi yang sesuai. Proses konseling bersifat personal, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Contohnya adalah konseling gizi untuk ibu hamil yang mengalami anemia, konseling berhenti merokok di puskesmas, atau konseling psikologis bagi remaja yang mengalami stres.

Keberhasilan konseling bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan dalam membangun kepercayaan, mendengarkan secara aktif, dan memberikan rekomendasi yang realistis sesuai kondisi klien.

b. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD)

FGD merupakan metode yang digunakan untuk menggali persepsi, pengetahuan, sikap, dan pengalaman sekelompok orang terhadap suatu isu kesehatan. Diskusi ini melibatkan 6–12 peserta dengan fasilitator yang berperan mengarahkan jalannya percakapan.

FGD efektif untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat, mengumpulkan ide solusi, serta menumbuhkan kesadaran kolektif. Misalnya,

dalam program pencegahan stunting, FGD dapat digunakan untuk menggali persepsi ibu-ibu tentang praktik pemberian makan bayi dan anak.

Selain itu, metode ini juga berfungsi sebagai wadah komunikasi sosial untuk memperkuat dukungan antaranggota kelompok dalam mengubah perilaku.

c. Pelatihan komunitas

Pelatihan komunitas adalah metode pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis. Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk lokakarya atau simulasi, di mana peserta dilatih untuk melakukan tindakan kesehatan tertentu secara mandiri.

Contohnya, pelatihan kader posyandu tentang deteksi dini gizi buruk, pelatihan pengelolaan limbah rumah tangga bagi masyarakat, atau pelatihan remaja sekolah mengenai kesehatan reproduksi.

Pelatihan semacam ini bukan hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga membentuk agent of change di masyarakat yang mampu menularkan pengetahuan dan perilaku sehat kepada orang lain.

Pendekatan berbasis individu dan kelompok memiliki keunggulan karena lebih personal, komunikatif, dan mampu menggali kebutuhan sasaran secara mendalam. Namun, metode ini memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjangkau populasi yang luas.

2. Metode promosi kesehatan berbasis masyarakat dan institusi

Pendekatan ini berfokus pada upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perubahan perilaku sehat melalui kegiatan di tingkat komunitas maupun institusi. Promosi kesehatan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada kelompok masyarakat di tempat mereka beraktivitas sehari-hari.

a. Kegiatan posyandu dan komunitas kesehatan

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk nyata promosi kesehatan berbasis masyarakat di Indonesia. Melalui kegiatan rutin seperti penimbangan balita, penyuluhan gizi, imunisasi, dan konsultasi kesehatan, posyandu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat terutama ibu dan anak.

Selain posyandu, kegiatan berbasis komunitas lainnya seperti desa siaga sehat, bank sampah, dan kampung bebas rokok juga merupakan contoh keberhasilan promosi kesehatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

b. Sekolah sebagai tatanan promosi kesehatan

Sekolah merupakan institusi strategis dalam membentuk perilaku hidup sehat sejak dini. Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peserta didik

diajarkan tentang kebersihan diri, gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan pentingnya olahraga.

Selain itu, pembiasaan perilaku sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan lingkungan kelas, dan membawa bekal sehat menjadi bagian dari upaya membentuk budaya sekolah sehat (Health Promoting School).

c. Tempat kerja sehat (Workplace Health Promotion)

Lingkungan kerja merupakan tempat yang potensial untuk promosi kesehatan bagi orang dewasa. Program seperti pemeriksaan kesehatan rutin, edukasi pencegahan penyakit tidak menular, dan kebijakan area bebas rokok di kantor berperan dalam menjaga produktivitas serta menurunkan risiko penyakit akibat kerja.

Contohnya, perusahaan yang menerapkan program employee wellness—menyediakan fasilitas olahraga dan pemeriksaan kesehatan berkala—mendukung karyawan untuk hidup lebih sehat dan bahagia.

d. Media komunitas lokal

Promosi kesehatan berbasis masyarakat juga dapat memanfaatkan media lokal seperti radio komunitas, papan informasi desa, pertunjukan seni tradisional, atau kegiatan sosial seperti lomba kebersihan lingkungan. Pendekatan ini lebih mudah diterima masyarakat karena menggunakan bahasa dan konteks budaya setempat.

Pendekatan berbasis masyarakat dan institusi sangat penting untuk memperluas jangkauan promosi kesehatan dan memastikan pesan-pesan kesehatan terintegrasi dalam kehidupan sosial sehari-hari.

3. Media promosi kesehatan

Media promosi kesehatan berfungsi sebagai alat bantu untuk memperkuat penyampaian pesan dan meningkatkan daya tarik komunikasi. Pemilihan media yang tepat dapat menentukan keberhasilan kampanye promosi kesehatan. Jenis media yang umum digunakan meliputi:

a. Media cetak

Media ini meliputi brosur, leaflet, poster, banner, majalah kesehatan, dan buku panduan. Keunggulannya adalah mudah diproduksi, relatif murah, dan dapat digunakan berulang kali. Poster dengan visual menarik dan pesan singkat seperti “Cuci Tangan Pakai Sabun” atau “Stop Merokok” efektif untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

b. Media audio-visual

Televisi, radio, film dokumenter, dan video edukatif merupakan media yang mampu menggabungkan elemen suara dan gambar sehingga lebih menarik

dan mudah diingat. Misalnya, iklan layanan masyarakat tentang bahaya hipertensi di televisi dapat menjangkau masyarakat luas dan memotivasi mereka untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin.

c. Media digital dan media sosial

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma promosi kesehatan. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan WhatsApp kini menjadi sarana utama penyebaran pesan kesehatan, terutama bagi generasi muda.

Kampanye digital memungkinkan interaksi dua arah antara penyuluh kesehatan dan masyarakat. Misalnya, Kementerian Kesehatan menggunakan media sosial untuk kampanye #CegahStunting dan #AyoCuciTangan, yang menggabungkan pesan edukatif dengan konten visual menarik dan interaktif.

d. Teknologi digital interaktif

Aplikasi kesehatan (health apps), situs web resmi kesehatan, webinar, dan platform e-learning memberikan kemudahan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat dan berbasis bukti.

Contohnya, aplikasi "SehatPedia" dari Kemenkes RI menyediakan layanan konsultasi kesehatan online, edukasi penyakit, dan pelaporan data kesehatan masyarakat secara real-time.

Media digital memberikan keuntungan dalam hal jangkauan luas, biaya yang efisien, serta kemampuan untuk menyesuaikan pesan sesuai segmentasi audiens. Namun, penggunaan media ini juga memerlukan verifikasi informasi untuk mencegah penyebaran hoaks kesehatan.

4. Pemilihan media dan strategi komunikasi efektif

Pemilihan media dan metode komunikasi dalam promosi kesehatan harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran audiens, termasuk usia, tingkat pendidikan, budaya, bahasa, dan kebiasaan sosial. Pesan kesehatan yang efektif harus bersifat spesifik, sederhana, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa prinsip komunikasi efektif dalam promosi kesehatan antara lain:

a. Kenali sasaran (know your audience)

Lakukan analisis audiens untuk memahami nilai, kepercayaan, dan kebiasaan mereka. Misalnya, pendekatan untuk remaja akan berbeda dengan untuk orang tua atau lansia.

b. Gunakan bahasa yang mudah dipahami

Hindari istilah medis yang rumit. Gunakan bahasa lokal yang familiar agar pesan lebih mudah diterima.

- c. Bangun pesan yang positif dan solutif
Fokus pada manfaat dan peluang ("Hidup Sehat Itu Menyenangkan") daripada ancaman ("Jika Tidak Sehat, Akan Sakit"). Pesan positif lebih memotivasi dan mendorong perubahan perilaku.
- d. Gunakan kombinasi multi-media
Integrasi berbagai media (poster, media sosial, dan kegiatan lapangan) akan memperkuat daya jangkau pesan kesehatan dan meningkatkan dampak komunikasi.
- e. Libatkan tokoh masyarakat atau influencer
Keberadaan figur publik, pemuka agama, atau influencer digital dapat memperkuat kredibilitas pesan dan mempercepat penyebarannya, terutama pada masyarakat muda.

Selain itu, penting untuk memantau efektivitas komunikasi melalui evaluasi rutin, seperti survei persepsi masyarakat, tingkat partisipasi kegiatan, dan perubahan perilaku sasaran. Evaluasi ini membantu menyesuaikan strategi promosi agar tetap relevan dan berdampak nyata.

F. Perencanaan dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan yang efektif tidak dapat dilakukan secara spontan atau tanpa arah. Setiap kegiatan promosi kesehatan harus melalui proses perencanaan yang matang, sistematis, dan berorientasi pada hasil. Perencanaan merupakan fondasi penting dalam memastikan bahwa program promosi kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, realistis untuk dilaksanakan, dan dapat memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku dan peningkatan derajat kesehatan.

Selain perencanaan, evaluasi program juga memiliki peran vital. Evaluasi membantu memastikan apakah kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai rencana, seberapa besar dampaknya, dan apa saja aspek yang perlu diperbaiki. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, program promosi kesehatan dapat terus disesuaikan dan ditingkatkan efektivitasnya.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan promosi kesehatan, terdapat dua tahapan utama yang harus menjadi perhatian, yaitu perencanaan program dan evaluasi keberhasilan:

1. Langkah-langkah perencanaan program promosi kesehatan

Perencanaan program promosi kesehatan adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta menyusun strategi, pelaksanaan, dan mekanisme pemantauan yang sesuai. Tujuannya adalah memastikan kegiatan promosi kesehatan dapat berjalan efisien, efektif, dan berorientasi hasil.

Menurut WHO (World Health Organization) dan Kementerian Kesehatan RI, perencanaan program promosi kesehatan umumnya meliputi lima langkah utama, yaitu: analisis situasi, penetapan tujuan, perumusan strategi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi:

a. Analisis situasi

Tahap pertama adalah memahami kondisi dan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Analisis situasi bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, serta faktor penyebab masalah kesehatan yang akan menjadi dasar perencanaan.

Kegiatan analisis mencakup pengumpulan data primer dan sekunder seperti angka kejadian penyakit, tingkat kesadaran masyarakat, kondisi lingkungan, serta perilaku kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan bisa berupa wawancara, survei, observasi lapangan, atau diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil analisis situasi akan membantu menentukan prioritas masalah dan sasaran intervensi. Misalnya, jika ditemukan tingginya prevalensi anemia pada remaja putri, maka program promosi kesehatan dapat difokuskan pada peningkatan konsumsi zat besi melalui edukasi gizi dan distribusi tablet tambah darah (TTD).

b. Penetapan tujuan dan sasaran program

Tujuan program harus spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu (mengikuti prinsip SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Terdapat dua jenis tujuan yang harus ditetapkan:

- 1) Tujuan umum (outcome goal): menggambarkan perubahan jangka panjang yang diharapkan, misalnya peningkatan derajat kesehatan atau penurunan angka kejadian penyakit.
- 2) Tujuan khusus (output objective): menggambarkan hasil langsung yang akan dicapai, seperti peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang atau peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki jamban sehat.

Selain itu, penetapan sasaran (target audience) juga penting. Sasaran bisa berupa individu, keluarga, kelompok masyarakat, atau institusi tertentu. Misalnya, sasaran program "Cegah Stunting" adalah ibu hamil, remaja putri, dan balita di wilayah berisiko tinggi.

c. Perumusan strategi dan rencana kegiatan

Strategi promosi kesehatan merupakan cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini bisa bersifat edukatif, partisipatif, advokatif, maupun berbasis lingkungan.

Contohnya:

- 1) Strategi edukatif: penyuluhan dan kampanye media sosial tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- 2) Strategi partisipatif: melibatkan masyarakat dalam pembentukan kader gizi dan posyandu mandiri.
- 3) Strategi advokatif: mengupayakan dukungan kebijakan daerah dalam penerapan kawasan bebas asap rokok.
- 4) Strategi lingkungan: menciptakan sekolah sehat, tempat kerja sehat, atau kota sehat.

Setelah strategi dirumuskan, disusun rencana operasional yang meliputi pembagian peran, jadwal kegiatan, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme koordinasi antarinstansi atau mitra kerja.

d. Pelaksanaan program

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, tenaga kesehatan, kader, dan pihak terkait melaksanakan kegiatan promosi sesuai dengan jadwal dan pedoman yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan berjalan efektif, perlu ada koordinasi lintas sektor (misalnya antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat). Selain itu, komunikasi yang baik dan fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi lapangan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.

e. Monitoring dan pengendalian program

Monitoring dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan.

Tujuannya adalah memberikan umpan balik (feedback) yang cepat sehingga perbaikan dapat dilakukan segera tanpa menunggu evaluasi akhir.

Monitoring biasanya mencakup observasi kegiatan, pengumpulan laporan rutin, serta diskusi dengan pelaksana program di lapangan.

Sebagai contoh, dalam program pemberian TTD pada remaja putri, monitoring dilakukan dengan memeriksa tingkat distribusi tablet, kepatuhan konsumsi, serta umpan balik dari peserta.

Dengan perencanaan yang matang dan pemantauan yang efektif, program promosi kesehatan dapat berjalan sesuai sasaran dan menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Penetapan indikator keberhasilan promosi kesehatan

Untuk mengukur keberhasilan program promosi kesehatan, diperlukan indikator yang jelas dan terukur. Indikator berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah program telah mencapai hasil sesuai tujuan.

Menurut Kementerian Kesehatan dan panduan WHO, indikator keberhasilan promosi kesehatan dapat dibagi menjadi lima kategori utama: input, proses, output, outcome, dan dampak:

a. Indikator input

Menggambarkan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program.
Contohnya: jumlah tenaga promosi kesehatan, dana yang dialokasikan, peralatan, dan media edukasi yang disediakan.

Indikator ini penting untuk memastikan kecukupan sumber daya dalam mendukung keberhasilan program.

b. Indikator proses

Menunjukkan aktivitas yang dilakukan selama program berlangsung.

Misalnya: jumlah penyuluhan yang dilaksanakan, jumlah peserta pelatihan, atau tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan.

Indikator proses berfungsi untuk menilai sejauh mana program dijalankan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

c. Indikator output

Menggambarkan hasil langsung dari kegiatan program dalam jangka pendek.
Contohnya: peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi, peningkatan jumlah rumah tangga yang mempraktikkan PHBS, atau peningkatan cakupan imunisasi.

Indikator ini memberikan gambaran awal apakah intervensi promosi kesehatan mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan.

d. Indikator outcome

Menunjukkan hasil jangka menengah yang berkaitan dengan perubahan perilaku, sikap, atau kondisi kesehatan masyarakat.

Misalnya: peningkatan proporsi masyarakat yang rutin melakukan aktivitas fisik, penurunan angka perokok aktif, atau peningkatan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi TTD.

Outcome menggambarkan keberhasilan program dalam memengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat sesuai dengan tujuan promosi kesehatan.

e. Indikator dampak (impact)

Indikator ini menggambarkan hasil jangka panjang yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Contohnya: penurunan angka kejadian stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, atau peningkatan harapan hidup.

Dampak merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian program promosi kesehatan, yang mencerminkan keberhasilan kolaborasi berbagai intervensi kesehatan.

Penetapan indikator harus dilakukan sejak tahap perencanaan agar evaluasi dapat dilakukan secara terukur dan obyektif. Dengan indikator yang jelas, keberhasilan program dapat dinilai secara transparan dan berbasis data.

3. Evaluasi program promosi kesehatan

Evaluasi merupakan bagian penting dari siklus manajemen program promosi kesehatan. Melalui evaluasi, pelaksana dapat mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai rencana, sejauh mana tujuan tercapai, serta apa saja yang perlu diperbaiki di masa depan. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir program, tetapi juga dapat dilakukan di berbagai tahapan pelaksanaan.

Menurut Notoatmodjo (2012) dan WHO (2017), evaluasi program promosi kesehatan dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu evaluasi formatif, sumatif, dan partisipatif.

a. Evaluasi formatif

Evaluasi formatif dilakukan pada tahap awal atau selama pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program dirancang dan dijalankan dengan baik sebelum mencapai tahap akhir.

Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perencanaan, ketersediaan sumber daya, kualitas materi edukasi, serta kesiapan pelaksana program.

Sebagai contoh, dalam kampanye "Cegah Diabetes dengan GERMAS", evaluasi formatif dilakukan dengan menilai efektivitas pesan kampanye, daya tarik materi visual, serta kesesuaian konten dengan budaya lokal sebelum disebarluaskan secara nasional.

b. Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai hasil dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini menjawab pertanyaan: "Apakah program mencapai tujuannya?" dan "Seberapa besar dampak yang dihasilkan?"

Metode yang digunakan bisa berupa survei, wawancara, dan analisis data sebelum dan sesudah intervensi (pre-post analysis).

Contohnya, setelah program edukasi tentang bahaya merokok di sekolah, evaluasi sumatif dapat mengukur penurunan jumlah siswa yang merokok dalam kurun waktu tertentu.

Hasil evaluasi sumatif menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan, pengembangan, atau replikasi program di wilayah lain.

c. Evaluasi partisipatif

Evaluasi partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat, tenaga pelaksana, dan pemangku kepentingan dalam seluruh proses evaluasi. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menilai hasil, tetapi juga untuk membangun rasa memiliki (ownership) terhadap program.

Dalam evaluasi partisipatif, masyarakat diajak untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala program, serta memberikan masukan terhadap perbaikan kegiatan.

Misalnya, pada program sanitasi berbasis masyarakat, warga dapat terlibat dalam menilai perubahan perilaku kebersihan lingkungan serta efektivitas fasilitas yang disediakan.

Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas sosial dan meningkatkan keberlanjutan program karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasilnya.

G. Tantangan dan Inovasi dalam Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan pada era modern menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Di satu sisi, kemajuan teknologi, globalisasi informasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat membuka peluang besar bagi peningkatan derajat kesehatan. Namun, di sisi lain, masih banyak tantangan yang menghambat efektivitas implementasi program promosi kesehatan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Tantangan tersebut mencakup rendahnya literasi kesehatan, keterbatasan sumber daya, serta resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku. Dalam menghadapi hal ini, promosi kesehatan perlu terus berinovasi dengan mengadopsi pendekatan baru, terutama yang memanfaatkan teknologi digital, media sosial, serta teori perilaku modern seperti nudge theory dan behavioral insights.

1. Kendala implementasi promosi kesehatan

Meskipun berbagai program promosi kesehatan telah dilakukan secara luas, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural.

a. Rendahnya literasi kesehatan masyarakat

Literasi kesehatan (health literacy) merupakan kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat bagi kesehatannya. Rendahnya tingkat literasi kesehatan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan promosi kesehatan.

Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman keliru tentang isu kesehatan, seperti mitos seputar vaksinasi, pola makan, atau penggunaan obat tradisional. Misalnya, sebagian masyarakat masih percaya bahwa imunisasi dapat menyebabkan penyakit tertentu atau bahwa makanan “alami” selalu lebih sehat meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Rendahnya literasi ini menyebabkan masyarakat sulit memahami pesan promosi kesehatan, sehingga mengurangi efektivitas kampanye dan intervensi yang dilakukan.

b. Keterbatasan sumber daya dan tenaga kesehatan

Kegiatan promosi kesehatan sering kali terkendala oleh minimnya sumber daya manusia dan anggaran. Tenaga promosi kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan dasar jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja dan banyaknya sasaran.

Selain itu, kapasitas petugas dalam menggunakan teknologi, mengembangkan media komunikasi, dan melakukan pendekatan berbasis perilaku sering kali belum optimal. Akibatnya, kegiatan promosi kesehatan cenderung bersifat rutinitas, kurang kreatif, dan belum menjangkau masyarakat luas secara efektif.

c. Resistensi perilaku masyarakat terhadap perubahan

Salah satu tantangan terbesar dalam promosi kesehatan adalah resistensi perilaku, yakni kecenderungan masyarakat untuk menolak atau sulit mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Perilaku tidak sehat seperti merokok, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta gaya hidup sedentari sering kali sudah menjadi bagian dari budaya sosial.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam memperkuat resistensi tersebut. Misalnya, dalam beberapa komunitas, merokok masih dianggap sebagai simbol kedewasaan atau pergaulan, sehingga kampanye anti-rokok sering kali tidak efektif jika tidak disesuaikan dengan konteks sosialnya.

2. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam konteks promosi kesehatan, teknologi digital memberikan peluang luar biasa untuk menjangkau masyarakat secara luas, cepat, dan interaktif.

a. E-health dan M-health

Teknologi electronic health (e-health) dan mobile health (m-health) memungkinkan penyampaian layanan dan informasi kesehatan melalui platform digital, seperti situs web, aplikasi seluler, dan sistem telemedisin.

Melalui e-health, tenaga kesehatan dapat menyebarkan edukasi mengenai pencegahan penyakit, pola hidup sehat, dan manajemen penyakit kronis secara daring. Contohnya adalah portal resmi Sehat Negeriku milik Kementerian Kesehatan RI, yang menyediakan informasi kesehatan terpercaya untuk masyarakat umum.

Sementara itu, m-health melalui aplikasi di ponsel memungkinkan masyarakat memantau kondisi kesehatannya sendiri, seperti menghitung kebutuhan kalori, memeriksa tekanan darah, atau mengingatkan jadwal minum obat. Aplikasi seperti "SehatPedia", "PeduliLindungi", dan "KlikDokter" merupakan contoh penerapan nyata m-health di Indonesia.

b. Kampanye digital melalui media sosial

Media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook kini menjadi kanal utama komunikasi publik, termasuk untuk penyebaran pesan-pesan kesehatan.

Kampanye kesehatan digital memungkinkan penyampaian pesan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif melalui konten visual, video pendek, infografis, dan live session. Misalnya, kampanye #CegahStunting atau #AyoCuciTangan oleh Kemenkes RI yang memanfaatkan influencer dan figur publik untuk meningkatkan jangkauan audiens muda.

Selain itu, algoritma media sosial yang berbasis preferensi pengguna dapat dimanfaatkan untuk menargetkan kelompok sasaran tertentu, sehingga pesan promosi kesehatan menjadi lebih tepat guna.

c. Edukasi interaktif dan pembelajaran daring

Teknologi digital juga memungkinkan penerapan metode pembelajaran daring (online learning) dalam pendidikan kesehatan masyarakat. Webinar, kursus daring, dan platform edukatif seperti YouTube Edukasi Kesehatan menjadi sarana bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk terus memperbarui pengetahuan kesehatan dengan cara yang mudah dan fleksibel.

3. Inovasi komunikasi perilaku kesehatan di era modern

Dalam menghadapi tantangan perilaku masyarakat yang kompleks, promosi kesehatan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih kreatif dan berbasis pada ilmu perilaku. Inovasi komunikasi yang efektif tidak hanya mengandalkan penyampaian informasi, tetapi juga memahami cara manusia berpikir, merespons, dan membuat keputusan.

a. Behavioral insights dalam promosi kesehatan

Behavioral insights atau ilmu perilaku terapan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana faktor psikologis, sosial, dan emosional memengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam bidang ekonomi dan kini diterapkan juga dalam kesehatan masyarakat. Contohnya, pesan kesehatan yang menekankan norma sosial ("8 dari 10 orang sudah berhenti merokok untuk hidup lebih sehat") terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan dibandingkan dengan pesan yang bersifat ancaman.

b. Nudge theory (teori dorongan lembut)

Konsep nudge yang diperkenalkan oleh Richard Thaler dan Cass Sunstein (2008) menjelaskan bahwa manusia tidak selalu membuat keputusan berdasarkan logika rasional, melainkan sering kali dipengaruhi oleh konteks dan kebiasaan.

Nudge theory digunakan dalam promosi kesehatan untuk memberikan "dorongan lembut" kepada masyarakat agar memilih perilaku sehat tanpa merasa dipaksa.

Contohnya, menempatkan buah di tempat yang mudah dijangkau di kantin sekolah mendorong siswa untuk memilih makanan sehat; atau menampilkan pesan visual di toilet umum “Cuci Tanganmu untuk Lindungi Orang yang Kamu Sayangi” dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perilaku cuci tangan.

Dengan nudge, perubahan perilaku tidak bergantung pada larangan atau paksaan, melainkan pada rekayasa lingkungan (choice architecture) yang membuat pilihan sehat menjadi lebih mudah dan alami.

c. Pendekatan kreatif berbasis budaya lokal

Promosi kesehatan yang efektif harus memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Pendekatan berbasis budaya tidak hanya meningkatkan penerimaan pesan, tetapi juga memperkuat identitas dan kearifan lokal dalam upaya kesehatan.

Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, promosi kesehatan dilakukan melalui media tradisional seperti pertunjukan wayang, ludruk, atau kesenian daerah yang disisipi pesan-pesan kesehatan.

Contoh lainnya adalah penggunaan bahasa daerah dan simbol budaya dalam poster atau kampanye kesehatan, seperti ajakan hidup bersih melalui pepatah lokal yang mudah diingat oleh masyarakat.

H. Peran Lintas Sektor dan Kolaborasi dalam Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan merupakan upaya bersama yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, maupun sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh sifat permasalahan kesehatan yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan promosi kesehatan sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor (multisectoral collaboration) dan kemitraan yang saling menguatkan antar aktor pembangunan.

Pendekatan kolaboratif memungkinkan setiap sektor berkontribusi sesuai kapasitas dan perannya, sehingga tercipta sinergi antara kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan. Upaya ini sejalan dengan konsep Health in All Policies (HiAP) yang dicanangkan oleh WHO, yang menekankan pentingnya memasukkan aspek kesehatan dalam seluruh kebijakan publik.

Dalam konteks global, promosi kesehatan juga diintegrasikan dalam agenda pembangunan berkelanjutan, yakni Sustainable Development Goals (SDGs), yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan.

1. Peran tenaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga pendidikan

a. Tenaga kesehatan sebagai agen perubahan (change agent)

Tenaga kesehatan memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan promosi kesehatan, baik sebagai fasilitator, edukator, maupun motivator perubahan perilaku di masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan pelayanan kuratif dan preventif, tetapi juga berperan dalam mendidik masyarakat agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kesehatan dirinya sendiri.

Misalnya, bidan dan perawat di puskesmas berperan dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak, petugas gizi memberikan edukasi tentang pola makan sehat, sementara tenaga promosi kesehatan menjadi penggerak utama dalam kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, tenaga kesehatan juga bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan kebijakan publik. Mereka mengidentifikasi masalah kesehatan di lapangan dan menyampaikan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based recommendation) kepada pembuat kebijakan.

b. Pemerintah sebagai pengarah kebijakan dan penyedia sumber daya

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator utama dalam promosi kesehatan. Tanggung jawab pemerintah meliputi penyusunan kebijakan kesehatan yang berpihak pada masyarakat, penguatan infrastruktur kesehatan, serta pengalokasian anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan.

Melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, pemerintah menetapkan strategi nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Kota Sehat, dan Desa Siaga Aktif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan.

Di tingkat daerah, pemerintah juga bekerja sama dengan sektor lain seperti pendidikan, pertanian, dan lingkungan untuk menangani determinan sosial kesehatan seperti gizi, air bersih, dan sanitasi.

Selain kebijakan nasional, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem informasi promosi kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga promkes, serta mendorong inovasi berbasis teknologi.

c. Lembaga pendidikan sebagai pusat pembelajaran dan penelitian kesehatan masyarakat

Institusi pendidikan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, berperan penting dalam membentuk perilaku sehat sejak dini. Sekolah dapat menjadi tempat ideal untuk menanamkan nilai-nilai hidup sehat melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kantin sehat, kegiatan olahraga, dan penyuluhan kebersihan lingkungan.

Selain itu, lembaga pendidikan tinggi memiliki peran dalam menghasilkan tenaga profesional kesehatan yang kompeten di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat. Universitas juga berfungsi sebagai pusat penelitian

dan inovasi dalam promosi kesehatan, misalnya dalam pengembangan model komunikasi kesehatan, media edukatif, dan intervensi berbasis komunitas. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga pendidikan membentuk ekosistem yang saling melengkapi tenaga kesehatan menjadi pelaksana di lapangan, pemerintah sebagai pengarah kebijakan, dan lembaga pendidikan sebagai penghasil ilmu dan sumber daya manusia berkualitas.

2. Peran organisasi masyarakat, media, dan sektor swasta

a. Organisasi masyarakat sebagai penggerak sosial

Organisasi masyarakat, baik berbasis komunitas (community-based organization) maupun organisasi keagamaan, memiliki kekuatan sosial yang besar dalam memobilisasi masyarakat untuk berperilaku sehat.

Keterlibatan mereka memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kesehatan dan mempercepat proses perubahan sosial. Contohnya, organisasi seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, kelompok tani, serta majelis taklim sering kali menjadi mitra pemerintah dalam kampanye gizi seimbang, kebersihan lingkungan, atau pencegahan stunting.

Organisasi keagamaan juga berperan penting dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan melalui pendekatan nilai spiritual dan moral, yang sering kali lebih diterima masyarakat. Misalnya, kampanye bahaya narkoba atau HIV/AIDS dapat dilakukan dengan pendekatan dakwah yang menyentuh hati.

b. Media sebagai saluran komunikasi dan pembentuk opini publik

Media massa dan media sosial berperan sebagai sarana utama dalam menyebarkan pesan kesehatan dan membangun opini publik. Peran media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan norma sosial baru mengenai perilaku hidup sehat.

Melalui pemberitaan, program televisi, kampanye digital, dan jurnalisme kesehatan, media dapat memperluas jangkauan promosi kesehatan dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Sebagai contoh, kampanye "Indonesia Sehat Tanpa Rokok" atau "Cegah Stunting Sejak Dini" menggunakan kombinasi media konvensional dan digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.

Namun, media juga perlu bertanggung jawab dalam memastikan informasi yang disampaikan valid dan berbasis bukti ilmiah untuk menghindari penyebaran hoaks kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat.

c. Sektor swasta dalam kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership / PPP)

Peran sektor swasta dalam promosi kesehatan semakin penting melalui kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Konsep Public-Private Partnership (PPP) memungkinkan perusahaan berkontribusi dalam mendukung program kesehatan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), inovasi teknologi, dan jaringan distribusi yang luas.

Sebagai contoh, perusahaan makanan dapat terlibat dalam program fortifikasi pangan untuk mengatasi defisiensi zat gizi mikro, perusahaan farmasi mendukung edukasi penggunaan obat rasional, sementara perusahaan teknologi berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi digital kesehatan.

Selain itu, sektor swasta juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat melalui kebijakan area bebas rokok, penyediaan sarana olahraga, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan.

Kolaborasi antara pemerintah, media, masyarakat, dan sektor swasta tidak hanya memperkuat sumber daya, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang kondusif untuk mendukung perubahan perilaku kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Kolaborasi internasional dan kebijakan global kesehatan masyarakat

Kesehatan masyarakat kini menjadi isu global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Penyakit menular lintas batas, perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial menuntut kerja sama antarnegara dan lembaga internasional. Oleh karena itu, kolaborasi global dalam promosi kesehatan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan dunia.

a. Kolaborasi berbasis Sustainable Development Goals (SDGs)

Promosi kesehatan secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages).

Namun, keterkaitan promosi kesehatan tidak berhenti pada tujuan ini saja. Upaya promosi kesehatan juga mendukung pencapaian SDGs lainnya, seperti:

- 1) SDG 2 (Tanpa Kelaparan): melalui promosi gizi seimbang dan ketahanan pangan;
- 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas): melalui pendidikan kesehatan di sekolah;
- 3) SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak): melalui kampanye perilaku hidup bersih dan sehat;
- 4) SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim): melalui edukasi masyarakat tentang dampak kesehatan akibat krisis iklim.

b. Peran lembaga internasional dan kerja sama antarnegara

Banyak organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, UNFPA, dan FAO berperan dalam mendukung promosi kesehatan global melalui pendanaan, penelitian, pelatihan, serta penyusunan pedoman kebijakan.

Sebagai contoh, WHO mengembangkan program Health Promotion Framework, sementara UNICEF berfokus pada promosi kesehatan anak dan gizi ibu.

Selain itu, kolaborasi antarnegara juga dilakukan dalam bentuk pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman dalam implementasi promosi kesehatan berbasis komunitas. Misalnya, kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pengembangan Healthy City Program atau dengan Australia dalam bidang maternal and child health improvement.

I. Penutup

Promosi kesehatan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat penyuluhan atau penyampaian informasi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pemberdayaan, advokasi kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor, promosi kesehatan mampu mendorong perubahan perilaku, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan kesehatannya sendiri.

Dalam keseluruhan pembahasan ini, terlihat bahwa promosi kesehatan menempati posisi sentral dalam paradigma health for all, yakni menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara. Prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kerja sama antar sektor menjadi landasan utama agar kegiatan promosi kesehatan tidak hanya bersifat temporer, tetapi menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan kebijakan publik. Upaya ini juga menuntut kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, media, dan organisasi masyarakat, sehingga terbentuk ekosistem yang saling mendukung dalam menciptakan perilaku hidup sehat.

Selain itu, di era digital dan globalisasi informasi, promosi kesehatan menghadapi tantangan baru yang menuntut inovasi berkelanjutan. Rendahnya literasi kesehatan, resistensi perilaku, dan kesenjangan akses terhadap informasi perlu diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital, media sosial, serta pendekatan behavioral insights dan nudge theory yang lebih humanis dan kontekstual. Inovasi dalam komunikasi kesehatan berbasis budaya lokal juga penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan kesehatan diterima, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.

Di tingkat global, promosi kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mencapai tujuan ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia. Kolaborasi internasional yang kuat antara negara, organisasi dunia, dan lembaga masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam menanggulangi tantangan kesehatan global seperti penyakit menular lintas batas, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial ekonomi.

Pada akhirnya, promosi kesehatan bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan sosial dan moral yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Melalui promosi kesehatan yang berbasis ilmu, partisipasi masyarakat, serta kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan, diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi

- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action control: From cognition to behavior* (pp. 11–39). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice Hall.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman umum promosi kesehatan di daerah*. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS): Panduan pelaksanaan*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Rencana strategis bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020–2024*. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Rineka Cipta.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390>
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the health belief model. *Health Education Monographs*, 2(4), 328–335. <https://doi.org/10.1177/109019817400200403>

- Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Health Organization, & UNICEF. (2020). *Operational framework for primary health care: Transforming vision into action*. WHO Press.
- World Health Organization. (1986). *Ottawa charter for health promotion*. WHO. <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en>
- World Health Organization. (2017). *Health promotion: A toolkit for action*. WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean.
- World Health Organization. (2020). *Health promotion and disease prevention through population-based interventions, including action to address social determinants and health inequity*. WHO.

BAB IV

KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN WILAYAH

A. Pendahuluan

Gizi komunitas merupakan bidang yang mengintegrasikan prinsip-prinsip gizi, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan status gizi populasi. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai semua 17 tujuan SDGs, yang berkisar dari pengurangan kemiskinan dan kelaparan hingga kesetaraan gender dan keberlanjutan planet (Pérez-Escamilla, 2017). Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) gizi komunitas menjadi sangat penting karena erat kaitannya dengan beberapa tujuan, terutama:

1. SDG 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mendukung pertanian yang berkelanjutan.
2. SDG 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia.
3. SDG 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Pratiwi et al., 2023)

Konsep ini berfokus pada integrasi kebijakan gizi dalam upaya pembangunan yang lebih luas, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program-program gizi. Dalam konteks SDGs, gizi komunitas tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan gizi, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Target ini mengakui keterkaitan antara mendukung pertanian berkelanjutan, memberdayakan petani kecil, mempromosikan kesetaraan gender, mengakhiri kemiskinan pedesaan, memastikan gaya hidup sehat, mengatasi perubahan iklim, dan isu-isu lain yang dibahas dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Béné et al., 2019)

1. Paradigma Ketahanan Pangan: Dari Individual hingga Regional

Ketahanan pangan memiliki definisi yang telah berkembang selama 50 tahun terakhir. Definisi ketahanan pangan telah berkembang dan berubah selama 50 tahun terakhir, termasuk pengenalan empat pilar ketahanan pangan yang umum dikutip: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Perkembangan terbaru menunjukkan pentingnya dua dimensi tambahan yang diusulkan oleh

High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition: agency dan sustainability, sehingga membentuk kerangka kerja enam dimensi ketahanan pangan (Jones et al., 2021).

Enam Dimensi Ketahanan Pangan:

- a. Ketersediaan (Availability): Produksi dan pasokan pangan yang cukup
- b. Akses (Access): Kemampuan untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi
- c. Pemanfaatan (Utilization): Penggunaan pangan untuk mencapai status gizi yang baik
- d. Stabilitas (Stability): Konsistensi akses terhadap pangan setiap saat
- e. Agensi (Agency): Kapasitas individu dan kelompok untuk membuat keputusan tentang sistem pangan mereka
- f. Keberlanjutan (Sustainability): Viabilitas jangka panjang dari basis ekologis dan sosial sistem pangan

2. Kerangka Teori dan Pendekatan Multisektoral

Kerangka teori ketahanan pangan sering kali mengacu pada Framework Four Dimensions of Food Security yang terdiri dari empat dimensi utama (Food and Agriculture Organization of the United (FAO), 2025):

- a. Ketersediaan Pangan (Availability): Mengacu pada jumlah pangan yang diproduksi dalam suatu wilayah dan distribusinya, baik yang bersumber dari hasil domestik maupun impor.
- b. Akses Pangan (Access): Berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi, baik melalui pembelian, produksi sendiri, atau bantuan.
- c. Pemanfaatan Pangan (Utilization): Melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana tubuh menyerap dan memanfaatkan nutrisi yang terkandung dalam pangan, seperti status gizi, sanitasi, dan kesehatan.
- d. Stabilitas Pangan (Stability): Berkaitan dengan konsistensi ketersediaan pangan sepanjang waktu dan ketahanan terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim, bencana alam, atau fluktuasi harga pangan.

Teori ketahanan pangan ini bisa dipadukan dengan konsep-konsep dari teori pembangunan berkelanjutan dan pendekatan sistem yang lebih luas. Sebagai contoh, pendekatan sistem melihat ketahanan pangan sebagai hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Pendekatan multisektoral dalam ketahanan pangan melibatkan keterlibatan berbagai sektor yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap ketahanan pangan, termasuk sektor pertanian, kesehatan, ekonomi, dan

lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama antar sektor untuk mencapai ketahanan pangan yang holistik. Beberapa sektor kunci yang harus terlibat dalam pendekatan multisektoral adalah (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022) :

- a. Pertanian dan Perikanan: Sektor ini berfokus pada produksi pangan, keberlanjutan pertanian, dan keberagaman sumber pangan. Inovasi dalam teknologi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam juga penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan.
- b. Ekonomi dan Infrastruktur: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk akses terhadap pasar, modal, dan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi dan sistem distribusi pangan, sangat penting untuk memastikan akses pangan yang adil dan merata.
- c. Kesehatan: Dalam hal pemanfaatan pangan, sektor kesehatan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah malnutrisi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi.
- d. Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan terkait pola makan sehat, pengolahan pangan, dan pentingnya keberagaman konsumsi pangan harus dipromosikan di seluruh lapisan masyarakat.
- e. Lingkungan dan Perubahan Iklim: Aspek lingkungan, seperti perubahan iklim dan degradasi tanah, dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan ekologis penting dalam mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

Beberapa negara dan lembaga internasional telah mengadopsi pendekatan multisektoral ini untuk memperkuat ketahanan pangan mereka. Misalnya, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, ekonomi, dan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Meskipun pendekatan multisektoral menjanjikan solusi yang lebih komprehensif untuk masalah ketahanan pangan, penerapannya tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah (1) Koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, yang dapat menghambat implementasi kebijakan yang terpadu, (2) Keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli yang dapat mengelola program-program multisektoral. Ketegangan antara sektor ekonomi dan lingkungan, di mana kebijakan pembangunan ekonomi seringkali bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan yang dapat mendukung ketahanan pangan jangka panjang

B. Ketahanan Pangan Rumah Tangga

1. Situasi Global Ketahanan Pangan

Situasi ketahanan pangan global saat ini menunjukkan tantangan yang masih sangat signifikan meskipun terdapat beberapa perbaikan. Diperkirakan antara 638 hingga 720 juta orang, atau sekitar 7,8 hingga 8,8 persen dari populasi global, menghadapi kelaparan pada tahun 2024 (Food and Agriculture Organization of the United (FAO), 2025). Pada tahun 2024, lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami tingkat kelaparan akut, meningkat 13,7 juta dari tahun 2023 (Global Network Against Food Crises, 2025). Dari jumlah tersebut, 1,4 juta orang menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang katastrofik (The World Bank, 2025). Sekitar 2,33 miliar orang secara global menghadapi kerawanan pangan moderat atau parah pada tahun 2023, dengan lebih dari 864 juta orang mengalami kerawanan pangan parah (Food and Agriculture Organization of the United (FAO), 2025). Ketidakmampuan mengakses diet sehat juga menjadi persoalan besar, di mana di negara-negara berpendapatan rendah, jumlah orang yang tidak mampu membeli diet sehat meningkat dari 464 juta pada 2019 menjadi 545 juta pada 2024 (Global Network Against Food Crises, 2025).

Malnutrisi pada anak-anak masih menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan global. Pada tahun 2024, sebanyak 150,2 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting (terlalu pendek untuk usianya), 42,8 juta anak mengalami wasting (terlalu kurus untuk tingginya), dan 35,5 juta anak mengalami kelebihan berat badan. Prevalensi stunting turun menjadi 23,2 persen pada tahun 2024, mengurangi jumlah anak yang mengalami stunting dari 180,4 juta pada 2012 menjadi 150,2 juta pada 2024, namun dunia masih belum berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target 2030 (Food and Agriculture Organization of the United (FAO), 2025). Secara global pada tahun 2024, 6,6 persen anak di bawah 5 tahun menderita wasting dan 1,9 persen menderita wasting parah, yang berarti masing-masing 42,8 juta dan 12,2 juta anak. Data ini menggambarkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa indikator, dunia masih jauh dari target global untuk mengakhiri kelaparan dan malnutrisi dalam segala bentuknya.

2. Dampak COVID-19 terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan di delapan provinsi di Indonesia (Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat) menunjukkan bahwa 50,63% rumah tangga yang disurvei mengalami ketidakamanan pangan (Daulay & Arka, 2025). Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah melemahnya kondisi

ekonomi masyarakat. Penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan pembatasan aktivitas ekonomi mengurangi daya beli rumah tangga terhadap pangan. Laporan bersama WFP, FAO, dan UN Women menyebutkan bahwa karantina wilayah membatasi kesempatan bekerja dan mengakses layanan, memberikan tekanan pada populasi rentan untuk membeli kebutuhan dasar (Rozaki, 2021). Ekonomi masyarakat yang lemah akan berdampak pada ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian di wilayah urban (Jakarta) dan semi-urban (Depok) dengan total sampel 517 orang menunjukkan hubungan signifikan antara dampak ekonomi pandemi dengan status ketahanan pangan rumah tangga (Syafiq et al., 2022)). Survei daring oleh LIPI menunjukkan bahwa meskipun secara umum ketahanan pangan rumah tangga cukup baik, terdapat rumah tangga dengan kondisi ketahanan pangan rendah, terutama yang memiliki kepala rumah tangga berpenghasilan tidak tetap, bekerja di sektor informal, dan pengeluaran rumah tangga rendah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2020) Pada tahun 2021, stunting diprediksi meningkat menjadi 32,5%, underweight menjadi 23,0% dan wasting menjadi 10,5%. Salah satu penyebab utama meningkatnya tingkat malnutrisi akibat pandemi COVID-19 adalah melalui penurunan pendapatan rumah tangga yang berdampak negatif pada daya beli serta mengurangi ketersediaan pangan dan menurunkan tingkat ketahanan pangan rumah tangga.

3. Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

a. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Sebaliknya, pengeluaran rumah tangga yang besar untuk pangan dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lainnya. Studi oleh Esta Lestari dan Jiwa Sarana (2025) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat keparahan kemiskinan, yang berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan rumah tangga (Lestari & Jiwa, 2018)

b. Ukuran Rumah Tangga

Ukuran rumah tangga yang besar cenderung meningkatkan konsumsi pangan total, namun dapat menurunkan konsumsi per kapita, yang berpotensi menurunkan kualitas gizi. Ukuran keluarga berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan suatu rumah tangga. Rumah tangga dengan ukuran keluarga yang besar memiliki kecenderungan untuk menjadi tahan pangan 2,49 kali lebih besar dibandingkan dengan yang ukuran keluarganya kecil (Putrie & Rahman, 2020).

c. Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada kepala rumah tangga berhubungan dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya gizi dan cara mengelola sumber daya pangan secara efisien. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi cenderung untuk menjadi tahan pangan 1,31 kali lebih besar dibandingkan dengan yang berpendidikan dasar; 1,21 kali lebih dibandingkan dengan yang berpendidikan menengah pertama; serta 1,15 kali lebih dibandingkan dengan yang berpendidikan menengah atas (Putrie & Rahman, 2020).

d. Kesehatan dan Status Gizi Anggota Rumah Tangga

Kesehatan yang baik dan status gizi yang optimal mendukung kemampuan anggota rumah tangga untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan pangan. Penelitian oleh Esta Lestari dan Jiwa Sarana (2018) menunjukkan bahwa status kesehatan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga (Lestari & Jiwa, 2018).

e. Akses terhadap Sumber Pangan Lokal

Pangan lokal memiliki kaitan erat dan strategis dengan ketahanan pangan rumah tangga melalui beberapa dimensi kunci yang saling memperkuat. Pertama, pangan lokal seperti kelor, porang, dan sagu menyediakan ketersediaan nutrisi yang tinggi dan terjangkau bagi rumah tangga, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, karena komoditas ini dapat dibudidayakan secara lokal dengan adaptabilitas ekologis yang baik terhadap berbagai kondisi tanah dan iklim. Kedua, aksesibilitas pangan lokal meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dengan mengurangi ketergantungan pada pangan impor dan ultra-processed yang mahal, sehingga meningkatkan daya beli dan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh makanan bergizi secara konsisten. Ketiga, pemanfaatan pangan lokal mendukung dimensi utilisasi pangan melalui kandungan mikronutrien dan senyawa bioaktif yang efektif mengatasi masalah malnutrisi seperti anemia, stunting, dan defisiensi vitamin, yang sering dialami oleh rumah tangga miskin dan rentan. Keempat, pangan lokal yang terintegrasi dalam kearifan tradisional dan praktik budaya lokal memastikan keberlanjutan dan stabilitas pasokan pangan rumah tangga, terutama pada periode kelangkaan pangan atau tekanan iklim, karena tanaman seperti sagu memiliki ketahanan terhadap kekeringan dan dapat menjadi sumber kalori kritis saat terjadi krisis pangan. Dengan demikian, pengembangan dan promosi pangan lokal fungsional bukan hanya memperkuat kemandirian pangan di tingkat rumah tangga, tetapi juga

berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya dalam konteks pencapaian SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 12 (Responsible Consumption and Production) (Prasetia et al., 2025)

f. Kebijakan Sosial dan Bantuan Pemerintah

Berdasarkan artikel tersebut, kebijakan sosial dan ekonomi memiliki peranan krusial dalam mengatasi kerawanan pangan rumah tangga dengan bekerja pada akar permasalahan melalui perbaikan kondisi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini mencakup intervensi di bidang pendapatan dan ketenagakerjaan (seperti upah layak dan dukungan pendapatan), perumahan (untuk memastikan keterjangkauan dan fasilitas yang memadai), jaminan sosial atau safety net (bantuan finansial dan material bagi pengangguran dan kelompok rentan), serta kebijakan keluarga (cuti orang tua dan kesejahteraan anak), yang kesemuanya dirancang untuk memengaruhi determinan kerawanan pangan dengan meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan, ketersediaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan. Berbeda dengan intervensi pemberian pangan langsung atau program pendidikan gizi yang berfokus pada perubahan perilaku individual, kebijakan sosial dan ekonomi berupaya memperbaiki ketidakadilan dalam kondisi struktural tempat masyarakat dilahirkan, hidup, bekerja, dan berinteraksi, sehingga memberikan dampak jangka panjang pada stabilitas ketahanan pangan dengan memastikan rumah tangga memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mengakses pangan bergizi secara konsisten. Melalui mekanisme ini, kebijakan pemerintah yang nutrition-sensitive dapat secara efektif mengurangi prevalensi dan tingkat keparahan kerawanan pangan dengan mengatasi kemiskinan, ketidakamanan pendapatan, dan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang menjadi penyebab mendasar dari masalah kerawanan pangan di negara-negara berpenghasilan tinggi maupun negara berkembang seperti BRICS (R et al., 2023)

4. Peran Modal Sosial

Modal sosial adalah kelompok, jaringan, norma, dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk tujuan produktif.

Peranan Modal Sosial terhadap Ketahanan Pangan (Rusmawati et al., 2023):

a. Pengaruh Positif dan Signifikan

Penelitian menemukan bahwa modal sosial bonding (ikatan) dan bridging (jembatan) memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Hal ini dikonfirmasi melalui berbagai

indikator ketahanan pangan seperti asupan kalori, skor keragaman pangan (DDS), dan skor variasi makanan (FVS).

b. Mekanisme Peningkatan Ketahanan Pangan

Modal sosial meningkatkan ketahanan pangan melalui beberapa mekanisme yaitu (1) Berbagi Pengetahuan dan Produk Modal sosial meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagi pengetahuan dan produk, termasuk informasi peluang pekerjaan melalui hubungan kekerabatan dan persahabatan, (2) Dukungan Sosial dan Psikologis Modal sosial bonding membantu anggota komunitas bertahan melalui dukungan sosial dan psikologis yang erat, memungkinkan rumah tangga mendapatkan pinjaman dan peluang kerja dan (3) Akses ke Sumber Daya Modal sosial bridging memberikan akses ke aset eksternal yang lebih luas dan penyebaran informasi, menghubungkan masyarakat dengan lingkungan yang lebih beragam dan peluang kerja yang lebih luas.

c. Perbedaan Dampak Bonding vs Bridging

Modal Sosial Bonding: Modal sosial bonding lebih berperan dalam membantu rumah tangga bertahan dalam kondisi sulit ("getting by") melalui dukungan dari anggota komunitas dengan karakteristik serupa.

Modal Sosial Bridging: Modal sosial bridging memiliki dampak yang lebih kuat terhadap ketahanan pangan (koefisien 130,1 vs 83,69 untuk bonding), karena memungkinkan masyarakat mengatasi tantangan dengan lebih baik ("getting ahead") melalui hubungan lintas komunitas dengan latar belakang yang beragam.

d. Alasan Bridging Lebih Efektif

Bridging social capital lebih efektif karena melibatkan interaksi antara orang-orang dengan latar belakang berbeda, memungkinkan mereka mengatasi kesulitan melalui pertukaran informasi, proses pembelajaran, dan pemahaman pengalaman orang lain. Variasi strata ekonomi juga meningkatkan peluang masyarakat rawan pangan untuk mendapatkan bantuan moneter dan non-moneter dari komunitas bridging mereka.

e. Implikasi Kebijakan

Pemerintah Indonesia perlu melibatkan partisipan yang lebih heterogen dalam program ketahanan pangan, seperti pengusaha, ahli pertanian, dan konsumen potensial, untuk mengembangkan modal sosial bridging yang lebih efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

5. Pengukuran Ketahanan Pangan Rumah Tangga

a. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS)

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan rumah tangga adalah household-food-insecurity access scale (HFIAS). Keuntungan dari metode ini adalah sederhana dan murah untuk diterapkan. HFIAS merupakan adaptasi dari pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan prevalensi ketidakamanan pangan per tahun di Amerika Serikat, yaitu U.S. Household Food Security Survey Module (US HFSSM). Metode HFIAS didasarkan pada ide bahwa pengalaman mengakses ketidakamanan pangan menyebabkan reaksi dan respons yang dapat diprediksi yang dapat ditangkap dan dikuantifikasi melalui survei dan dirangkum pada skala (Coates et al., 2007).

b. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia

Melalui Biro Ketahanan Pangan Republik Indonesia (2020), Indonesia menerbitkan Indeks Ketahanan Pangan setiap tahun (Pakpahan et al., 2021). Indeks ini menggunakan berbagai indikator untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia (Badan Pangan Nasional, 2022).

c. Coping Strategy Index

Strategi coping rumah tangga dinilai menggunakan instrumen Reduced Coping Strategy Index (RCSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga mengalami ketidakamanan pangan dan melakukan beberapa upaya strategi coping untuk bertahan hidup. Strategi coping yang paling umum dilakukan oleh rumah tangga adalah meminjam makanan dari tetangga (Sari & Adi, 2018).

C. Ketahanan Pangan Wilayah

Ketahanan pangan wilayah adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi suatu wilayah atau daerah tertentu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat.

Beberapa tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan wilayah di Indonesia antara lain (Salasa, 2021) :

- **Pertumbuhan penduduk yang cepat**, meningkatkan kebutuhan pangan, sementara luas lahan pertanian terbatas.
- **Perubahan iklim**: memengaruhi pola curah hujan dan suhu, yang berdampak pada produksi pangan.

- **Urbanisasi:** mengurangi jumlah lahan pertanian produktif dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.
- **Keterbatasan infrastruktur:** menghambat distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan biaya pangan.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah antara lain (Badan Pangan Nasional, 2022):

- **Diversifikasi sumber pangan:** mengembangkan berbagai jenis pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.
- **Peningkatan infrastruktur pertanian:** membangun dan memperbaiki sistem irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung produksi dan distribusi pangan.
- **Pemberdayaan masyarakat:** melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan terkait pangan.
- **Pemanfaatan teknologi:** mengadopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

1. Sistem Pangan Berkelanjutan di Level Regional

Untuk menjadi berkelanjutan, pertanian harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, sambil memastikan profitabilitas, kesehatan lingkungan, dan kesetaraan sosial dan ekonomi. Pangan dan pertanian berkelanjutan (SFA) berkontribusi pada keempat pilar ketahanan pangan – ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas – dan dimensi keberlanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi) (Food and Agriculture Organization of the United (FAO), 2025). Sistem produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari meningkatnya permintaan pangan untuk populasi yang berkembang, meningkatnya kelaparan dan malnutrisi, efek perubahan iklim yang merugikan, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kehilangan serta pemborosan pangan.

Pilar Utama dalam Sistem Pangan Berkelanjutan Regional (Fahmi, 2024):

a. Diversifikasi Pangan Lokal

Memanfaatkan keragaman hayati lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal seperti beras. Indonesia memiliki lebih dari 77 jenis sumber karbohidrat yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Diversifikasi ini penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat

b. Penguatan Infrastruktur dan Distribusi Pangan

Membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian serta sistem distribusi pangan untuk memastikan pangan lokal dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan yang efisien.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sistem pangan melalui pendekatan partisipatif. Pengembangan pangan lokal berbasis komunitas dan kearifan lokal dapat memperkuat ketahanan pangan daerah rentan

d. Pendekatan Ekoregion dalam Perencanaan Pangan

Mengembangkan sistem pangan berbasis ekoregion untuk mengintegrasikan produksi pangan dengan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini mempertimbangkan kombinasi ekoregion daratan dan lautan untuk menciptakan sistem pangan yang holistik dan berkelanjutan

Perubahan iklim menjadi tantangan utama dalam sistem pangan berkelanjutan karena fluktuasi suhu dan curah hujan yang tidak dapat diprediksi dapat mempengaruhi hasil pertanian. Variabilitas iklim, seperti kekeringan yang berkepanjangan atau curah hujan yang sangat tinggi, dapat merusak tanaman pangan dan mengurangi hasil pertanian. Selain itu, fenomena perubahan iklim seperti banjir dan cuaca ekstrem lainnya mempengaruhi infrastruktur pertanian dan kualitas tanah, yang berujung pada penurunan ketahanan pangan regional. Menurut laporan dari **FAO**, perubahan iklim mengancam ketahanan pangan karena menyebabkan kegagalan panen, meningkatkan biaya produksi pangan, dan mengurangi daya dukung lahan pertanian. Hal ini juga menciptakan ketidakpastian dalam pasokan pangan, sehingga berdampak pada kestabilan sistem pangan secara keseluruhan (The World Bank, 2025).

Sistem pangan berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya alam, terutama lahan pertanian yang subur, air, dan keanekaragaman hayati. Namun, lahan pertanian yang terbatas, degradasi tanah, dan pencemaran air dapat membatasi potensi produksi pangan daerah. Ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam tertentu juga menambah kerentanannya terhadap perubahan ekosistem, yang semakin memperburuk ketahanan pangan regional. Akibat konversi lahan untuk kepentingan non-pertanian, serta perubahan pola penggunaan lahan oleh masyarakat, menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian yang produktif. Penurunan kualitas tanah juga memengaruhi keberlanjutan produksi pangan di wilayah tersebut (Suryana, 2014).

Infrastruktur yang buruk sering kali menjadi penghambat dalam mendistribusikan pangan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Ketidakmampuan dalam membangun jalan yang baik, fasilitas penyimpanan pangan, dan sistem distribusi yang efisien

menyebabkan ketidakmerataan akses pangan yang berkualitas. Misalnya, di wilayah dengan infrastruktur transportasi yang terbatas, pangan yang diproduksi lokal sering kali tidak dapat sampai ke pasar tepat waktu atau dalam kondisi baik. Ketidakcukupan infrastruktur menyebabkan ketimpangan dalam akses pangan, yang mengakibatkan kesenjangan antara wilayah penghasil pangan dan wilayah yang kekurangan pangan. Hal ini menyebabkan peningkatan harga pangan dan ketidakstabilan pasokan (Khan et al., 2025).

2. Kerangka Penilaian Ketahanan Pangan Regional

Kerangka Penilaian Ketahanan Pangan Regional merupakan sistem komprehensif yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi status ketahanan pangan pada tingkat wilayah atau regional. Kerangka ini mengintegrasikan berbagai dimensi ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability) pangan dalam konteks geografis tertentu

Dimensi Utama Penilaian

a. Ketersediaan Pangan (Food Availability)

Dimensi ini mengukur tingkat produksi pangan, stok cadangan, dan kemampuan impor suatu wilayah. Indikator yang digunakan meliputi produksi per kapita, rasio ketergantungan impor, dan diversifikasi produksi pangan (Jones et al., 2013)

b. Akses Pangan (Food Access)

Mengukur kemampuan rumah tangga dan individu untuk memperoleh pangan yang cukup melalui produksi sendiri, pembelian, atau mekanisme lainnya. Indikator mencakup tingkat kemiskinan, infrastruktur pasar, dan daya beli masyarakat (Manikas et al., 2023).

c. Pemanfaatan Pangan (Food Utilization)

Berkaitan dengan keamanan pangan, nilai gizi, dan praktik pengolahan pangan. Indikator meliputi status gizi masyarakat, akses air bersih, dan fasilitas sanitasi (Sumsion et al., 2023).

d. Stabilitas (Stability)

Mengukur konsistensi ketersediaan dan akses pangan sepanjang waktu, termasuk ketahanan terhadap guncangan ekonomi, iklim, dan politik (Manikas et al., 2023).

3. Metodologi Penilaian Ketahanan Pangan Regional

Metodologi penilaian ketahanan pangan merupakan kerangka sistematis yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan memantau status ketahanan pangan suatu wilayah atau populasi. Mengingat kompleksitas dan multidimensionalitas ketahanan pangan, berbagai pendekatan metodologi telah dikembangkan dengan kelebihan dan keterbatasan masing-masing (Jones et al.,

2013). Pemilihan metodologi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan informasi yang akurat dan actionable bagi perumusan kebijakan.

a. Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) adalah sistem pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan yang dikembangkan melalui kerjasama antara World Food Programme (WFP), Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik Indonesia. FSVA pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 dan terus diperbarui secara berkala untuk memantau dinamika ketahanan pangan di Indonesia hingga level kabupaten/kota. FSVA digunakan sebagai dasar perencanaan program intervensi ketahanan pangan, alokasi bantuan pangan, dan prioritas pembangunan pertanian. Peta FSVA membantu pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam program ketahanan pangan.

FSVA menggunakan pendekatan indikator komposit yang mengintegrasikan tiga komponen utama: (Department of Food Security and Animal Husbandry, 2020)

- 1) Komponen Kerawanan Pangan (Food Insecurity): Mengukur kondisi ketahanan pangan aktual melalui indikator seperti rasio konsumsi normatif per kapita, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, persentase balita stunting, dan Angka Harapan Hidup (AHH).
- 2) Komponen Kerentanan Pangan (Food Vulnerability): Menilai potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan pangan, meliputi indikator seperti rasio ketergantungan penduduk, persentase desa tanpa akses jalan yang memadai, persentase wilayah dengan curah hujan rendah, persentase lahan dengan kemiringan tinggi, dan frekuensi bencana alam.
- 3) Komponen Ketahanan Pangan (Food Security): Mengukur kapasitas dan sumber daya yang mendukung ketahanan pangan, termasuk produktivitas padi, diversifikasi produksi pangan, surplus produksi pangan, dan ketersediaan infrastruktur.

Setiap indikator dinormalisasi menggunakan metode min-max scaling dengan rentang 0-100, kemudian diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Skor komposit dihitung dengan metode agregasi tertimbang untuk menghasilkan peta klasifikasi wilayah menjadi: sangat tahan pangan (prioritas 1), tahan pangan (prioritas 2), agak rentan pangan (prioritas 3), rentan pangan (prioritas 4), rawan pangan (prioritas 5), dan sangat rawan pangan (prioritas 6) (Pangaribowo & Tsegai, 2011)

b. Desirable Dietary Pattern / Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah suatu komposisi kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Konsep PPH dikembangkan oleh FAO dan diadopsi Indonesia sejak tahun 1990-an sebagai instrumen perencanaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (The World Bank, 2025)

PPH mengklasifikasikan pangan menjadi 9 kelompok dengan kontribusi energi ideal masing-masing:

- 1) Padi-padian: Sumber karbohidrat utama dengan kontribusi energi ideal 50% (skor maksimal 25)
- 2) Umbi-umbian: Sumber karbohidrat alternatif dengan kontribusi 6% (skor 2,5)
- 3) Pangan hewani: Sumber protein hewani dengan kontribusi 12% (skor 24)
- 4) Minyak dan lemak: Sumber energi dan asam lemak esensial dengan kontribusi 10% (skor 5)
- 5) Buah/biji berminyak: Sumber lemak nabati dengan kontribusi 3% (skor 1)
- 6) Kacang-kacangan: Sumber protein nabati dengan kontribusi 5% (skor 10)
- 7) Gula: Sumber energi dengan kontribusi 5% (skor 2,5)
- 8) Sayur dan buah: Sumber vitamin, mineral, dan serat dengan kontribusi 6% (skor 30)
- 9) Lain-lain: Bumbu, minuman dengan kontribusi 3% (skor 0)

Skor PPH dihitung berdasarkan formula yang membandingkan kontribusi energi aktual dari setiap kelompok pangan terhadap standar PPH. Skor maksimal adalah 100, yang menunjukkan pola konsumsi pangan ideal. Perhitungan menggunakan rumus:

Skor PPH = Σ (Skor kelompok pangan $\times$ Proporsi energi aktual / Proporsi energi standar)

Skor PPH kemudian dikategorikan sebagai: sangat baik (>90), baik (80-90), cukup (60-80), kurang (50-60), dan sangat kurang (<50).

Selain skor total, PPH juga menghasilkan beberapa indikator turunan seperti: tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita, tingkat konsumsi pangan hewani, tingkat diversifikasi pangan, dan derajat ketergantungan pada sumber pangan tertentu. PPH digunakan untuk evaluasi ketahanan pangan tingkat nasional, regional, dan rumah tangga, perencanaan kebutuhan dan ketersediaan pangan, monitoring pencapaian diversifikasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan pengembangan sistem pangan berkelanjutan.

c. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sistem pengukuran ketahanan pangan menggunakan pendekatan indeks komposit yang mengintegrasikan multiple indikator dari berbagai dimensi ketahanan pangan. Keunggulan IKP adalah kemampuannya memberikan gambaran komprehensif multi-dimensi, memfasilitasi perbandingan antar wilayah dan antar waktu, serta memberikan basis empiris untuk formulasi kebijakan. Keterbatasan mencakup kompleksitas data yang diperlukan, subjektivitas dalam pembobotan, dan potensi masking effect dimana dimensi dengan skor tinggi dapat menutupi dimensi dengan skor rendah. IKP digunakan untuk monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan, identifikasi prioritas intervensi berdasarkan dimensi yang lemah, alokasi sumber daya pembangunan, dan benchmarking kinerja ketahanan pangan antar daerah. Beberapa provinsi di Indonesia telah mengembangkan IKP spesifik untuk perencanaan pembangunan daerah (Suryana, 2014). IKP dikembangkan berdasarkan framework FAO yang mencakup empat pilar: ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability) (Dan et al., 2003; Sumsion et al., 2023)

- 1) Dimensi Ketersediaan Pangan: mengukur kemampuan regional dalam menyediakan pangan melalui produksi lokal, stok, dan distribusi. Indikator meliputi: rasio produksi pangan terhadap kebutuhan konsumsi, produktivitas lahan pertanian, ketersediaan energi dan protein per kapita, rasio surplus produksi pangan, dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
- 2) Dimensi Akses Pangan: Menilai kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan secara fisik dan ekonomi. Indikator mencakup: persentase penduduk miskin, rasio pendapatan terhadap pengeluaran pangan, aksesibilitas terhadap pasar, kepadatan jalan per luas wilayah, dan rasio desa terisolasi.
- 3) Dimensi Pemanfaatan Pangan: Mengukur bagaimana tubuh memanfaatkan berbagai zat gizi dalam pangan. Indikator meliputi: prevalensi stunting dan wasting pada balita, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan Angka Harapan Hidup.
- 4) Dimensi Stabilitas Pangan: Menilai konsistensi ketiga dimensi di atas sepanjang waktu dan ketahanan terhadap guncangan. Indikator mencakup: koefisien variasi produksi pangan, koefisien variasi harga pangan pokok, frekuensi dan intensitas bencana alam, tingkat ketergantungan impor pangan, dan ketersediaan cadangan pangan.

Proses perhitungan IKP mengikuti tahapan sistematis:

- 1) Normalisasi Data: Setiap indikator dinormalisasi menggunakan metode min-max scaling untuk menghasilkan nilai antara 0-100. Formula: Nilai Ternormalisasi = $[(X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})] \times 100$, dimana X_i adalah nilai aktual, $X_{\min}$ adalah nilai minimum, dan $X_{\max}$ adalah nilai maksimum.
- 2) Pembobotan Indikator: Setiap indikator diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap ketahanan pangan, yang ditentukan melalui metode analytical hierarchy process (AHP), expert judgment, atau principal component analysis (PCA). Pembobotan dapat berbeda tergantung konteks regional.
- 3) Agregasi: Nilai IKP dihitung dengan formula: $IKP = \sum (W_i \times S_i)$, dimana W_i adalah bobot indikator ke- i dan S_i adalah skor ternormalisasi indikator ke- i . Hasilnya adalah skor komposit IKP dengan rentang 0-100.
- 4) Klasifikasi: Berdasarkan skor IKP, wilayah diklasifikasikan menjadi kategori: sangat tahan pangan ($IKP \geq 81$), tahan pangan (66-80), cukup tahan pangan (51-65), rentan pangan (36-50), rawan pangan (21-35), dan sangat rawan pangan (≤ 20).

4. Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia

a. Program Desa Mandiri Pangan (DMP)

Program Desa Mandiri Pangan di tingkat rumah tangga di Indonesia telah menunjukkan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketahanan pangan, menekankan pentingnya implementasi kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (Rusliyadi et al., 2019). Dampak Program DMP sangat positif, berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi negara secara keseluruhan dan meningkatkan penghidupan penduduk desa. Dalam hal pengentasan kemiskinan, Program DMP telah secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, sekaligus meningkatkan status ketahanan pangan rumah tangga tersebut, sehingga mendorong kesehatan dan gizi yang lebih baik di kalangan penduduk desa (Febriansyah et al., 2018).

b. Atlas Ketahanan Pangan dan Kerentanan

Atlas Ketahanan Pangan dan Kerentanan dikembangkan bersama oleh WFP dan Badan Ketahanan Pangan Nasional, atlas memvisualisasikan data ketahanan pangan utama untuk semua 514 kota dan kabupaten di Indonesia, sebuah negara besar dengan 280 juta penduduk. Di dalamnya, setiap kecamatan dan desa diberi salah satu dari enam kelas prioritas kerentanan, berdasarkan indikator seperti akses ke air mengalir, jumlah lahan pertanian per orang dan akses ke fasilitas medis, antara lain (United Nations Indonesia, 2023)

5. Implementasi Kebijakan yang Efektif

Model implementasi yang sukses memerlukan perbaikan berikut dalam konteks Indonesia: artikulasi yang jelas tentang tujuan kebijakan, justifikasi, dan rasional dalam hal prosedur implementasi; pengakuan atau insentif untuk pemerintah daerah yang menerapkan inovasi kebijakan yang sukses di tingkat desa; strategi manajemen untuk inovasi kebijakan berdasarkan ketersediaan dan kemampuan sumber daya lokal (Rusliyadi et al., 2024). Faktor-faktor seperti ukuran lahan, biaya benih, dan biaya tenaga kerja secara signifikan mempengaruhi efisiensi teknis. Selain itu, peran penyuluh dalam mengubah perilaku perempuan nelayan dapat meningkatkan status ketahanan pangan rumah tangga, menekankan pentingnya pelatihan komprehensif untuk penyuluh (Rusliyadi et al., 2024).

D. Intervensi Gizi Komunitas Untuk Ketahanan Pangan

1. Pendahuluan

Gizi komunitas berangkat dari kerangka determinan gizi UNICEF (2020) yang menegaskan peran pola makan (diet) dan praktik perawatan sebagai determinan langsung, dengan determinan mendasar seperti layanan kesehatan, lingkungan, perlindungan sosial, serta norma/gender. Kerangka ini juga mengakomodasi triple burden (kurang gizi, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan berat badan) sehingga intervensi perlu multisektor dan lintas level (UNICEF, 2021). Laporan SOFI (The State of Food Security and Nutrition in the World) terbaru menunjukkan dunia masih jauh dari target SDG2; harga pangan tinggi dan inflasi menggerus akses diet sehat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Artinya, intervensi di tingkat komunitas khusus untuk perilaku, akses, dan lingkungan makanan merupakan kunci intervensi yang akan diberikan (Burki, 2022). Prinsip desain intervensi komunitas yang efektif (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022; Meera et al., 2021; Tewodros et al., 2024):

- a. Berbasis bukti dan teori perubahan perilaku (SBC): program yang eksplisit memakai teori/peranti perubahan perilaku lebih konsisten mengubah praktik makan.
- b. Lintas-sektor dan peka konteks: memadukan intervensi spesifik gizi (misal menyusui, PMBA, suplementasi) dengan intervensi sensitif gizi (pertanian, WASH, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan).
- c. Berperspektif gender dan pemberdayaan: indikator pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan Kesehatan perempuan dan anak berkorelasi dengan kualitas diet dan hasil gizi.

2. Tipe intervensi gizi berbasis komunitas (dengan bukti efektivitas)

Intervensi gizi-spesifik

- a. Promosi, perlindungan, dan dukungan menyusui (termasuk BFCI)
 - 1) intervensi dukungan laktasi (edukasi antenatal/postnatal, konseling, dukungan sebaya) meningkatkan inisiasi & durasi menyusui (Whittaker et al., 2025).
 - 2) Baby-Friendly Community Initiative (BFCI) di Kenya (uji acak klaster): meningkatkan ASI eksklusif 6 bulan pada ibu di wilayah dengan banyak persalinan rumah (Kimani-Murage et al., 2021)
- b. Pemberian Makanan Bayi & Anak (PMBA) dan edukasi gizi
 - 1) Uji klaster berupa intervensi pada ibu hamil di Ethiopia: edukasi gizi berbasis model perilaku meningkatkan keragaman pangan (dietary diversity). Integrasi praktek Health Belief Model (HBM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) terbukti membantu meningkatkan perilaku makan sehat dengan: mengubah keyakinan dan persepsi risiko terkait gizi buruk, meningkatkan efikasi diri dan niat untuk mengonsumsi makanan beragam serta mengurangi pengaruh budaya atau pantangan makanan selama kehamilan (Beressa et al., 2025).
- c. Fortifikasi Mikronutrien
 - 1) Fortifikasi skala besar (tepung/gandum/beras/minyak) dengan zat besi dan asam folat : meta-analisis menunjukkan perbaikan status zat besi dan penurunan anemia pada perempuan usia reproduktif (Dorbu et al., 2025).
 - 2) Serbuk Multimikro Nutrien Powder (MNP) untuk balita: bukti kuat mencegah anemia defisiensi besi; panduan implementasi UNICEF (2022) menekankan desain & pemantauan program agar aman dan efektif (UNICEF, 2023).
 - 3) Program Universal Salt Iodization (USI) berupa garam beryodium analisis 2019/2020-an menegaskan manfaat kesehatan dan ekonomi jangka panjang dari USI dalam menekan gangguan akibat defisiensi iodium (Gorstein et al., 2020).
- d. Pencegahan dan tata laksana wasting berbasis komunitas
 - 1) Pedoman WHO 2023 memutakhirkan rekomendasi pencegahan & tata laksana wasting/oedema gizi, termasuk soal kebutuhan anak yang mengalami gizi kurang / buruk dan intervensi setelah pemulihan, menegaskan pendekatan komunitas atau pemberdayaan masyarakat sebagai tulang punggung (WHO, 2023).

- e. Pemberian makan di sekolah (School Feeding)
 - 1) Tinjauan sistematik & meta-analisis : program memberi dampak positif pada kehadiran sekolah, berat badan, serta beberapa capaian belajar; dapat berfungsi sebagai jaring pengaman gizi lokal jika dirancang dengan menu seimbang dan pemasok lokal (Wang et al., 2021).

Intervensi sensitif gizi (mengatasi determinan mendasar)

- a. Pertanian sensitif gizi & kebun rumah tangga (home gardening)
 - 1) Meta-analisis 2022 (JOGH): program pertanian sensitif gizi konsisten meningkatkan dietary diversity anak balita dan peluang mencapai minimum Dietary Diversity (Margolies et al., 2022).
 - 2) Tinjauan sistematik 2022 (Advances in Nutrition): memetakan jalur dampak (produksi-pendapatan-pengetahuan) dari intervensi pertanian terhadap hasil gizi. Peran sektor swasta sangat potensial untuk memperbaiki gizi masyarakat melalui: fortifikasi pangan skala besar, inovasi produk sehat yang terjangkau dan edukasi perilaku makan sehat (Sharma et al., 2021).
- b. Biofortifikasi (mis. ubi jalar oranye kaya provitamin A): bukti terbaru menunjukkan potensi bermakna menurunkan beban defisiensi vitamin A pada wilayah endemis (Lividini et al., 2024).
- c. Air, sanitasi, dan higienitas (WASH) terintegrasi
 - 1) Uji efektivitas besar kebersihan dan sanitasi (WASH) di Kenya dan Bangladesh dan SHINE (Zimbabwe) menunjukkan: paket WASH rumah tangga intensif tidak meningkatkan pertumbuhan linear, sementara pemberian makan bayi & anak memberi efek positif, pelajaran penting bahwa WASH rumah tangga saja tidak cukup untuk mencegah stunting, meski tetap esensial untuk kesehatan dan diare (Pickering et al., 2019).
- d. Perlindungan sosial (bantuan langsung tunai atau voucher dalam bentuk makanan)
 - 1) Meta-analisis 2020/pembaruan 2022 : cash transfer bernilai kecil-menengah namun signifikan pada pertumbuhan linear dan penurunan stunting bila ditargetkan tepat serta dipadukan dengan edukasi gizi (Manley et al., 2022).
 - 2) Uji komunitas: transfer tunai (dengan/tanpa edukasi) meningkatkan keragaman diet dan frekuensi makan anak 6-23 bulan (Rees et al., 2022).

3. Cara Menentukan Paket Intervensi di Tingkat Komunitas

- a. Langkah 1, Diagnostik cepat (food & care ecosystem)

Dimensi ketahanan pangan lokal baik empat atau enam dimensi; ukur keterjangkauan diet sehat (gunakan data harga lokal atau data The state of food security and nutrition sebagai acuan); praktik pemberian makan kepada bayi dan anak, akses layanan kesehatan, praktek sanitasi dan higiene, dan

dinamika gender dan agen perubahan yang di tempat (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022) .

b. Langkah2, Prioritaskan intervensi "campuran" spesifik + sensitif gizi

Contoh paket di desa pertanian rawan anemia dan stunting: edukasi pemberian makanan bayi dan anak disertai program dukungan menyusui (kader & kelompok sebaya); pemberian bubuk mikronutrien untuk anak 6–23 bulan sesuai protocol disertai dengan pemberdayaan masyarakat setempat; kebun gizi dan beternak disettai dengan pelatihan demo masak berbasis pangan lokal; air minum aman dan cuci tangan terintegrasi sebagai kegiatan yang fokus pencegahan diare; bantuan sosial bersyarat ringan (voucher pangan bergizi) bagi rumah tangga sangat miskin; fortifikasi massal (garam beryodium/tepung) melalui advokasi & penegakan mutu (Beressa et al., 2025; Dorbu et al., 2025; Kimani-Murage et al., 2021; Meera et al., 2021; Tewodros et al., 2024; Whittaker et al., 2025).

c. Langkah 3, Implementasi dan mutu layanan:

Standarisasi konseling untuk pemantauan pertumbuhan sebagai pintu masuk promosi sekaligus tindak lanjut. Peningkatan pemantauan pertumbuhan dapat dicapai dengan mengedukasi ibu melalui konseling, memperkuat penggunaan kartu kesehatan keluarga, serta mengintegrasikan pemantauan pertumbuhan dengan layanan kesehatan ibu seperti Ante Natal Care dan Post Natal Care (Simegn et al., 2024). Integrasi kegiatan intervensi dan pemantauan penanganan anak wasting dengan status gizi kurang dengan jaringan kader/posyandu/PKM (WHO, 2023)

d. Langkah 4, Monitoring & evaluasi (ringkas namun tajam):

Indikator proses: jangkauan konseling, kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, kehadiran sekolah untuk feeding, praktek pemberian makanan bayi dan anak. Indikator hasil: minimum dietary diversity anak & perempuan, kejadian diare 2 minggu, anemia (Hb kapiler), dan untuk evaluasi tahunan. Rujuk kerangka UNICEF 2020 agar indikator menutup aspek diet dan layanan-praktik (UNICEF, 2023).

E. Studi Kasus Dan Implementasi

1. Pengalaman Indonesia dalam Ketahanan Pangan

Indonesia memang memiliki sejarah panjang ketahanan pangan, dan beras, sebagai makanan pokok, telah menjadi fokus utama kebijakan ketahanan pangan. Sebagai negara yang dikenal dengan pertaniannya, Indonesia masih berjuang untuk mencapai swasembada pangan karena beberapa masalah klasik dalam pertanian seperti alih fungsi lahan pertanian, sumber daya manusia, input, dan lain-lain (Rozaki, 2021). Mengingat bahwa produksi lokal tidak dapat memenuhi permintaan pangan nasional, impor pangan diatur. Namun demikian, kebijakan ini tidak cocok untuk jangka waktu yang lama karena risiko ketergantungan impor pangan. Masalah klasik pertanian meliputi: alih fungsi lahan pertanian, sumber daya manusia yang terbatas, input pertanian yang tidak memadai dan infrastruktur yang kurang mendukung.

Tingkat ketahanan pangan di Indonesia bervariasi menurut wilayah, dan tergantung pada sumber daya dan kekayaan regional. Daerah yang lebih makmur tidak akan memiliki masalah mengenai ketahanan pangan. Jika mereka tidak dapat mencapai swasembada pangan, mereka dapat mengimpor makanan dari daerah lain. Sementara itu, daerah yang lebih miskin dengan sumber daya terbatas akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

2. Studi Kasus: Intervensi Berbasis Data

Studi kasus di Desa Idas, Kalimantan Barat, menunjukkan implementasi kebijakan berbasis data yang efektif. Pada tahun 2019, Idas masuk dalam kategori prioritas 1 atau "sangat rawan pangan". Sejak itu, beberapa intervensi dilakukan. Hasil Intervensi di Desa Idas:

- a. Perbaikan jalan tanah yang diperkuat yang menghubungkannya ke jalan utama di area tersebut untuk memudahkan akses petani ke pasar dan oleh karena itu meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara keseluruhan
- b. Distribusi benih kepada keluarga untuk membantu mereka diversifikasi diet mereka, bersama dengan tanaman lada untuk diversifikasi pendapatan mereka dari ketergantungan semata-mata pada karet dan minyak kelapa sawit
- c. Beberapa keluarga yang tidak memiliki air bersih sekarang terhubung ke sistem air desa (United Nations Indonesia, 2023).

3. Best Practices Internasional

Pengalaman perintis Escala Brasileira de Insegurança Alimentar adalah kunci untuk pengembangan Latin American and Caribbean Food Security Scale, yang, pada gilirannya, menjadi dasar FAO's Food Insecurity Experience Scale, yang telah diterapkan di >130 negara dan dimasukkan oleh FAO sebagai metrik resmi untuk menilai salah satu SDG terkait dengan pengurangan kelaparan (Pérez-Escamilla,

2017). Systematic review dan meta-analysis yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan merangkum informasi yang tersedia tentang efek intervensi nutrisi-spesifik berbasis komunitas pada peningkatan status gizi anak di bawah 5 tahun di negara-negara Eastern Mediterranean Region (EMR) menunjukkan hasil yang beragam. Pendidikan dan konseling gizi tentang pemberian makanan pelengkap anak dan penyediaan makanan melalui transfer tunai, voucher atau dalam bentuk barang adalah strategi nutrisi-spesifik utama yang digunakan untuk perbaikan status gizi anak-anak di wilayah tersebut. Ketika semua studi digabungkan, intervensi memiliki efek signifikan hanya pada status WHZ anak-anak (Ghodsi et al., 2021).

Evaluasi kualitatif program "Eat Healthy, Live Life" di East Harlem, lingkungan berpendapatan rendah di New York City, menunjukkan bahwa peserta mengadopsi perubahan perilaku sehat baru dan kupon Health Bucks membantu meningkatkan keterjangkauan produk segar. Program ini mungkin menjadi model yang efektif untuk berdampak pada perilaku kesehatan melalui promosi nutrisi yang baik, aktivitas fisik, dan pemanfaatan pasar petani di lingkungan berpendapatan rendah (Lu et al., 2023).

4. Inovasi dan Teknologi dalam Gizi Komunitas

Secara khusus, social cognitive theory diterapkan dalam tiga studi. Selain itu, satu studi menggabungkan kerangka membangun aset dengan social cognitive theory. Theory of planned behaviour dan model of goal-directed behaviour digunakan dalam studi lain, sedangkan studi terpisah menggunakan social media dan technology acceptance model. Studi lain menggunakan social learning theory (Ranisavljev et al., 2025). Semua intervensi yang diidentifikasi telah diintegrasikan ke dalam perawatan kesehatan rutin, termasuk promosi menyusui, imunisasi, air, sanitasi dan kebersihan (WASH), dan pemantauan dan promosi pertumbuhan (Ghodsi et al., 2021).

Penerapan penelitian saat ini dan teknologi yang dihasilkan dapat meningkatkan banyak intervensi lain yang dibahas sebelumnya. Dalam bidang mikronutrien, suplementasi berkala (dengan vitamin A dalam dosis tinggi) dapat diperluas melalui program komunitas, dan makanan yang diperkaya dan "sprinkles" mikronutrien dapat dipromosikan (Mason et al., 2006).

F. Penutup

Ketahanan pangan di Indonesia, baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Ketahanan pangan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kesehatan, di antaranya pendapatan, ukuran rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, serta status

kesehatan dan gizi anggota rumah tangga. Dampak pandemi COVID-19 semakin memperburuk ketahanan pangan, dengan banyak rumah tangga yang mengalami ketidakamanan pangan akibat penurunan pendapatan dan terbatasnya akses pangan yang bergizi. Oleh karena itu, kebijakan sosial dan ekonomi yang mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga, seperti pemberdayaan melalui modal sosial dan intervensi pemerintah, sangat penting untuk mengurangi kerawanan pangan.

Di tingkat wilayah, Indonesia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi distribusi pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan strategi seperti diversifikasi pangan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur pertanian. Program-program berbasis komunitas, seperti intervensi gizi dan promosi konsumsi pangan bergizi, terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Pendekatan berbasis bukti dan teori perubahan perilaku menjadi penting dalam merancang intervensi yang tepat sasaran.

Studi kasus di Indonesia, seperti di Desa Idas, menunjukkan bahwa intervensi berbasis data dan kebijakan yang terintegrasi dengan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan ketahanan pangan, terutama di daerah rawan pangan. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam gizi komunitas, Indonesia dapat memperkuat sistem ketahanan pangan di masa depan. Untuk itu, kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data serta kolaborasi antar sektor menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.

Pentingnya pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor pertanian, kesehatan, ekonomi, dan sosial dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang kuat di tingkat rumah tangga dan wilayah sangat bergantung pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi.

Referensi

- Badan Pangan Nasional. (2022). Indeks Ketahanan Pangan. *Indeks Ketahanan Pangan*, 58(12), 7250–7257.
- Béné, C., Oosterveer, P., Lamotte, L., Brouwer, I. D., de Haan, S., Prager, S. D., Talsma, E. F., & Houry, C. K. (2019). When food systems meet sustainability – Current narratives and implications for actions. *World Development*, 113(September), 116–130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.011>

- Beressa, G., Whiting, S. J., & Belachew, T. (2025). Effect of nutrition education integrating the health belief model and theory of planned behavior during pregnancy on gestational weight gain and birth weight in Southeast Ethiopia using complex analyses. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12884-025-07284-x>
- Burki, T. (2022). The State of Food Security and Nutrition In the World. In *The Lancet Diabetes and Endocrinology* (Vol. 10, Issue 9). [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00220-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00220-0)
- Coates, J., Anne, S., & Paula, B. (2007). Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide (Third, Issue August). Academy for Educational Development (AED).
- Dan, M., Ben, W., Wheeler, R., & Eastern, G. C. (2003). The Coping Strategies Index: A tool for rapidly measuring food security and the impact of food aid programmes in emergencies. In *The Coping Strategies Index: Field Methods Manual*. Nairobi: CARE and WFP. (Issue September). <http://www.fao.org/3/a-ae513e.pdf>
- Daulay, C. C., & Arka, S. (2025). Determinants of Indonesia's Food Security 2019 – 2023: A Panel Data Analysis. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 4(2).
- Department of Food Security and Animal Husbandry. (2020). Food Security and Vulnerability Atlas of North Sumatra Province 2020.
- Dorbu, A. D., Waddel, H. B., Chadha, M. K., de Romaña, D. L., Arabi, M., Moore, R. H., Mehta, C., & Pachón, H. (2025). Nutritional Anemia Reductions Due to Food Fortification Among Women of Childbearing Age: A Literature Review and Bayesian Meta-Analysis. *Maternal and Child Nutrition*. <https://doi.org/10.1111/mcn.13801>
- Fahmi, A. A. N. (2024). Analisis Cepat: Strategi Pangan Lokal Partisipatif dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. In Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas. https://komens.bappenas.go.idhttps://komens.bappenas.go.id/public/storage/files/1727249477_Analisis_Cepat_Strategi_Pangan_Lokal_Partisipatif_dalam_Mendukung_Ketahanan_Pangan_Nasional.pdf
- Febriansyah, E., Nurchaini, D. S., & Fathoni, Z. (2018). Pengaruh Program Desa Mandiri Pangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usahatani. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 21(1), 4. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v21i1.5093>

- Food and Agriculture Organization of the United (FAO). (2025). The future of food and agriculture: trends and challenges. In Food and Agriculture Organization of the United (FAO).
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World. In Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/ca5162en>
- Ghodsi, D., Omidvar, N., Nikooyeh, B., Roustaei, R., Shakibazadeh, E., & Al-Jawaldeh, A. (2021). Effectiveness of community nutrition-specific interventions on improving malnutrition of children under 5 years of age in the eastern mediterranean region: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15). <https://doi.org/10.3390/ijerph18157844>
- Global Network Against Food Crises. (2025). The Global Report on Food Crises (GRFC). In Global Network Against Food Crises. <https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2024-no-countries.pdf>. Accessed Oct. 13, 2024
- Gorstein, J. L., Bagriansky, J., Pearce, E. N., Kupka, R., & Zimmermann, M. B. (2020). Estimating the Health and Economic Benefits of Universal Salt Iodization Programs to Correct Iodine Deficiency Disorders. *Thyroid*, 30(12), 1802–1809. <https://doi.org/10.1089/thy.2019.0719>
- Jones, A. D., Ngure, F. M., Pelto, G., & Young, S. L. (2013). What Are We Assessing When We Measure Food Security ? A Compendium and Review of Current Metrics 1 , 2. 481–505. <https://doi.org/10.3945/an.113.004119.disciplines>
- Khan, A., Safdar, S., & Khan, G. (2025). Vol . 11 No . 1 (January -June 2025) pp . 43-57. *NUST JOURNAL OF SO*, 11(1), 43–57.
- Kimani-Murage, E. W., Kimiywe, J., Mutoro, A. N., Wilunda, C., Wekesah, F. M., Muriuki, P., Mwangi, B. M., Samburu, B. M., Madise, N. J., McGarvey, S. T., & Griffiths, P. L. (2021). Effectiveness of the baby-friendly community initiative on exclusive breastfeeding in Kenya. *Maternal and Child Nutrition*, 17(3), 1–11. <https://doi.org/10.1111/mcn.13142>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020). Strategi Kebijakan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga : Rekomendasi Berdasarkan Hasil Survei Daring September-Oktober 2020. In Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E - LIPI). https://ekonomi.lipi.go.id/public/images/publikasi/1619602983_Strategi_Kebijakan_Penanganan_Dampak.pdf

- Lestari, E., & Jiwa, S. (2018). Determinants of Household's Food and Nutrition Security in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(2), 105–115. <https://doi.org/10.14203/jep.26.2.2018.105-115>
- Lividini, K., Campos, H., Heck, S., Birol, E., & Hareau, G. (2024). Biofortified Orange-Fleshed Sweetpotato Can Meaningfully Reduce the Burden of Vitamin A Deficiency. *Current Developments in Nutrition*, 8, 102300. <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.102300>
- Lu, I., Suss, R., Lanza, D. V., Cohen, S., Yusuf, Y., & Yi, S. S. (2023). A qualitative study to inform the development of a subsidized community-supported agriculture program for Chinese Americans in Brooklyn, New York, U.S. *Preventive Medicine Reports*, 36(October), 102480. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2023.102480>
- Manikas, I., Ali, B. M., & Sundarakani, B. (2023). A systematic literature review of indicators measuring food security. *Agriculture and Food Security*, 12(1), 1–31. <https://doi.org/10.1186/s40066-023-00415-7>
- Manley, J., Alderman, H., & Gentilini, U. (2022). More evidence on cash transfers and child nutritional outcomes: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Global Health*, 7(4), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-008233>
- Margolies, A., Kemp, C. G., Choo, E. M., Levin, C., Olney, D., Kumar, N., Go, A., Alderman, H., & Gelli, A. (2022). Nutrition-sensitive agriculture programs increase dietary diversity in children under 5 years: A review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 12, 1–12. <https://doi.org/10.7189/JOGH.12.08001>
- Mason, J. B., Sanders, D., & Musgrove, P. (2006). Community Health and Nutrition Programs. In *he World Bank* (Issue January). The World Bank.
- Meera, S., Jeanine, C., Ali, P. M., & Sania, N. (2021). Maternal and Child Undernutrition: Progress Hinges on Supporting Women and More Implementation Research. *The Lancet*, 397(10282), 1329–1331.
- Pangaribowo, E. H., & Tsegai, D. (2011). ZEF-Discussion Papers on Development Policy No . 151 Food Demand Analysis of Indonesian Households with Particular Attention to the Poorest. *ZEF-Discussion Papers on Development Policy*, 151, 1–42. http://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/zef_dp/zef_dp_151.pdf
- Pérez-Escamilla, R. (2017). Food security and the 2015-2030 sustainable development goals: From human to planetary health. *Current Developments in Nutrition*, 1(7), 1–8. <https://doi.org/10.3945/cdn.117.000513>
- Pickering, A. J., Null, C., Winch, P. J., Mangwadu, G., Arnold, B. F., & Prendergast, A. J. (2019). The WASH Benefits and SHINE trials: interpretation of WASH intervention effects on linear growth and diarrhoea. *The Lancet Global Health*, 7(8).

- Prasetia, H. E., F. R. F., & Nuritsha, F. (2025). Potential of Local Functional Foods for Food Security in Indonesia : A Narrative Review. *Journal of FoodSecure Indonesia*, 1(1), 50–65.
- Pratiwi, R., Atmaka, D. R., Sutoyo, D. A. R., & Mahmudiono, T. (2023). The Effectiveness of Smartphone-Based Nutrition Education Intervention in Successful Practice of Exclusively Breastfeeding: A Meta-Analysis. *Amerta Nutrition*, 7(4), 615–625. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i4.2023.615-625>
- Putrie, D. A., & Rahman, A. (2020). Determinan ketahanan pangan berdasarkan proporsi pengeluaran pangan dan konsumsi energi (studi kasus pada rumah tangga di provinsi Kalimantan Barat). *Prosiding Seminar Nasional VARIANSI*, 77–86.
- R, L., K, W., A, B., R, W., M, C., ZJR, M., S, F., PJ, O., & S, M. (2023). Social and economic policy interventions to address household food insecurity in high-income countries (HIC) and the developing nations of Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, 167–186. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD015419.www.cochranelibrary.com>
- Ranisavljev, M., Kurniawan, A. L., Ferrero, E., Shinde, S., Zhao, S., Partap, U., Mkwanazi, N., Dah, N. C., Agure, E., Berhane, H. Y., Neumann, C., Alangea, D. O., Liu, S., Ostojic, S. M., Fawzi, W. W., Walsh, F., Bärnighausen, T., Ouédraogo, M., Napon, K., ... Laxy, M. (2025). Community-based interventions addressing multiple forms of malnutrition among adolescents in low- and middle-income countries: a scoping review. *Nutrition Journal*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12937-025-01136-2>
- Rees, C. A., Cleon, D., Davis, A. B., Sammy, A. M., Britto, C. D., Massaquoi, W., Forkpa, O. W., Johnson, A. J., Hook, V. F., MacAuley, J. A., Pewu, G. F., Gorpue, M., Gborie, A., Brown, T. T., Fannieh, A., Dweh, T., Marley, R. B., Baysah, M. K., Nowine, N. N., ... Zaizay, L. (2022). Cash transfers and nutrition education to improve dietary diversity among children aged 6-23 months in Grand Gedeh County, Liberia: a cluster-randomized trial. *Journal of Tropical Pediatrics*, 68(6), 1–10. <https://doi.org/10.1093/tropej/fmac096>
- Rozaki, Z. (2021). Food security challenges and opportunities in indonesia post COVID-19. In *Advances in Food Security and Sustainability* (1st ed., Vol. 6). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2021.07.002>
- Rusliyadi, M., Jamil, A. B. H. M., & Kumalasari, R. T. (2019). Analysis of household food security policy: Case of food security village programme, Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 9(1), 19–32. <https://doi.org/10.18488/journal.1005/2019.9.1/1005.1.19.32>

- Rusmawati, E., Hartono, D., & Aritenang, A. F. (2023). Food security in Indonesia: The Role of Social Capital. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2169732>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Sari, F. M. W., & Adi, A. C. (2018). Food Security and Coping Strategy of Households on the Gili Labak Isolated Island, Sumenep Regency Madura. *Media Gizi Indonesia*, 11(2), 153.
- Sharma, I. K., Di Prima, S., Essink, D., & Broerse, J. E. W. (2021). Nutrition-Sensitive Agriculture: A Systematic Review of Impact Pathways to Nutrition Outcomes. *Advances in Nutrition*, 12(1), 251–275. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa103>
- Simegn, M. B., Tilahun, W. M., Mazengia, E. M., Haimanot, A. B., Mneneh, A. L., Mengie, M. G., Endalew, B., Birhanu, M. Y., Tesfie, T. K., Asmare, L., & Geremew, H. (2024). Growth monitoring and promotion service utilization and its associated factors among children less than two years in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. *PLoS ONE*, 19(11 November), 1–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311531>
- Sumsion, R. M., June, H. M., & Cope, M. R. (2023). Measuring Food Insecurity: The Problem with Semantics. *Foods*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/foods12091816>
- Suryana, A. (2014). Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123–135.
- Syafiq, A., Fikawati, S., & Gemily, S. C. (2022). Household food security during the COVID-19 pandemic in urban and semi-urban areas in Indonesia. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 41(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s41043-022-00285-y>
- Tewodros, T., Escobar, C. X., Berra, L. S., & Webb Girard, A. (2024). Effectiveness of Elements of Social Behavior Change Activities in Nutrition-Sensitive Agriculture Programs: A Systematic Review. *Current Developments in Nutrition*, 8(8), 104420. <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.104420>
- The World Bank. (2025). Food Security Update.
- UNICEF. (2021). UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition. In *United Nations Children's Fund (UNICEF)* (pp. 2–3). [www.unicef.org/nutrition%0Afile:///C:/Users/HP/Documents/KULIAH/S E M E S T](http://www.unicef.org/nutrition%0Afile:///C:/Users/HP/Documents/KULIAH/S%20E%20M%20E%20S%20T)

- UNICEF. (2023). Home Fortification with Multiple Micronutrient Powders for the Prevention of Iron Deficiency Anaemia in Early Childhood Home Fortification With Multiple Micronutrient Powders For The Prevention Of Iron Deficiency. Unicef, July, 1–12.
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 1–27. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051>
- Whittaker, X., Meedya, S., & Capper, T. (2025). Factors and interventions that positively influence breastfeeding rates at six months postpartum: An integrative literature review. *Women and Birth*, 38(3), 101904. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2025.101904>
- WHO. (2023). WHO guideline on the prevention and management of wasting and nutritional oedema (acute malnutrition) in infants and children under 5 years. In World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/376075>

BAB V

PERENCANAAN PROGRAM DAN PEMBERDAYAAN KADER

A. Pendahuluan

Perencanaan program dalam bidang gizi komunitas merupakan salah satu langkah fundamental untuk mencapai tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan kesehatan, gizi menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap produktivitas, kesejahteraan ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perencanaan program gizi yang matang, sistematis, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin efektivitas intervensi yang dilakukan di lapangan.

Latar belakang munculnya kebutuhan akan perencanaan program gizi komunitas erat kaitannya dengan tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Perubahan pola konsumsi, urbanisasi, dan menurunnya aktivitas fisik telah menyebabkan terjadinya pergeseran masalah gizi dari kekurangan menuju kelebihan atau *double burden of malnutrition* (beban ganda masalah gizi). Di sisi lain, ketimpangan sosial-ekonomi dan ketidakmerataan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi persoalan klasik di berbagai daerah. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan untuk menjawab kompleksitas masalah tersebut. Tanpa perencanaan yang baik, kegiatan gizi sering kali bersifat reaktif, sporadis, dan tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat menjadi terbatas.

Urgensi perencanaan program gizi juga terlihat dari perannya sebagai jembatan antara kebijakan makro dan implementasi mikro di tingkat komunitas. Melalui proses perencanaan, setiap program dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini penting karena keberhasilan suatu program gizi tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis semata, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Dengan adanya perencanaan yang berbasis data dan partisipasi masyarakat, program gizi menjadi lebih relevan, adaptif, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Selain itu, perencanaan program membantu memaksimalkan

penggunaan sumber daya yang terbatas, baik dalam hal dana, tenaga, maupun waktu, sehingga kegiatan yang dijalankan lebih efisien dan efektif.

Dalam konteks implementasi di lapangan, keberhasilan program gizi komunitas sangat bergantung pada keterlibatan dan peran aktif para kader kesehatan. Kader merupakan ujung tombak pelaksanaan program, karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami kondisi sosial setempat, dan menjadi penghubung antara tenaga kesehatan profesional dengan komunitas. Peran strategis kader tidak hanya sebatas pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (change agent) yang mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan berorientasi pada gizi seimbang. Mereka menjadi sumber informasi yang dipercaya, pendamping keluarga dalam praktik pemberian makanan, serta penggerak kegiatan posyandu, penyuluhan, dan surveilans gizi di tingkat desa atau kelurahan.

Pemberdayaan kader menjadi sangat penting agar mereka mampu melaksanakan perannya secara optimal. Melalui pelatihan yang berkesinambungan, peningkatan kapasitas, dan dukungan moral maupun material, kader dapat mengembangkan kompetensi dalam menyampaikan pesan-pesan gizi secara efektif kepada masyarakat. Selain itu, pemberdayaan kader juga berkontribusi terhadap kemandirian komunitas dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga. Dengan demikian, keterlibatan kader dalam seluruh proses perencanaan—mulai dari identifikasi masalah, penyusunan strategi, hingga evaluasi program—menjadi kunci bagi keberhasilan intervensi gizi di tingkat komunitas.

B. Konsep Dasar Perencanaan Program Gizi Komunitas

1. Pengertian dan tujuan perencanaan program

Perencanaan program gizi komunitas merupakan proses sistematis untuk merumuskan serangkaian kegiatan yang bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat melalui pendekatan yang terarah, terukur, dan berbasis pada kebutuhan nyata. Secara konseptual, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir rasional yang melibatkan analisis situasi, penentuan tujuan, pemilihan strategi, penyusunan langkah operasional, serta evaluasi terhadap hasil yang diharapkan. Dalam konteks gizi komunitas, perencanaan program tidak hanya berfokus pada kegiatan teknis seperti pemberian suplemen atau penyuluhan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku yang memengaruhi konsumsi serta pola makan masyarakat.

Tujuan utama dari perencanaan program gizi adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat. Melalui perencanaan yang baik, program dapat berjalan secara efisien, menghindari duplikasi kegiatan, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang

tersedia. Selain itu, perencanaan bertujuan untuk menjamin keterpaduan antar sektor, seperti sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan, dalam menangani permasalahan gizi yang kompleks dan multidimensi. Dengan demikian, perencanaan program gizi komunitas menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan kegiatan yang efektif, serta pengukuran keberhasilan program secara objektif dan berkelanjutan.

Selain berfungsi sebagai alat manajemen, perencanaan juga memiliki dimensi sosial yang penting. Melalui perencanaan, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, menetapkan prioritas, dan menentukan solusi yang sesuai dengan kondisi mereka. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program, tetapi juga memperkuat keberlanjutan hasil intervensi gizi. Oleh karena itu, perencanaan program gizi komunitas harus selalu berpihak pada masyarakat, inklusif, dan berorientasi pada kemandirian.

2. Prinsip-prinsip perencanaan berbasis masyarakat

Perencanaan berbasis masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan proses perencanaan. Pendekatan ini berpijak pada keyakinan bahwa masyarakat adalah subjek, bukan objek, dari pembangunan kesehatan. Prinsip ini sangat relevan dalam bidang gizi komunitas, karena perubahan perilaku makan, pola konsumsi, dan praktik kesehatan keluarga tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan harus tumbuh dari kesadaran dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Salah satu prinsip utama dalam perencanaan berbasis masyarakat adalah partisipasi aktif. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat sejak tahap awal, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil program. Dengan partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut bertanggung jawab dalam keberhasilan program. Prinsip berikutnya adalah kemandirian. Program gizi yang baik harus mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan melanjutkan kegiatan tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan, termasuk melalui penguatan peran kader sebagai penggerak utama.

Prinsip lainnya adalah kontekstualitas dan kesesuaian lokal. Setiap komunitas memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, program gizi yang dirancang harus mempertimbangkan kearifan lokal, kebiasaan makan, serta sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat. Program yang disesuaikan dengan konteks lokal akan lebih mudah diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Prinsip kolaborasi lintas sektor juga menjadi pilar penting, mengingat masalah gizi tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan, tetapi juga oleh ketersediaan pangan, pendidikan, sanitasi, dan ekonomi. Oleh

karena itu, keterlibatan berbagai pihak — pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha — diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, perencanaan berbasis masyarakat harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap keputusan dan penggunaan sumber daya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui tujuan, hasil, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Prinsip berkelanjutan (sustainability) juga tidak kalah penting, memastikan bahwa dampak positif program dapat terus dirasakan dalam jangka panjang, bahkan setelah dukungan eksternal berakhir. Dengan menerapkan seluruh prinsip tersebut, perencanaan program gizi komunitas dapat menjadi proses yang inklusif, efektif, dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Tahapan umum dalam perencanaan program gizi

Perencanaan program gizi komunitas dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan dan membentuk siklus berkelanjutan. Tahapan pertama adalah analisis situasi, yaitu proses pengumpulan dan analisis data terkait kondisi gizi, kesehatan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya di masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat meliputi status gizi balita, pola konsumsi pangan, ketersediaan pangan lokal, tingkat pengetahuan gizi masyarakat, hingga aspek sosial ekonomi. Analisis ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah utama dan menentukan prioritas intervensi yang paling mendesak.

Tahapan berikutnya adalah penetapan tujuan dan sasaran program. Tujuan dirumuskan berdasarkan hasil analisis situasi dan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, serta berbatas waktu (SMART). Sasaran program dapat berupa kelompok tertentu seperti ibu hamil, balita, remaja, atau keluarga miskin yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah gizi. Dengan penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, arah kegiatan program menjadi lebih fokus dan mudah dievaluasi.

Tahap ketiga adalah penyusunan strategi dan rencana kegiatan, yang mencakup pemilihan pendekatan intervensi yang tepat, seperti edukasi gizi, fortifikasi pangan, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, atau penguatan layanan posyandu. Pada tahap ini, diperlukan juga perencanaan sumber daya baik sumber daya manusia, dana, maupun sarana — serta penyusunan jadwal pelaksanaan dan mekanisme koordinasi antar pihak terkait. Penyusunan rencana kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan dan potensi masyarakat agar implementasi dapat berjalan dengan lancar.

Tahapan keempat adalah pelaksanaan program, yaitu penerapan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan, peran kader sangat penting sebagai pelaksana lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Mereka membantu menyampaikan pesan gizi, memantau perubahan perilaku, serta melaporkan perkembangan kegiatan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap ini akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Sementara evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program terhadap perubahan status gizi masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan berikutnya, sehingga proses perencanaan menjadi siklus yang dinamis dan adaptif. Dengan mengikuti tahapan ini secara sistematis, program gizi komunitas akan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

C. Analisis Situasi dan Identifikasi Masalah Gizi

1. Pengumpulan data dan informasi gizi masyarakat

Tahap awal dalam perencanaan program gizi komunitas adalah pengumpulan data dan informasi yang komprehensif mengenai kondisi gizi masyarakat. Langkah ini merupakan fondasi penting yang menentukan kualitas perencanaan program secara keseluruhan. Data yang dikumpulkan berfungsi untuk menggambarkan situasi nyata di lapangan, mengidentifikasi permasalahan utama, serta mengenali faktor-faktor penyebab yang memengaruhi status gizi individu maupun kelompok. Tanpa data yang akurat, perencanaan program berisiko tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan sulit dievaluasi keberhasilannya.

Pengumpulan data gizi mencakup berbagai aspek, antara lain data status gizi, konsumsi pangan, pola makan, kesehatan lingkungan, sosial ekonomi, serta perilaku dan pengetahuan masyarakat terkait gizi. Data status gizi dapat diperoleh melalui pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA), atau indeks massa tubuh (IMT). Sementara itu, data konsumsi pangan biasanya dikumpulkan melalui metode recall 24 jam, food frequency questionnaire (FFQ), atau catatan konsumsi rumah tangga. Di samping itu, informasi tentang kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan ketersediaan pangan lokal juga penting karena berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizinya.

Sumber data dapat berasal dari berbagai pihak, baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui survei, wawancara, observasi, atau kegiatan posyandu. Sedangkan data sekunder dapat diambil dari laporan instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, maupun hasil riset lembaga pendidikan. Dalam proses pengumpulan data, perlu diterapkan prinsip validitas, reliabilitas, dan representativitas agar hasilnya dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya. Selain itu, kader gizi dan petugas lapangan berperan penting

dalam membantu pengumpulan data karena mereka memiliki akses langsung dan kepercayaan dari masyarakat setempat. Dengan pengumpulan data yang terencana dan berkualitas, maka dasar analisis yang dihasilkan akan kuat dan dapat dijadikan pijakan untuk menentukan arah intervensi gizi yang efektif.

2. Analisis kebutuhan dan prioritas masalah

3. Penetapan sasaran dan tujuan program

D. Perancangan Strategi dan Kegiatan Program

1. Penentuan strategi intervensi gizi

Setelah data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan dan menetapkan prioritas masalah gizi yang perlu segera ditangani. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah serta memahami konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Proses ini tidak hanya memusatkan perhatian pada gejala, tetapi juga menelusuri faktor-faktor mendasar seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan gizi, terbatasnya akses terhadap pangan bergizi, dan kondisi sanitasi yang buruk.

Dalam melakukan analisis kebutuhan, digunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah causal analysis atau analisis sebab-akibat. Pendekatan ini membantu menggambarkan hubungan antara masalah gizi dengan faktor-faktor determinannya, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, tingginya angka balita stunting dapat disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, praktik pemberian makanan pendamping ASI yang salah, serta rendahnya akses terhadap air bersih. Dengan memahami hubungan sebab-akibat tersebut, perencana program dapat menentukan jenis intervensi yang paling tepat dan relevan dengan konteks lokal.

Penetapan prioritas masalah dilakukan karena tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus, terutama bila sumber daya terbatas. Untuk itu, diperlukan metode penentuan prioritas seperti scoring system, Hanlon method, atau focus group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Prinsip utama dalam penetapan prioritas adalah mempertimbangkan besarnya masalah (magnitude), tingkat keseriusan (severity), serta kemungkinan untuk ditangani (feasibility). Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dilibatkan dalam menentukan masalah mana yang dianggap paling mendesak dan penting untuk segera diatasi.

Analisis kebutuhan yang baik tidak hanya menghasilkan daftar masalah, tetapi juga memberikan gambaran potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, jika masyarakat memiliki sumber daya pangan lokal yang kaya protein, maka program dapat difokuskan

pada peningkatan pemanfaatan bahan pangan tersebut. Dengan demikian, hasil analisis kebutuhan dan prioritas masalah menjadi dasar rasional untuk menyusun tujuan dan strategi program gizi komunitas yang efektif dan berkelanjutan.

2. Penyusunan rencana kegiatan, jadwal, dan anggaran

Setelah data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan dan menetapkan prioritas masalah gizi yang perlu segera ditangani. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah serta memahami konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Proses ini tidak hanya memusatkan perhatian pada gejala, tetapi juga menelusuri faktor-faktor mendasar seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan gizi, terbatasnya akses terhadap pangan bergizi, dan kondisi sanitasi yang buruk.

Dalam melakukan analisis kebutuhan, digunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah causal analysis atau analisis sebab-akibat. Pendekatan ini membantu menggambarkan hubungan antara masalah gizi dengan faktor-faktor determinannya, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, tingginya angka balita stunting dapat disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, praktik pemberian makanan pendamping ASI yang salah, serta rendahnya akses terhadap air bersih. Dengan memahami hubungan sebab-akibat tersebut, perencana program dapat menentukan jenis intervensi yang paling tepat dan relevan dengan konteks lokal.

Penetapan prioritas masalah dilakukan karena tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus, terutama bila sumber daya terbatas. Untuk itu, diperlukan metode penentuan prioritas seperti scoring system, Hanlon method, atau focus group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Prinsip utama dalam penetapan prioritas adalah mempertimbangkan besarnya masalah (magnitude), tingkat keseriusan (severity), serta kemungkinan untuk ditangani (feasibility). Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dilibatkan dalam menentukan masalah mana yang dianggap paling mendesak dan penting untuk segera diatasi.

Analisis kebutuhan yang baik tidak hanya menghasilkan daftar masalah, tetapi juga memberikan gambaran potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, jika masyarakat memiliki sumber daya pangan lokal yang kaya protein, maka program dapat difokuskan pada peningkatan pemanfaatan bahan pangan tersebut. Dengan demikian, hasil analisis kebutuhan dan prioritas masalah menjadi dasar rasional untuk menyusun tujuan dan strategi program gizi komunitas yang efektif dan berkelanjutan.

3. Indikator kinerja dan hasil yang diharapkan

Tahap berikutnya setelah melakukan analisis situasi dan penentuan prioritas masalah adalah menetapkan sasaran dan tujuan program. Sasaran program menggambarkan siapa yang menjadi target penerima manfaat dari kegiatan gizi yang akan dilaksanakan, sedangkan tujuan program menjelaskan arah dan hasil yang ingin dicapai. Kedua hal ini harus dirumuskan secara jelas agar pelaksanaan program dapat terukur dan dievaluasi keberhasilannya.

Penetapan sasaran dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah gizi yang ditemukan pada tahap analisis sebelumnya. Misalnya, jika data menunjukkan tingginya angka stunting pada anak usia di bawah dua tahun (baduta), maka kelompok sasaran utama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak baduta. Namun, dalam pendekatan komunitas, sasaran tidak hanya mencakup individu yang berisiko, tetapi juga lingkungan sosial yang memengaruhi perilaku gizi, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Penetapan sasaran juga harus mempertimbangkan aspek geografis (desa, kecamatan, wilayah kerja puskesmas), sosial ekonomi, dan budaya agar intervensi lebih tepat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Sementara itu, tujuan program dirumuskan berdasarkan prinsip SMART — Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Artinya, tujuan harus spesifik (jelas dan terarah), dapat diukur (memiliki indikator keberhasilan), realistis untuk dicapai, relevan dengan masalah yang ada, dan memiliki batas waktu pencapaian yang terukur. Contohnya, tujuan program dapat berupa “menurunkan prevalensi balita stunting sebesar 10% dalam kurun waktu tiga tahun melalui peningkatan asupan gizi dan perilaku hidup sehat keluarga.” Tujuan seperti ini memberikan arah yang konkret bagi pelaksana program dan menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan serta indikator kinerja.

Penetapan sasaran dan tujuan juga sebaiknya dilakukan secara partisipatif, melibatkan kader, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok sasaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan yang telah disepakati. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat komitmen lokal, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Akhirnya, kejelasan sasaran dan tujuan akan menjadi kompas utama dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi komunitas, sehingga setiap langkah yang diambil selalu terarah pada pencapaian perbaikan status gizi masyarakat secara berkelanjutan.

E. Pemberdayaan Kader Gizi dan Kesehatan

1. Peran kader dalam program gizi komunitas

Kader gizi dan kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Mereka adalah perpanjangan tangan tenaga

kesehatan profesional yang bekerja langsung di lapangan, menjembatani interaksi antara fasilitas kesehatan dan masyarakat. Keberadaan kader sangat penting karena mereka mengenal dengan baik kondisi sosial, budaya, dan karakter masyarakat setempat. Dengan kedekatan ini, kader memiliki posisi strategis dalam menyampaikan pesan-pesan gizi, mendorong perubahan perilaku, dan memobilisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan.

Peran kader dalam program gizi komunitas sangat beragam dan meliputi aspek promotif, preventif, dan kadang juga kuratif sederhana. Dalam peran promotif, kader berfungsi sebagai pendidik masyarakat, menyampaikan informasi tentang gizi seimbang, pola makan sehat, pentingnya ASI eksklusif, dan pencegahan anemia maupun stunting. Mereka juga menjadi fasilitator dalam kegiatan posyandu, membantu pelaksanaan penimbangan balita, pencatatan status gizi, serta memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu dan keluarga.

Dalam aspek preventif, kader berperan dalam deteksi dini masalah gizi dan kesehatan, misalnya dengan mengidentifikasi anak dengan berat badan kurang, memantau perkembangan ibu hamil, atau mengamati kasus penyakit infeksi yang berpotensi mengganggu status gizi. Selain itu, kader juga menjadi agen perubahan sosial (change agent), yang berperan membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Mereka tidak hanya menjalankan program yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga menginisiasi kegiatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti kebun gizi, dapur sehat, atau kelas ibu balita.

Dengan demikian, keberhasilan program gizi komunitas sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen kader. Tanpa keterlibatan aktif kader, intervensi gizi sering kali tidak menjangkau masyarakat sasaran secara efektif. Oleh karena itu, pemberdayaan kader bukan hanya menjadi pelengkap program, melainkan komponen inti dari strategi peningkatan gizi masyarakat.

2. Rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan kader

Proses rekrutmen kader merupakan langkah awal yang menentukan kualitas pelaksanaan program gizi di masyarakat. Rekrutmen biasanya dilakukan oleh pihak puskesmas, pemerintah desa, atau organisasi masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa kriteria penting, seperti domisili di wilayah setempat, kemampuan komunikasi yang baik, kemauan untuk berperan aktif, dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, kader idealnya memiliki minat dalam bidang kesehatan dan gizi, serta kesediaan bekerja secara sukarela demi kepentingan bersama. Proses rekrutmen ini sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat agar kader yang dipilih benar-benar representatif dan diterima oleh warga.

Setelah kader terpilih, langkah berikutnya adalah pelatihan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Pelatihan kader gizi meliputi materi tentang dasar-dasar gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan, pencatatan dan pelaporan, komunikasi interpersonal, serta teknik penyuluhan. Metode pelatihan hendaknya bersifat partisipatif, menggunakan pendekatan *learning by doing*, studi kasus, dan simulasi agar kader tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dalam praktik sehari-hari. Selain pelatihan awal, kader perlu mendapatkan pelatihan penyegaran (*refreshing training*) secara berkala untuk memperbarui pengetahuan mereka terhadap kebijakan dan inovasi program gizi yang terus berkembang.

Pembinaan kader merupakan bagian integral dari pemberdayaan yang berkelanjutan. Pembinaan mencakup kegiatan pendampingan, supervisi, dan evaluasi kinerja kader oleh petugas puskesmas atau tim pembina di tingkat kecamatan dan kabupaten. Melalui pembinaan, kader memperoleh bimbingan teknis, motivasi, serta umpan balik terhadap pelaksanaan tugas mereka di lapangan. Pembinaan juga berfungsi menjaga semangat kader agar tetap aktif dan konsisten dalam menjalankan perannya. Dalam banyak kasus, pembinaan yang bersifat suportif dan apresiatif terbukti lebih efektif daripada pendekatan yang bersifat instruktif semata. Oleh karena itu, sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kualitas dan keberlanjutan peran kader di masyarakat.

3. Strategi motivasi dan peningkatan kapasitas kader

Kader kesehatan dan gizi bekerja dengan semangat pengabdian, sehingga motivasi menjadi unsur penting yang harus dijaga agar mereka tetap aktif dan produktif. Banyak kader bekerja secara sukarela tanpa imbalan tetap, sehingga bentuk motivasi non-material sering kali lebih bermakna. Motivasi dapat diberikan melalui pengakuan sosial, penghargaan atas prestasi, kesempatan berpartisipasi dalam pelatihan, atau kepercayaan untuk memimpin kegiatan di komunitas. Dukungan moral dari petugas kesehatan, aparat desa, dan masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap semangat kader. Ketika kader merasa dihargai dan diakui kontribusinya, mereka cenderung lebih berkomitmen terhadap tugasnya.

Selain motivasi, peningkatan kapasitas kader merupakan strategi penting untuk memperkuat kinerja mereka. Kapasitas di sini mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*). Upaya peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan lanjutan, lokakarya, kunjungan studi antar daerah, serta penyediaan bahan ajar dan media edukatif yang mudah digunakan. Dengan kemampuan yang terus berkembang, kader tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga mampu menjadi pemimpin komunitas dalam promosi gizi dan kesehatan.

Pendekatan pemberdayaan kader yang efektif harus bersifat holistik dan berorientasi pada keberlanjutan. Artinya, pengembangan kapasitas kader tidak boleh berhenti pada pelatihan sesaat, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan yang diintegrasikan dengan sistem pembinaan dan dukungan yang konsisten. Pemerintah daerah, puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan jejaring dukungan kader, termasuk dalam bentuk kelompok belajar kader, forum komunikasi, atau komunitas berbagi pengalaman (peer learning network).

F. Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan Program

1. Prinsip dan metode monitoring-evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam siklus perencanaan program gizi komunitas. Keduanya berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sumber daya dimanfaatkan secara efektif, dan tujuan program dapat tercapai secara optimal. Tanpa monitoring dan evaluasi yang baik, keberhasilan program sulit diukur, kesalahan tidak dapat diperbaiki tepat waktu, dan keberlanjutan program menjadi tidak terjamin.

Monitoring adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pelaksanaan kegiatan program dari waktu ke waktu. Tujuan utama monitoring adalah untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan. Monitoring bersifat rutin dan dilakukan selama program berlangsung. Dalam konteks gizi komunitas, kegiatan monitoring dapat berupa pemantauan kehadiran kader, pelaksanaan posyandu, penimbangan balita, tingkat partisipasi masyarakat, maupun distribusi bahan pangan tambahan.

Sementara itu, evaluasi merupakan proses penilaian secara menyeluruh terhadap relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak program setelah dilaksanakan dalam periode tertentu. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan apakah intervensi yang dilakukan memberikan perubahan signifikan terhadap status gizi dan perilaku masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif (selama program masih berjalan untuk memperbaiki pelaksanaan) dan sumatif (setelah program selesai untuk menilai hasil akhir).

Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi harus berpedoman pada beberapa prinsip dasar, yaitu objektivitas, partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan. Objektivitas menuntut agar proses pengumpulan data dan penilaian dilakukan berdasarkan fakta dan indikator yang jelas, bukan asumsi atau pendapat pribadi. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat dan kader, dalam proses pemantauan agar hasilnya lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak. Transparansi

diperlukan agar hasil monitoring dan evaluasi dapat diakses oleh pihak terkait dan digunakan sebagai bahan pembelajaran bersama. Sementara prinsip keberlanjutan berarti proses monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan rutin yang terintegrasi dalam sistem kerja komunitas, bukan sekadar kegiatan proyek sementara.

Metode yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi program gizi cukup beragam, mulai dari pendekatan kuantitatif hingga kualitatif. Metode kuantitatif meliputi pengukuran indikator kinerja seperti prevalensi stunting, status gizi balita, tingkat konsumsi pangan, atau angka partisipasi posyandu. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami aspek perilaku, persepsi masyarakat, dan faktor sosial budaya yang memengaruhi keberhasilan program, melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan observasi partisipatif. Kombinasi kedua metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas program.

2. Pelibatan kader dalam evaluasi partisipatif

Kader gizi dan kesehatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan evaluasi partisipatif. Pendekatan ini menempatkan kader dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses evaluasi, bukan sekadar penerima hasil penilaian. Evaluasi partisipatif bertujuan membangun rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menilai dan memperbaiki kegiatan yang mereka jalankan sendiri.

Keterlibatan kader dalam evaluasi partisipatif memiliki beberapa manfaat strategis. Pertama, kader lebih mengenal kondisi sosial dan budaya masyarakat, sehingga mampu menginterpretasikan hasil pengamatan dengan lebih akurat. Kedua, kader memiliki kedekatan emosional dengan sasaran program, yang membuat masyarakat lebih terbuka dalam memberikan masukan dan umpan balik. Ketiga, dengan dilibatkan dalam evaluasi, kader memperoleh pengalaman belajar yang memperkuat kapasitas analitis dan kepemimpinannya dalam komunitas.

Dalam praktiknya, pelibatan kader dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengisian formulir pemantauan, pencatatan hasil posyandu, diskusi kelompok reflektif, atau forum evaluasi tahunan di tingkat desa. Misalnya, setelah kegiatan penyuluhan gizi, kader dapat melakukan wawancara sederhana kepada peserta untuk menilai sejauh mana pesan yang disampaikan dipahami dan diterapkan. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada petugas puskesmas untuk dianalisis bersama. Dengan demikian, proses evaluasi tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran sosial bagi masyarakat.

Pelibatan kader dalam evaluasi juga memperkuat mekanisme akuntabilitas publik. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan program, hasil yang telah

dicapai, serta tantangan yang dihadapi. Kader menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara program, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan. Dengan pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sarana pemberdayaan dan penguatan kapasitas komunitas.

3. Upaya menjaga keberlanjutan dan kemandirian komunitas

Keberlanjutan program gizi komunitas merupakan tujuan akhir dari seluruh rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program yang berkelanjutan adalah program yang tetap berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang, bahkan setelah dukungan eksternal seperti dana atau tenaga ahli berakhir. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan strategi yang memadukan aspek kelembagaan, sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

Salah satu kunci utama menjaga keberlanjutan program adalah pemberdayaan masyarakat dan kader. Ketika masyarakat merasa memiliki dan mampu mengelola program secara mandiri, maka ketergantungan terhadap pihak luar akan berkurang. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, serta penguatan jejaring kerja antar lembaga di tingkat lokal. Misalnya, kader dan masyarakat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif seperti kebun gizi, kelompok pangan olahan, atau warung sehat yang sekaligus menjadi sumber dana mandiri untuk mendukung kegiatan gizi.

Aspek kelembagaan juga perlu diperkuat dengan membangun mekanisme organisasi yang jelas dan berkelanjutan. Misalnya, pembentukan tim gizi desa atau forum kesehatan masyarakat yang memiliki struktur kepemimpinan dan tanggung jawab yang terdefinisi. Lembaga ini dapat menjadi wadah koordinasi, advokasi kebijakan, dan pengelolaan sumber daya lokal untuk mendukung kegiatan gizi. Selain itu, keberlanjutan dapat dijaga melalui integrasi program gizi ke dalam rencana pembangunan desa (RPJMDes), sehingga kegiatan gizi tidak hanya menjadi proyek sementara, tetapi bagian dari agenda pembangunan jangka panjang.

Kemandirian komunitas juga dapat diperkuat melalui kemitraan lintas sektor. Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan institusi pendidikan dapat memperluas dukungan sumber daya serta memperkuat inovasi program. Misalnya, universitas dapat berperan dalam pendampingan teknis dan penelitian, sementara sektor swasta dapat membantu dalam penyediaan sarana edukatif atau dukungan logistik.

Terakhir, keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh komitmen dan motivasi kader. Kader yang termotivasi akan menjadi penggerak utama dalam menjaga semangat masyarakat untuk terus melaksanakan kegiatan. Oleh karena

itu, penghargaan, pelatihan berkelanjutan, serta pengakuan atas peran kader harus menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan.

Dengan kombinasi antara pemberdayaan, kelembagaan yang kuat, dukungan lintas sektor, dan motivasi kader yang terus dipelihara, program gizi komunitas tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

G. Penutup

Perencanaan program gizi komunitas merupakan landasan penting bagi keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Proses ini bukan sekadar menyusun kegiatan, tetapi merupakan suatu pendekatan terpadu yang melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan, strategi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kecermatan teknis dalam perencanaan, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh partisipasi aktif berbagai pihak di lapangan.

Dalam konteks gizi komunitas, pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci utama. Masyarakat tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran sentral dalam setiap tahapan program mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Melalui prinsip partisipasi, kemandirian, dan kolaborasi lintas sektor, perencanaan program gizi dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal. Pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga keberlanjutan program meskipun dukungan eksternal berakhir.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada peran kader gizi dan kesehatan sebagai penggerak utama di tingkat komunitas. Kader berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai perilaku hidup sehat dan gizi seimbang di masyarakat. Melalui pelatihan, pembinaan, dan motivasi yang berkelanjutan, kader dapat mengembangkan kapasitas mereka untuk menjadi pemimpin lokal dalam upaya peningkatan gizi. Oleh karena itu, pemberdayaan kader bukan hanya bagian dari kegiatan program, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap masalah gizi.

Selanjutnya, keberlanjutan program hanya dapat dicapai melalui sistem monitoring dan evaluasi yang efektif serta partisipatif. Proses pemantauan dan penilaian bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bersama antara masyarakat, kader, dan tenaga kesehatan. Dengan pelibatan kader dalam evaluasi partisipatif, data dan informasi

yang dihasilkan menjadi lebih realistis dan kontekstual, serta membuka ruang refleksi kolektif bagi perbaikan program di masa mendatang.

Aspek keberlanjutan dan kemandirian komunitas menjadi tujuan akhir yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan. Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pembentukan kelembagaan lokal, dan kemitraan lintas sektor, program gizi komunitas dapat terus hidup dan berkembang meskipun dukungan eksternal berkurang. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan pangannya sendiri.

Secara keseluruhan, sinergi antara perencanaan program yang matang, pemberdayaan kader yang kuat, dan sistem evaluasi yang partisipatif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, dan mandiri. Program gizi komunitas yang dirancang dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan tidak hanya memperbaiki status gizi individu, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan program gizi komunitas mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia yang sesungguhnya pembangunan yang berpihak pada rakyat, berbasis pada potensi lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Referensi

- Ahmad, F., & Wahyuni, R. (2021). *Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arisman. (2019). *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: EGC.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Program Gizi di Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Dwiriani, C. M., & Hardinsyah. (2017). *Gizi Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Hardinsyah, & Martianto, D. (2014). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi Komunitas*. Bogor: IPB Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015–2019*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Purwanti, D., & Lestari, A. (2020). Pemberdayaan Kader Posyandu dalam Upaya Perbaikan Gizi Balita. Yogyakarta: Deepublish.
- Sediaoetama, A. D. (2010). Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Dian Rakyat.
- Soekirman. (2016). Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Mahasiswa dan Profesi di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Supriasa, I. D. N., Bakri, B., & Fajar, I. (2016). Penilaian Status Gizi. Jakarta: EGC.
- World Health Organization (WHO). (2018). Guideline: Implementing Effective Nutrition Interventions in the Community. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2021). Nutrition in Communities: Building Capacity for Sustainable Health. Geneva: WHO Press.

BAB VI

GIZI DALAM SITUASI DARURAT DAN KETAHANAN KOMUNITAS

A. Pendahuluan

Gizi merupakan salah satu determinan paling awal yang terpengaruh ketika komunitas menghadapi situasi darurat—baik akibat bencana alam, konflik, pandemi, maupun krisis pangan. Pada saat sistem pangan terguncang, akses terhadap layanan kesehatan terganggu, dan lingkungan tempat tinggal berubah secara mendadak, status gizi penduduk akan cepat memburuk. Kekurangan asupan energi dan zat gizi esensial berpadu dengan meningkatnya paparan penyakit infeksi membentuk lingkaran setan yang menurunkan imunitas, memperberat morbiditas, dan pada akhirnya meningkatkan mortalitas, terutama pada kelompok rentan. Karena itu, respons kemanusiaan yang efektif tidak dapat memisahkan penyelamatan jiwa dari perlindungan status gizi keduanya adalah dua sisi dari satu kebutuhan mendesak: menjaga fungsi-fungsi vital manusia agar tetap bertahan, pulih, dan mampu beradaptasi.

Karakter situasi darurat ditandai oleh disrupsi simultan pada empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Banjir yang merusak lahan pertanian, gempa yang memutus rantai pasok, konflik yang membatasi mobilitas, atau pandemi yang melumpuhkan ekonomi rumah tangga—semuanya dapat menggerus kemampuan keluarga untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Gangguan air bersih dan sanitasi mempercepat transmisi penyakit diare atau infeksi saluran napas akut yang menghambat penyerapan gizi. Pada saat yang sama, pusat layanan kesehatan dan pos gizi sering kali tidak berfungsi optimal karena kerusakan fasilitas, kekurangan tenaga, atau terhambatnya logistik. Kombinasi faktor ini membuat penurunan status gizi dapat terjadi sangat cepat, bahkan pada rumah tangga yang sebelumnya tidak dikategorikan rawan pangan.

Dampak tersebut tidak merata; kelompok tertentu memikul beban yang lebih berat. Bayi dan balita berada pada fase tumbuh kembang pesat dengan kebutuhan gizi per kilogram berat badan yang tinggi namun cadangan metabolik yang rendah. Ibu hamil dan menyusui membutuhkan energi dan mikronutrien tambahan untuk mendukung kesehatan dirinya sekaligus janin atau bayi, sehingga defisit asupan pada periode ini berimplikasi ganda—bagi ibu dan generasi berikutnya. Lansia kerap menghadapi keterbatasan mobilitas, kondisi kronis (seperti diabetes atau

hipertensi), serta penurunan nafsu makan dan kemampuan mengunyah, yang memperbesar risiko malnutrisi dan dehidrasi ketika akses layanan terganggu. Individu dengan disabilitas, penyakit kronis, atau status sosial-ekonomi paling bawah juga menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh bantuan. Mengabaikan kerentanan-kerentanan ini berarti menempatkan kelompok-kelompok tersebut pada jalur risiko yang tidak proporsional terhadap morbiditas dan mortalitas.

Dalam konteks inilah urgensi sistem tanggap gizi yang cepat dan terkoordinasi menjadi jelas. Respons yang efektif menuntut mekanisme kewaspadaan dini, penilaian kebutuhan yang cepat namun akurat, serta pengambilan keputusan berbasis bukti mulai dari pemetaan wilayah terdampak, estimasi populasi rentan, hingga identifikasi hambatan budaya dan logistik yang memengaruhi penerimaan bantuan pangan. Koordinasi lintas sector kesehatan, logistik, perlindungan, air, sanitasi dan kebersihan harus berjalan serempak agar intervensi gizi tidak terhambat oleh ketiadaan air bersih, tidak relevan dengan pola konsumsi lokal, atau tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas kepada penyintas menjadi landasan etik untuk memastikan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan dan dilakukan dengan cara yang menjaga martabat penerima.

Kecepatan respons harus disertai ketepatan sasaran. Di lapangan, keputusan mengenai jenis pangan yang didistribusikan, bentuk dukungan gizi khusus untuk anak balita dan ibu menyusui, maupun penanganan kasus gizi buruk tidak bisa bersandar pada asumsi atau pendekatan satu-ukuran-untuk-semua. Ketersediaan makanan siap saji yang aman dan bergizi, dukungan pemberian makan bayi dan anak dalam keadaan darurat (termasuk perlindungan menyusui), suplementasi mikronutrien yang tepat, serta tata laksana terpadu gizi buruk harus disesuaikan dengan konteks lokal dan fase bencana tanggap darurat, transisi, hingga pemulihan. Di saat yang sama, mekanisme umpan balik komunitas, komunikasi risiko yang jelas, dan pelibatan tokoh lokal membantu memastikan intervensi dapat diterima, dipahami, dan diadopsi dengan cepat oleh keluarga terdampak.

Kesiapsiagaan sebelum krisis menentukan kualitas respons ketika krisis datang. Investasi pada kapasitas komunitas pelatihan kader, penyusunan rencana kontinjensi gizi, pemetaan sumber daya pangan lokal, dan simulasi koordinasi antar-lembaga akan memperpendek waktu dari kejadian bencana ke penyaluran bantuan gizi yang efektif. Di tingkat layanan, protokol sederhana untuk skrining status gizi (misalnya pengukuran LILA dan penimbangan rutin), pencatatan minimal yang andal, dan jalur rujukan yang jelas memungkinkan tenaga lapangan bertindak cepat meskipun infrastruktur terdampak. Dengan demikian, pendahuluan bab ini menegaskan bahwa gizi dalam situasi darurat bukan isu sekunder, melainkan

komponen inti dari keseluruhan upaya penyelamatan jiwa dan pemulihan sebuah mandat untuk bergerak cepat, tepat, dan bersama.

B. Konsep Gizi dalam Situasi Darurat

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, "situasi darurat" merujuk pada kondisi luar biasa akibat bencana alam, konflik bersenjata, wabah penyakit menular, kegagalan ekonomi, atau kombinasi di antaranya yang mengganggu secara cepat dan luas fungsi sistem sosial, layanan kesehatan, serta rantai pasok pangan. Dari sudut pandang gizi, keadaan ini ditandai oleh meningkatnya risiko defisit energi dan zat gizi esensial, memburuknya status gizi kelompok rentan, serta melonjaknya morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan penyakit infeksi. Gangguan tersebut terjadi karena empat pilar ketahanan pangan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas tertekan secara simultan: produksi menurun, distribusi terputus, daya beli merosot, penyimpanan dan pengolahan terganggu, sementara air bersih dan sanitasi tidak memadai untuk menjamin keamanan pangan dan penyerapan gizi.

Jenis-jenis bencana yang paling berdampak terhadap ketahanan pangan dan gizi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, bencana geofisika seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api yang menghancurkan infrastruktur, merusak lahan pertanian, serta memutus akses ke layanan esensial termasuk pos gizi dan fasilitas kesehatan. Kedua, bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, siklon, dan tanah longsor yang mengurangi hasil panen, memicu kenaikan harga, dan meningkatkan paparan penyakit berbasis lingkungan (diare, ISPA) yang memperburuk penyerapan gizi. Ketiga, bencana biologis seperti pandemi yang membatasi mobilitas, mengurangi pendapatan rumah tangga, dan menurunkan kualitas serta kuantitas asupan pangan. Keempat, krisis sosial-politik seperti konflik dan pengungsian paksa yang memusatkan populasi di lokasi dengan kapasitas layanan terbatas, memicu ketergantungan pada bantuan, dan meningkatkan risiko gizi buruk akut. Di banyak konteks, bencana-bencana ini saling bertumpuk misalnya kekeringan yang berkepanjangan diikuti konflik memperebutkan sumber daya menciptakan krisis gizi berkepanjangan yang sulit dipulihkan tanpa pendekatan lintas sektor.

Penanganan gizi dalam situasi darurat bertumpu pada sejumlah prinsip dasar. Prinsip kemanusiaan menempatkan penyelamatan jiwa dan perlindungan martabat penyintas di atas segalanya, memastikan bahwa dukungan gizi diberikan cepat, aman, dan sesuai kebutuhan. Prinsip ketidakberpihakan dan keadilan menuntut penetapan prioritas berdasarkan tingkat kerentanan balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit kronis bukan berdasarkan identitas atau afiliasi. Prinsip berbasis bukti mengharuskan respons didahului penilaian cepat yang valid tentang status gizi, pola konsumsi, ketersediaan air dan

sanitasi, kebiasaan makan setempat, serta hambatan budaya yang memengaruhi penerimaan bantuan pangan. Prinsip kesesuaian kontekstual menegaskan pentingnya keselarasan jenis komoditas dan bentuk intervensi dengan pola diet lokal, kapasitas memasak, serta keamanan pangan (misalnya apakah ada bahan bakar dan air yang cukup). Akhirnya, prinsip koordinasi dan akuntabilitas mewajibkan sinkronisasi antar sector kesehatan, logistik, WASH (air, sanitasi, dan kebersihan), perlindungan, pendidikan, serta pertanian agar intervensi gizi tidak berjalan dalam silo dan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada komunitas penerima.

Dalam praktiknya, pendekatan gizi pada fase tanggap darurat dan fase pemulihan (recovery) memiliki fokus, tujuan, dan paket intervensi yang berbeda. Pada fase tanggap darurat biasanya minggu-minggu pertama setelah kejadian tujuan utama adalah menyelamatkan jiwa dan mencegah memburuknya status gizi. Kegiatan kunci meliputi penilaian cepat gizi dan keamanan pangan; skrining aktif balita menggunakan ukuran sederhana seperti MUAC dan penimbangan; tata laksana gizi buruk akut secara rawat jalan atau rawat inap; distribusi pangan darurat yang bergizi dan aman (termasuk ready-to-eat foods untuk konteks tanpa fasilitas memasak); suplementasi mikronutrien esensial; serta dukungan pemberian makan bayi dan anak dalam keadaan darurat (perlindungan menyusui, ruang laktasi aman, konseling laktasi, pencegahan dan tata kelola donasi susu formula yang tidak tepat). Intervensi gizi di fase ini harus terintegrasi erat dengan layanan WASH untuk memutus “lingkaran penyakit–malnutrisi,” dan dengan logistik agar rantai dingin serta pasokan komoditas gizi khusus tetap terjaga.

Memasuki fase pemulihan, orientasi bergeser dari tindakan penyelamatan jiwa menuju rekonstruksi kapasitas dan ketahanan sistem pangan–gizi lokal. Fokusnya adalah memulihkan layanan dasar (posyandu/pos gizi, puskesmas), memperkuat sistem rujukan dan pencatatan pelaporan gizi, serta melakukan transisi dari bantuan pangan umum ke mekanisme yang lebih berkelanjutan seperti bantuan tunai berbasis pasar lokal bila memungkinkan. Program pemulihan menekankan diversifikasi pangan rumah tangga, revitalisasi produksi dan distribusi pangan lokal, penguatan sanitasi lingkungan, dan edukasi gizi yang kontekstual. Di tahap ini, dukungan untuk ibu hamil dan menyusui berlanjut dalam bentuk paket layanan antenatal–postnatal terintegrasi, sementara anak-anak yang pulih dari gizi buruk dipantau pertumbuhannya agar tidak relaps. Pemulihan juga menjadi momentum untuk membangun kembali secara “lebih baik dan tangguh” melalui kebijakan perlindungan sosial adaptif, fortifikasi/ biofortifikasi yang relevan, serta penguatan kapasitas kader dan struktur kelembagaan desa agar respons pada krisis berikutnya lebih cepat dan tepat.

Perbedaan mendasar antara kedua fase bukan sekadar pada jenis intervensi, melainkan pada cara mengambil keputusan dan berkoordinasi. Fase tanggap

darurat menuntut kecepatan, kesederhanaan protokol, dan toleransi terhadap ketidakpastian data awal selama tetap menjunjung standar minimal layanan dan keselamatan. Fase pemulihan, sebaliknya, menuntut pendalaman analisis, partisipasi komunitas yang lebih luas, dan peralihan menuju mekanisme pembiayaan serta pasokan yang stabil. Di sepanjang spektrum ini, sistem surveilans gizi yang adaptif menggabungkan indikator input, proses, dan hasil menjadi “kompas” untuk mengarahkan transisi yang mulus dari bantuan darurat ke penguatan ketahanan komunitas.

Dengan kerangka konsep tersebut, gizi dalam situasi darurat dipahami bukan sebagai paket bantuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan. Ketika prinsip kemanusiaan, kontekstualitas, berbasis bukti, dan koordinasi diterapkan secara konsisten, intervensi gizi tidak hanya menyelamatkan jiwa pada fase akut, tetapi juga menyiapkan landasan bagi komunitas untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan menjadi lebih tahan terhadap guncangan di masa depan.

C. Dampak Bencana terhadap Status Gizi dan Ketahanan Pangan

Bencana baik geofisik, hidrometeorologis, biologis, maupun social mengguncang empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Pada tingkat hulu, kerusakan lahan, infrastruktur irigasi, gudang, dan jalur logistik menurunkan ketersediaan pangan. Rantai pasok yang terputus membuat komoditas pokok sulit masuk ke wilayah terdampak, sementara keterbatasan bahan bakar dan tenaga kerja memperlambat distribusi. Pada saat yang sama, daya beli rumah tangga melemah akibat hilangnya mata pencaharian, kenaikan harga, dan terganggunya pasar. Bahkan bila pangan masih ada, akses ekonomi menjadi penghalang utama. Di hilir, pemanfaatan (utilization) ikut terpuak: air bersih dan sanitasi yang rusak meningkatkan risiko kontaminasi, mengundang kejadian diare dan infeksi lain yang menurunkan penyerapan zat gizi. Ketidakpastian pasokan dan pendapatan menjadikan stabilitas konsumsi tergerus rumah tangga berhadapan dengan pola makan yang makin monoton, porsi yang dikurangi, dan frekuensi makan yang menurun.

Gangguan WASH (water, sanitation, and hygiene) menjadi katalis yang mempercepat penurunan status gizi. Ketika sumber air tercemar atau sarana sanitasi tidak berfungsi, prevalensi penyakit diare, ISPA, dan infeksi kulit meningkat. Penyakit-penyakit ini membentuk “lingkaran setan” dengan malnutrisi: infeksi mengurangi nafsu makan, mengganggu penyerapan zat gizi, dan meningkatkan kebutuhan metabolik; malnutrisi pada gilirannya melemahkan sistem imun sehingga infeksi lebih mudah terjadi dan lebih lama sembuh. Pada anak balita, siklus ini terlihat cepat melalui penurunan berat badan, edema pada gizi buruk akut, atau pertumbuhan yang terhambat. Pada ibu hamil, infeksi dan defisit gizi memperbesar

risiko anemia, kelahiran bayi berat lahir rendah, serta komplikasi perinatal. Pada lansia dan individu dengan penyakit kronis, gangguan asupan dan hidrasi memperburuk kondisi dasar seperti diabetes dan hipertensi, menambah beban layanan kesehatan yang juga sedang terguncang.

Keruntuhan atau menurunnya kapasitas pelayanan kesehatan memperparah situasi. Fasilitas yang rusak, tenaga kesehatan yang terdampak, serta terputusnya logistik vaksin, suplemen, dan komoditas gizi khusus membuat layanan rutin—penimbangan, imunisasi, konseling menyusui, tata laksana gizi buruk—tidak berjalan optimal. Ketiadaan ruang aman laktasi, tekanan psikososial, dan informasi yang simpang siur dapat menurunkan keberhasilan menyusui sehingga bayi lebih dini terpapar pangan pengganti yang mungkin tidak aman karena air dan peralatan tidak steril. Di sisi lain, persebaran bantuan pangan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal (misalnya komoditas sulit diolah tanpa bahan bakar atau air memadai) menimbulkan limbah sekaligus menurunkan asupan zat gizi esensial yang sebenarnya dibutuhkan.

Dari sisi hasil gizi, pola penurunan asupan dan peningkatan penyakit infeksi biasanya tampak melalui kenaikan kasus gizi buruk akut (*wasting*) pada fase-fase awal tanggap darurat. Jika krisis berlarut, dampak jangka menengah berupa *stunting* dapat meningkat akibat akumulasi kekurangan asupan berkualitas, peradangan kronis karena infeksi berulang, dan lingkungan tidak higienis. Di saat yang sama, defisiensi mikronutrien terutama zat besi, vitamin A, zinc, dan folat lebih sering muncul karena keranjang pangan bantuan dan belanja rumah tangga cenderung berpindah ke pangan murah berenergi tinggi namun miskin mikronutrien. Pada remaja dan dewasa, stres, tidur yang buruk, dan keterbatasan aktivitas fisik mengubah pola makan ke arah makanan ultra-proses bila tersedia, membuka peluang munculnya “triple burden” (kurang gizi, kelebihan gizi, dan defisiensi mikronutrien) di komunitas yang sama.

Ketahanan pangan rumah tangga pascabencana bersifat dinamis dan berlapis fase. Pada fase akut, strategi penanggulangan (*coping*) yang umum dilakukan adalah mengurangi porsi dan frekuensi makan, mengganti bahan pangan hewani dengan nabati yang lebih murah, atau meminjam uang dan pangan dari jejaring sosial. Bila situasi berkepanjangan, rumah tangga beralih ke strategi erosi: menjual aset produktif (alat kerja, ternak), menarik anak dari sekolah untuk membantu mencari nafkah, atau migrasi paksa. Strategi-strategi ini mungkin menjaga konsumsi jangka pendek, tetapi mengikis kapasitas produksi dan pendapatan masa depan sehingga memerangkap rumah tangga pada kerentanan kronis. Di sinilah rancangan bantuan menjadi krusial: bantuan pangan umum yang tepat sasaran dapat segera menutup defisit energi, sedangkan dukungan tunai bersyarat/tidak bersyarat (bila pasar lokal berfungsi) menjaga pilihan diet dan memulihkan martabat penerima. Pemulihan mata pencaharian seperti benih, alat pertanian, sarana pengolahan, atau

dukungan usaha mikro pangan mempercepat transisi dari ketergantungan bantuan ke swakelola.

Aspek gender, usia, dan disabilitas mewarnai dinamika pemenuhan gizi pascabencana. Perempuan sering memikul peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola pangan rumah tangga, namun aksesnya ke sumber daya dan keputusan belanja tidak selalu setara. Tanpa pendekatan sensitif gender, bantuan dapat tidak menjangkau pengasuh utama anak. Demikian pula, pengungsi internal, kelompok adat, atau komunitas terpencil menghadapi hambatan bahasa, dokumentasi, dan mobilitas yang membatasi akses ke bantuan gizi dan layanan kesehatan. Mengintegrasikan mekanisme umpan balik komunitas, memastikan informasi gizi tersampaikan dalam bahasa yang dipahami, dan menempatkan pos layanan dekat dengan titik hunian sementara akan meningkatkan keterjangkauan dan penerimaan intervensi.

Memulihkan ketahanan pangan setelah fase akut menuntut lebih dari sekadar melanjutkan distribusi bantuan. Diperlukan pemulihan layanan dasar gizi–kesehatan (posyandu/pos gizi, Puskesmas), penguatan WASH untuk memutus rantai penyakit, serta edukasi gizi yang menyesuaikan ketersediaan pangan lokal dan kapasitas memasak. Diversifikasi sumber pangan melalui kebun keluarga, pekarangan gizi, dan revitalisasi rantai pasok lokal membantu memperbaiki kualitas diet. Di tingkat sistem, perlindungan sosial adaptif yang dapat “mengembang–mengempis” saat krisis, kebijakan stabilisasi harga pangan pokok, serta kolaborasi lintas sektor dengan pertanian, koperasi, dan dunia usaha mempercepat pemulihan. Dengan memadukan intervensi segera yang melindungi status gizi dan strategi jangka menengah untuk memulihkan produksi, pendapatan, dan layanan, komunitas dapat bergerak dari kerentanan menuju ketangguhan menurunkan risiko gizi buruk saat ini sekaligus memperkecil dampak bencana pada krisis berikutnya.

D. Intervensi Gizi dalam Situasi Darurat

Intervensi gizi dalam situasi darurat diawali oleh penilaian cepat yang terstruktur terhadap status gizi dan kebutuhan pangan populasi terdampak. Tujuannya adalah menghasilkan gambaran awal yang cukup akurat untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat. Tim lapangan melakukan pengumpulan data minimal yang mencakup ukuran antropometri sederhana seperti MUAC, berat badan, dan tinggi badan pada anak balita, serta indikator ibu hamil dan menyusui. Informasi mengenai ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi, kapasitas memasak, rantai pasok pangan, dan harga komoditas lokal juga dicatat karena faktor ini menentukan bentuk dukungan yang paling tepat. Penilaian cepat yang baik selalu memadukan data kuantitatif dengan wawancara singkat kepada pengasuh anak,

tokoh masyarakat, dan penyedia layanan setempat untuk memahami hambatan budaya dan logistik yang dapat memengaruhi penerimaan bantuan.

Berdasarkan temuan penilaian, langkah berikutnya adalah merancang dan melaksanakan distribusi pangan serta suplementasi gizi darurat yang relevan dengan konteks. Pada fase paling awal, dukungan pangan siap saji yang aman dan mudah dikonsumsi sering diperlukan, terutama ketika air, bahan bakar, dan peralatan memasak terbatas. Begitu kondisi memungkinkan, paket bantuan dapat bertransisi ke komoditas pokok yang sesuai pola makan lokal agar keluarga tetap dapat menyiapkan makanan yang akrab dan bergizi. Suplementasi mikronutrien diberikan sesuai kebutuhan, misalnya vitamin A untuk anak, zat besi dan asam folat untuk ibu hamil, serta bubuk multimikronutrien bila kualitas diet menurun. Seluruh dukungan harus memperhatikan keamanan pangan dan potensi alergen, serta disertai pesan edukasi singkat tentang penyimpanan dan cara penyajian yang aman.

Manajemen gizi buruk merupakan komponen klinis yang berjalan paralel dengan distribusi pangan. Anak dengan gizi buruk akut tanpa komplikasi ditangani melalui layanan rawat jalan dengan makanan terapeutik siap pakai dan tindak lanjut ketat. Anak dengan komplikasi atau kondisi medis serius dirujuk ke perawatan rawat inap dengan protokol terapi yang mencakup stabilisasi, rehabilitasi, dan rencana pulang dengan pemantauan yang terjadwal. Dukungan untuk pemberian makan bayi dan anak sangat penting di seluruh fase, termasuk perlindungan menyusui, penyediaan ruang laktasi yang aman, dan konseling laktasi. Donasi susu formula harus diatur ketat agar tidak mengganggu praktik menyusui dan hanya digunakan berdasarkan penilaian kebutuhan yang jelas disertai jaminan air bersih dan sanitasi.

Keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi koordinasi yang rapi antar lembaga. Pemerintah daerah memimpin penetapan kebijakan, prioritas sasaran, dan integrasi data. Organisasi nonpemerintah mendukung pelaksanaan teknis, pengadaan, dan pendampingan di lapangan. Masyarakat dan kader lokal menjadi penghubung utama agar informasi tepat sasaran dan layanan mudah diakses, sekaligus berperan dalam pemantauan sederhana serta umpan balik. Koordinasi juga melibatkan sektor air, sanitasi, dan kebersihan, logistik, perlindungan, pendidikan, serta pertanian. Pertemuan rutin untuk berbagi data, menyepakati standar layanan, menghindari duplikasi, dan menutup celah layanan akan mempercepat perbaikan status gizi.

Seluruh rangkaian intervensi harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Efisiensi menuntut keputusan berbasis data dengan paket layanan yang sederhana namun berdampak, penetapan rantai pasok yang singkat, serta penggunaan modalitas bantuan yang paling hemat biaya tanpa mengurangi mutu. Keadilan memastikan bahwa prioritas diberikan pada kelompok paling rentan seperti balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan hambatan akses. Keberlanjutan mengarahkan

transisi bertahap dari bantuan pangan umum ke mekanisme yang memperkuat kemandirian rumah tangga, seperti bantuan tunai bila pasar lokal berfungsi, dukungan produksi pangan skala keluarga, dan pemulihan layanan gizi dasar. Dengan mengintegrasikan tiga prinsip tersebut, intervensi gizi darurat tidak hanya menutup defisit gizi pada fase akut, tetapi juga menyiapkan landasan pemulihan yang tangguh dan adil bagi komunitas terdampak.

E. Peran dan Pemberdayaan Komunitas dalam Ketahanan Gizi

Ketahanan gizi yang kuat berawal dari komunitas yang terlibat aktif dalam seluruh siklus penanggulangan krisis. Keterlibatan ini mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan hasil, serta pembelajaran bersama untuk memperbaiki respons pada kejadian berikutnya. Masyarakat adalah pemilik pengetahuan lokal tentang pola pangan, musim tanam, kebiasaan makan, dan jalur distribusi informal. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting untuk merancang intervensi yang sesuai konteks, mudah diterima, dan lebih cepat memberikan dampak. Ketika warga dilibatkan sejak tahap perencanaan, rasa memiliki meningkat, transparansi terjaga, dan akuntabilitas sosial terhadap penggunaan sumber daya publik menguat. Hasilnya adalah program gizi yang lebih tepat sasaran, hemat biaya, dan berkelanjutan.

Peran kader gizi dan kesehatan berada di garis terdepan. Mereka menjadi jembatan komunikasi antara layanan kesehatan dan rumah tangga, sekaligus motor penggerak perubahan perilaku. Pemberdayaan kader dimulai dari rekrutmen yang adil, pelatihan berbasis kompetensi, serta pembinaan yang konsisten. Materi pelatihan tidak hanya mencakup dasar gizi, pemberian makan bayi dan anak, serta penanganan awal gizi buruk, tetapi juga keterampilan komunikasi interpersonal, pengelolaan data sederhana, dan fasilitasi komunitas. Kader yang terlatih mampu melakukan skrining cepat, merujuk kasus dengan tepat, memimpin penyuluhan yang relevan, dan mengorganisir dukungan timbal balik antar keluarga. Dukungan non finansial seperti pengakuan publik, sertifikat, dan peluang pengembangan karier menumbuhkan motivasi kerja yang berkelanjutan. Ketika memungkinkan, insentif berbasis kinerja yang transparan membantu menjaga konsistensi layanan tanpa mengikis semangat kerelawanan.

Selain kader, kelompok masyarakat memegang peran penting dalam memperluas jangkauan dan kedalaman intervensi. Kelompok ibu balita, remaja, pemuda, kelompok tani, kelompok wanita tani, karang taruna, serta organisasi keagamaan dapat menjadi wadah edukasi gizi, pengelolaan kebun pangan pekarangan, dan koordinasi bantuan rumah tangga rentan. Forum ini mendorong praktik berbagi pangan, tabungan kelompok, serta dapur komunitas pada saat tanggap darurat. Pada fase pemulihan, kelompok masyarakat dapat mengelola lumbung pangan desa, bank benih, dan usaha mikro pengolahan pangan yang

menambah nilai gizi dan ekonomi. Kegiatan bersama meningkatkan solidaritas dan memperluas jejaring dukungan sosial yang terbukti penting saat pendapatan menurun atau harga pangan naik.

Jejaring lokal memperkuat kesiap siagaan dan mitigasi risiko. Pemerintah desa, puskesmas, posyandu, sekolah, kelompok tani, pelaku usaha lokal, dan organisasi kemanusiaan perlu duduk bersama dalam struktur koordinasi yang jelas. Rencana kontinjensi gizi tingkat desa menjadi dokumen operasional yang memetakan peran masing masing pihak, lokasi layanan, rute logistik, daftar keluarga berisiko, serta protokol aktivasi saat terjadi bencana. Latihan simulasi berkala membantu seluruh aktor memahami alur tugas dan menguji titik lemah, misalnya ketersediaan air bersih, rantai dingin komoditas gizi khusus, atau jalur rujukan kasus gizi buruk. Sistem peringatan dini berbasis komunitas dapat memanfaatkan indikator sederhana seperti perubahan harga pangan pokok, gagal panen lokal, meningkatnya diare, atau turunnya partisipasi posyandu. Informasi tersebut dilaporkan secara rutin untuk memicu tindakan pengamanan lebih awal.

Mitigasi risiko gizi membutuhkan kombinasi tindakan di hulu dan hilir. Di hulu, diversifikasi produksi pangan rumah tangga melalui kebun keluarga, kolam ikan kecil, atau ternak skala rumah tangga memperkuat kualitas diet sepanjang tahun. Di hilir, edukasi gizi yang kontekstual menekankan pemilihan menu seimbang dengan bahan lokal, cara penyimpanan yang aman, dan teknik memasak hemat bahan bakar. Akses air bersih, sanitasi, dan kebersihan pribadi harus berjalan beriringan dengan intervensi gizi untuk memutus siklus penyakit dan malnutrisi. Ketika pasar lokal tetap berfungsi, bantuan tunai dapat dipadukan dengan pendampingan belanja pangan bergizi. Pada saat yang sama, mekanisme perlindungan sosial adaptif seperti bantuan beras, subsidi pangan, atau voucher perlu diaktifkan dengan data terpadu yang diperbarui oleh kader dan pemerintah desa agar tepat sasaran dan tepat waktu.

Pemulihan pascabencana menuntut tata kelola yang inklusif dan sensitif terhadap gender, usia, serta disabilitas. Pengasuh utama anak, khususnya perempuan, harus dilibatkan dalam perancangan jenis bantuan, lokasi layanan, dan jadwal distribusi agar tidak menambah beban kerja domestik. Remaja dilibatkan sebagai duta gizi dan kebersihan di sekolah dan lingkungan sekitar. Lansia dan penyandang disabilitas perlu difasilitasi akses fisik ke pos layanan, termasuk penyediaan transportasi lokal bila dibutuhkan. Mekanisme umpan balik komunitas melalui kotak saran, nomor pengaduan, atau pertemuan warga berkala memastikan suara kelompok rentan didengar dan menjadi dasar perbaikan layanan. Transparansi daftar penerima bantuan dan kriteria penetapan sasaran menjaga kepercayaan publik serta mencegah konflik sosial.

Keberlanjutan pemberdayaan komunitas bergantung pada data yang sederhana namun bermutu. Pencatatan minimal oleh kader tentang kehadiran

posyandu, hasil skrining MUAC, kasus rujukan, dan pola distribusi bantuan memberikan gambaran cepat mengenai apa yang bekerja dan apa yang perlu diubah. Pertemuan refleksi bulanan di tingkat desa mendorong pembelajaran bersama. Ketika indikator peringatan dini menunjukkan penurunan ketahanan pangan rumah tangga, jejaring lokal dapat segera mengalihfungsikan dana darurat desa, mengaktifkan dapur komunitas, atau mengusulkan tambahan bantuan tunai sementara. Pendekatan ini memperpendek waktu respons dan menahan kemerosotan status gizi sebelum menjadi krisis.

F. Strategi Pembangunan Ketahanan Komunitas

Ketahanan komunitas terhadap gangguan gizi tidak terbentuk dalam hitungan hari. Ia lahir dari proses panjang yang menautkan penguatan sistem pangan, perbaikan perilaku konsumsi, tata kelola layanan kesehatan dan gizi, serta kebijakan daerah yang berpihak pada kerentanan. Strategi jangka panjang harus menempatkan keluarga sebagai aktor utama, komunitas sebagai arena kolaborasi, dan pemerintah daerah sebagai pengarah kebijakan serta penjaga kesinambungan pendanaan. Dengan kerangka tersebut, upaya pembangunan ketahanan komunitas menuntut pendekatan yang konsisten, adaptif, dan terukur dari waktu ke waktu.

Penguatan sistem pangan lokal menjadi pilar pertama. Sistem ini mencakup seluruh rangkaian dari produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi di tingkat desa dan kecamatan. Upaya penguatan dimulai dengan memastikan akses petani kecil pada input produksi seperti benih bermutu, pupuk yang tepat guna, alat pascapanen, serta pembiayaan mikro yang terjangkau. Perbaikan infrastruktur sederhana seperti jalan tani, gudang, dan fasilitas pengeringan mengurangi kehilangan pascapanen yang selama ini menjadi sumber inefisiensi. Kelembagaan ekonomi seperti koperasi pangan dan lumbung desa memperkuat posisi tawar produsen kecil, menstabilkan stok, dan memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Ketika shock terjadi, sistem pangan lokal yang kuat mampu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan dasar sehingga rumah tangga tidak segera mengorbankan kualitas dietnya.

Diversifikasi sumber pangan menjadi pilar kedua yang saling melengkapi. Ketergantungan pada satu atau dua komoditas pokok membuat komunitas rentan ketika harga bergejolak atau gagal panen melanda. Diversifikasi dilakukan di lahan, dapur, dan pasar. Di lahan, pekarangan gizi, kebun sekolah, kolam ikan kecil, dan ternak skala rumah tangga memperkaya pasokan pangan hewani dan nabati sepanjang musim. Di dapur, pengembangan resep berbasis bahan lokal mendorong konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, umbi, dan sumber protein yang lebih beragam. Di pasar, kemitraan dengan pelaku usaha lokal membuka akses pada produk segar serta olahan bernilai gizi tinggi dengan harga yang kompetitif.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas diet, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang memperkuat daya beli rumah tangga.

Edukasi gizi berkelanjutan menjadi pilar ketiga yang memastikan perubahan perilaku benar benar terjadi dan bertahan. Edukasi yang efektif harus relevan dengan konteks setempat, menggunakan bahasa yang dipahami, dan memanfaatkan saluran yang dipercaya komunitas. Kader dan tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang memadukan pengetahuan ilmiah dengan praktik harian keluarga. Kelas ibu, klub remaja, pembinaan menu sekolah, dan konseling menyusui menjadi wahana untuk menginternalisasi praktik gizi seimbang, keamanan pangan rumah tangga, dan kebiasaan higienis. Media sederhana seperti kartu menu musiman, papan harga pangan lokal, dan panduan belanja hemat gizi membantu keluarga membuat keputusan yang lebih baik meskipun anggaran terbatas. Keberlanjutan edukasi dijaga melalui pengulangan pesan, umpan balik dari warga, serta integrasi dengan kegiatan komunitas yang rutin.

Pilar keempat adalah integrasi program gizi ke dalam kebijakan tanggap bencana daerah. Ketahanan komunitas menuntut bahwa gizi tidak berdiri sendiri, melainkan hadir dalam rencana pembangunan jangka menengah, dokumen rencana kontinjensi bencana, serta mekanisme perlindungan sosial yang adaptif. Pemerintah daerah bersama puskesmas, dinas terkait, dan pemerintah desa menyusun peran dan alur kerja yang jelas saat krisis. Hal ini mencakup standar layanan gizi minimum, lokasi pos layanan, skema pembiayaan darurat, serta protokol aktivasi bantuan pangan atau bantuan tunai ketika indikator peringatan dini terpenuhi. Integrasi juga berarti data gizi menjadi bagian dari sistem informasi kebencanaan daerah sehingga keputusan penyaluran sumber daya didasarkan pada bukti, bukan semata persepsi. Dengan kebijakan yang berpihak, transisi dari bantuan darurat menuju pemulihan dapat berlangsung cepat tanpa jeda layanan yang berisiko bagi kelompok rentan.

Strategi pembangunan ketahanan tidak lepas dari tata kelola yang transparan dan akuntabel. Komite gizi desa atau forum pangan dan gizi di tingkat kecamatan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, layanan kesehatan, sekolah, kelompok tani, UMKM pangan, organisasi keagamaan, dan perwakilan kelompok rentan. Forum ini menyepakati target dan indikator yang dapat dilacak bersama, seperti keragaman konsumsi rumah tangga, ketersediaan komoditas kunci sepanjang musim, partisipasi posyandu, serta angka rujukan gizi buruk. Siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan refleksi dilakukan secara berkala agar strategi tetap adaptif terhadap perubahan cuaca, ekonomi lokal, maupun dinamika sosial.

G. Penutup

Bab ini menegaskan bahwa intervensi gizi darurat dan pembangunan ketahanan komunitas bukan dua agenda yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling memperkuat. Intervensi darurat melindungi nyawa dan mencegah kemunduran status gizi pada fase krisis, sementara ketahanan komunitas memastikan pemulihan yang cepat, mencegah relaps, serta mengurangi dampak krisis berikutnya. Keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlangsungan fungsi hidup, memelihara kualitas diet, dan memperkuat kapasitas lokal untuk menghadapi guncangan di masa depan.

Integrasi yang efektif dimulai dari perencanaan berbasis bukti dan sensitif konteks. Penilaian cepat yang akurat harus segera diikuti dengan intervensi yang selaras dengan pola pangan lokal, kapasitas memasak, dan kondisi WASH. Setelah fase akut terlewati, program beralih ke pemulihan yang memperbaiki layanan gizi dasar, memperkuat rantai pasok lokal, dan memperluas pilihan pangan bergizi melalui diversifikasi produksi serta edukasi gizi yang berkelanjutan. Transisi yang mulus ini hanya mungkin terjadi bila data lapangan dicatat secara sederhana tetapi andal, diulas secara berkala, dan menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi.

Ketangguhan masyarakat bertumpu pada aktor lokal yang berdaya. Kader, kelompok masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha kecil menjadi penggerak utama yang memastikan layanan menjangkau kelompok rentan, mulai dari balita, ibu hamil dan menyusui, hingga lansia dan penyandang disabilitas. Pemberdayaan mereka memerlukan pelatihan yang konsisten, pembinaan yang suportif, serta mekanisme umpan balik yang membuat warga merasa didengar. Ketika komunitas memegang peran dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan hasil, rasa memiliki tumbuh dan program lebih tahan lama.

Kolaborasi lintas sektor adalah syarat mutlak untuk menutup celah layanan. Sektor kesehatan, pertanian, sosial, pendidikan, WASH, logistik, dan dunia usaha perlu berbagi peta jalan yang sama, menggunakan indikator yang disepakati, serta menyelaraskan pembiayaan. Kebijakan daerah harus memasukkan gizi ke dalam rencana kontinjensi dan perlindungan sosial yang adaptif, sehingga bantuan dapat diaktifkan cepat ketika indikator peringatan dini terpenuhi. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, tumpang tindih program dapat dikurangi dan celah akses dapat ditangani lebih dini.

Akhirnya, investasi pada sistem pangan lokal, literasi gizi, dan kelembagaan komunitas akan menghasilkan manfaat ganda. Manfaat langsung terlihat pada penurunan kasus gizi buruk saat krisis. Manfaat jangka menengah dan panjang tampak pada meningkatnya keragaman pangan, perbaikan perilaku makan, dan layanan gizi yang lebih siap siaga. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan di bidang gizi: respons cepat yang menyelamatkan hari ini, dan penguatan kapasitas yang menjamin esok lebih tangguh. Dengan komitmen bersama dan kolaborasi

lintas sektor yang konsisten, masyarakat tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis gizi, tetapi juga tumbuh menjadi komunitas yang sehat, berdaya, dan adil bagi semua.

Referensi

- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum. Rome: FAO.
- FAO. (2015). The State of Food Insecurity in the World 2015: Meeting the 2015 international hunger targets. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2021). The State of Food and Agriculture 2021: Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Global Nutrition Cluster (GNC). (2020). Guidance on nutrition in emergencies coordination mechanisms. Geneva: GNC.
- IFE Core Group. (2017). Infant and Young Child Feeding in Emergencies: Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Programme Managers (Version 3). Oxford: IFE Core Group.
- IPC Global Partners. (2021). IPC Technical Manual Version 3.1: Evidence and standards for better food security and nutrition decisions. Rome: Integrated Food Security Phase Classification.
- MSF. (2020). Clinical guidelines: Diagnosis and treatment manual for curative programmes in hospitals and dispensaries. Geneva: Médecins Sans Frontières.
- Sphere Association. (2018). The Sphere Handbook: Humanitarian charter and minimum standards in humanitarian response. Geneva: Sphere Association.
- Sphere Association. (2023). Sphere Handbook 2023 edition: Humanitarian standards. Geneva: Sphere Association.
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (2023). Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2023 edition. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2020). Programming guidance for infant and young child feeding. New York: United Nations Children’s Fund.
- UNICEF. (2021). Community-based infant and young child feeding counselling package. New York: United Nations Children’s Fund.

- UNICEF. (2023). Guidance on cash plus for nutrition: Integrating cash transfers with nutrition services. New York: United Nations Children's Fund.
- WASH Cluster. (2018). WASH in emergencies technical working group field guide. Geneva: Global WASH Cluster.
- WFP. (2017). Emergency Food Security Assessment (EFSA) handbook (2nd ed.). Rome: World Food Programme.
- WFP. (2020). Fill the Nutrient Gap: A tool to inform nutrition-sensitive policies and programmes. Rome: World Food Programme.
- WHO. (2013). Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2017). Guideline: Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2020). Guidance for the prevention and control of outbreaks in camps and camp-like settings. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2023). Guideline on the prevention and management of wasting and nutritional oedema (acute malnutrition) in infants and children under 5 years. Geneva: World Health Organization.

PROFIL PENULIS



Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes. Lahir di Grobogan, 05 Maret 1970 Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu jenjang D3 pada program studi kebidanan Poltekkes Tasikmalaya tahun 2005, D4 program studi sarjana sains terapan kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun 2013. Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon sebagai Rektor sekaligus dosen mengampu mata kuliah Kespro & KB, KDPK, Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir. Penulis aktif dalam berbagai Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah, serta publikasi ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi Penulis dapat dihubungi melalui email: srinusfiroh052@gmail.com.
Motto : Menjadi manusia yang berguna untuk orang lain.



Dr. Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM Lahir di Kuningan, 15 September 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis D3 Kebidanan kemudian melanjutkan D4 Kebidanan, kemudian melanjutkan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat konsentrasi Promosi Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta kemudian melanjutkan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan dan Teknologi Pengembangan Media. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, seminar, melakukan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: risnanurlia@gmail.com



Yuni Retnowati, SST., Bdn., M.Keb. Tempat tanggal lahir Malang 10 Juni 1982, Dosen di Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan, Menyelesaikan Pendidikan S2 Kebidanan Universitas Padjajaran Bandung.



Zuraidah S.SKM., MKM. Profesi: Dosen D3 Prodi Keperawatan Palembang Poltekkes Kemenkes Palembang. Pendidikan: S2 Universitas Indonesia Pengalaman kerja: Dosen D3 Prodi Keperawatan Palembang Poltekkes Kemenkes Palembang sejak Tahun 2000 Keahlian / kompetensi: Promosi Kesehatan Prestasi / sertifikasi (jika ada): Aktif dalam mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi dan Scopus, Buku. Hak Cipta



Dr. Herta Masthalina, S. KM., M.PH. Peneliti dan pengajar pada Kemenkes Pottekkes Medan Jurusan Gizi. Lahir di Belawan 23 Agustus 1974. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Belawan. Kemudian pada tahun 1992- 1995 melanjutkan studi DIII Gizi di PAM (Pendidikan Ahli Madya Gizi) Lubuk Pakam, melanjutkan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga tahun 2001 - 2003 dan mengambil Magister of Public Health tahun 2008-2010 di Universitas Gadjah Mada dan lulus Doktor dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023. Penulis memulai karirnya sebagai asisten dosen di PAM Gizi Mataram tahun 1998, menjadi dosen pada Poltekkes Mataram tahun 2003-2014, dosen di Poltekkes Medan tahun 2014 sampai sekarang. Saat ini mengajar mata kuliah Penilaian Status Gizi, Epidemiologi Gizi, Program Pangan dan Gizi, Ekonomi Pangan dan Gizi serta Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi dan dipublikasi dalam jurnal internasional maupun nasional. Berperan serta dalam menyumbangkan pikiran dan kegiatan ilmiah dalam penurunan stunting di Sumatera Utara, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat dan Gizi

SINOPSIS

Buku referensi "Gizi Komunitas: Intervensi, Promosi Kesehatan, dan Ketahanan Pangan" membahas secara komprehensif peran gizi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Buku ini hadir di tengah tantangan gizi yang semakin kompleks mulai dari kekurangan dan kelebihan gizi, perubahan pola konsumsi, hingga ancaman krisis pangan akibat bencana, perubahan iklim, dan pandemi.

Isi buku mencakup konsep dasar perencanaan program gizi, strategi intervensi di masyarakat, serta pentingnya promosi kesehatan dan pemberdayaan kader dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi keluarga. Penulis juga menguraikan penanganan gizi dalam situasi darurat, pentingnya koordinasi lintas sektor, dan upaya membangun ketahanan komunitas melalui sistem pangan lokal yang tangguh, diversifikasi pangan, serta edukasi gizi berkelanjutan.

Buku ini ditulis dengan gaya ilmiah yang mudah dipahami dan aplikatif, menjadikannya relevan bagi mahasiswa, tenaga gizi, dosen, praktisi kesehatan, dan perencana program. Lebih dari sekadar referensi akademik, buku ini menjadi panduan praktis untuk membangun masyarakat yang sehat, mandiri, dan tangguh terhadap krisis gizi menuju ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Indonesia.



Buku referensi “Gizi Komunitas: Intervensi, Promosi Kesehatan, dan Ketahanan Pangan” membahas secara komprehensif peran gizi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Buku ini hadir di tengah tantangan gizi yang semakin kompleks mulai dari kekurangan dan kelebihan gizi, perubahan pola konsumsi, hingga ancaman krisis pangan akibat bencana, perubahan iklim, dan pandemi.

Isi buku mencakup konsep dasar perencanaan program gizi, strategi intervensi di masyarakat, serta pentingnya promosi kesehatan dan pemberdayaan kader dalam menjaga ketahanan pangan dan gizi keluarga. Penulis juga menguraikan penanganan gizi dalam situasi darurat, pentingnya koordinasi lintas sektor, dan upaya membangun ketahanan komunitas melalui sistem pangan lokal yang tangguh, diversifikasi pangan, serta edukasi gizi berkelanjutan.

Buku ini ditulis dengan gaya ilmiah yang mudah dipahami dan aplikatif, menjadikannya relevan bagi mahasiswa, tenaga gizi, dosen, praktisi kesehatan, dan perencana program. Lebih dari sekadar referensi akademik, buku ini menjadi panduan praktis untuk membangun masyarakat yang sehat, mandiri, dan tangguh terhadap krisis gizi menuju ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-86-4

